

Buku Ajar

KOMUNIKASI TERAPEUTIK KEPERAWATAN

Mukhoirotin • Habsyah Saparidah Agustina • Ria Tri Harini Dwi Rusiawati
Yuliana Dafroyati • Khusana Rahma • Afina Muharani Syaftriani
Nurhayati • Leni Wijaya

BUKU AJAR

KOMUNIKASI TERAPEUTIK KEPERAWATAN

Penulis:

Mukhoirotin, S.Kep., Ns., M.Kep.

Habsyah Saparidah Agustina, S.Kep., Ners., M.Kep.

Ria Tri Harini Dwi Rusiawati, S.ST., M.Pd.

Yuliana Dafroyati, S.Kep., Ns., M.Sc.

Khusana Rahma, S.Kep., M.Tr.Kep.

Afina Muharani Syaftriani, S.Kep., Ns., M.Kep.

Nurhayati, SKM., MPH.

Ns. Leni Wijaya, S.Kep., M.Kes.

BUKU AJAR KOMUNIKASI TERAPEUTIK KEPERAWATAN

Penulis: Mukhoirotin, S.Kep., Ns., M.Kep.
Habsyah Saparidah Agustina, S.Kep., Ners., M.Kep.
Ria Tri Harini Dwi Rusiawati, S.ST., M.Pd.
Yuliana Dafroyati, S.Kep., Ns., M.Sc.
Khusana Rahma, S.Kep., M.Tr.Kep.
Afina Muharani Syaftriani, S.Kep., Ns., M.Kep.
Nurhayati, SKM., MPH.
Ns. Leni Wijaya, S.Kep., M.Kes.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak : Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN : 978-623-10-9569-5

Cetakan Pertama : Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, buku ajar ini yang berjudul “Komunikasi Terapeutik Keperawatan” dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung proses pembelajaran mahasiswa keperawatan, serta sebagai referensi tambahan bagi dosen dan praktisi dalam memahami dan menerapkan komunikasi terapeutik secara efektif dan profesional dalam berbagai situasi klinis.

Dalam dunia keperawatan, komunikasi bukan sekadar alat untuk menyampaikan informasi, melainkan merupakan bagian integral dari proses asuhan keperawatan itu sendiri. Perawat tidak hanya dituntut untuk mampu menjalankan intervensi medis, tetapi juga harus memiliki keterampilan interpersonal yang mampu menjalin hubungan yang hangat, empatik, dan suportif dengan pasien dan keluarganya. Hubungan inilah yang menjadi inti dari komunikasi terapeutik.

Komunikasi terapeutik memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antara perawat dan pasien, membangun rasa saling percaya, serta membantu pasien dalam mengelola emosi, kecemasan, dan ketidaknyamanan yang mungkin mereka alami selama menjalani perawatan. Namun demikian, keterampilan komunikasi terapeutik tidak datang secara otomatis. Keterampilan ini harus dipelajari, dilatih, dan dikembangkan secara berkelanjutan agar perawat dapat memberikan pelayanan yang tidak hanya aman dan bermutu, tetapi juga penuh perhatian dan empati.

Buku ini disusun dengan mengacu pada kurikulum pendidikan tinggi keperawatan yang berlaku, serta memperhatikan perkembangan ilmu dan praktik keperawatan terkini. Isi buku mencakup pengertian dasar komunikasi terapeutik, prinsip-prinsip yang mendasarinya, tahapan-tahapan dalam proses komunikasi, hambatan yang mungkin terjadi dalam praktik, serta berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan studi kasus dan contoh aplikasi komunikasi terapeutik pada kelompok pasien dengan kebutuhan khusus, seperti anak-anak, lansia, pasien dengan gangguan mental, serta pasien dalam kondisi kritis.

Penulis berharap bahwa buku ini dapat menjadi salah satu sumber belajar yang aplikatif, relevan, dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Diharapkan pula buku ini mampu memperluas wawasan pembaca mengenai pentingnya pendekatan humanistik dalam praktik keperawatan, terutama dalam hal komunikasi yang efektif dan bermakna.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Terima kasih khusus disampaikan kepada para dosen, rekan sejawat, mahasiswa, dan tim akademik yang telah memberikan masukan, kritik, serta dukungan selama proses penulisan ini berlangsung. Tidak lupa penulis juga menghaturkan terima kasih kepada institusi tempat penulis mengabdikan yang telah memberikan kesempatan untuk terus berkarya dan berkontribusi di dunia pendidikan keperawatan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan edisi berikutnya. Besar harapan penulis, buku ini dapat memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi mahasiswa keperawatan, tetapi juga bagi para praktisi yang setiap hari berada di garis depan pelayanan kesehatan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi bagian dari upaya kita semua dalam mewujudkan praktik keperawatan yang lebih manusiawi, profesional, dan berpusat pada pasien. Semoga setiap ilmu yang disampaikan dalam buku ini menjadi amal jariyah yang terus mengalir manfaatnya bagi semua pihak yang terlibat.

Penulis

Mei, 2025

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 SELF AWARENESS (KESADARAN INTRAPERSONAL DALAM HUBUNGAN INTERPERSONAL)	1
A. Model Keperawatan Holistik Kesadaran Diri.....	19
B. Meningkatkan Kesadaran Diri	19
C. Perawat dan Pertumbuhan Diri	22
D. Latihan Soal	24
E. Rangkuman Materi	25
F. Glosarium.....	26
G. Daftar Pustaka.....	26
BAB 2 DIMENSI RESPON DAN TINDAKAN	28
A. Dimensi Respon	32
B. Dimensi Tindakan.....	36
C. Latihan Soal	39
D. Rangkuman Materi	41
E. Glosarium.....	41
F. Daftar Pustaka.....	42
BAB 3 HAMBATAN DALAM KOMUNIKASI TERAPEUTIK	44
A. Hambatan Verbal	45
B. Hambatan Non-Verbal.....	46
C. Hambatan Psikologis	46
D. Hambatan Budaya dan Sosial.....	47
E. Hambatan Lingkungan.....	48
F. Hambatan Teknologi	48
G. Latihan Soal	50
H. Rangkuman Materi	52
I. Glosarium.....	53
J. Daftar Pustaka.....	55

BAB 4 TAHAP – TAHAP DALAM KOMUNIKASI TERAPEUTIK	58
A. Komunikasi Terapeutik	59
B. Tujuan Komunikasi Terapeutik.....	59
C. Prinsip Komunikasi Terapeutik.....	60
D. Tahapan Komunikasi Terapeutik.....	62
E. Latihan Soal	70
F. Rangkuman Materi	72
G. Glosarium.....	73
H. Daftar Pustaka	73
 BAB 5 TEKNIK-TEKNIK KOMUNIKASI TERAPEUTIK.....	74
A. Pengertian Komunikasi Terapeutik	76
B. Tujuan Komunikasi Terapeutik.....	76
C. Prinsip Dasar Komunikasi Terapeutik.....	78
D. Teknik-Teknik Komunikasi Terapeutik	79
E. Aplikasi Komunikasi Terapeutik Dalam Berbagai Konteks	84
F. Latihan Soal	87
G. Rangkuman Materi	87
H. Glosarium.....	88
I. Daftar Pustaka.....	88
 BAB 6 KOMUNIKASI TERAPEUTIK PADA ANAK.....	90
A. Tujuan komunikasi terapeutik pada bayi dan anak.....	91
B. Perkembangan komunikasi pada Anak.....	91
C. Bentuk-bentuk Komunikasi pada anak.....	95
D. Teknik Komunikasi Terapeutik pada Anak	96
E. Latihan Soal	98
F. Rangkuman Materi	100
G. Glosarium.....	101
H. Daftar Pustaka.....	101
 BAB 7 KOMUNIKASI TERAPEUTIK PADA LANSIA	104
A. Suasana Komunikasi pada Orang Dewasa dan Lansia	107
B. Teknik Komunikasi pada Orang Dewasa dan Penerapannya	108
C. Karakteristik Lansia	108
D. Perkembangan Komunikasi Pada Lanjut Usia	110

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komunikasi Dengan Lansia	111
F. Hambatan Komunikasi Pada Lansia dan Cara Mengatasi.....	111
G. Pendekatan Komunikasi Terapeutik Pada Lanjut Usia	112
H. Komunikasi Terapeutik dengan Lansia yang Mengalami Masalah Fisik maupun Mental.....	113
I. Teknik Komunikasi dengan Lansia	116
J. Latihan Soal	117
K. Rangkuman Materi	126
L. Glosarium.....	128
M. Daftar Pustaka.....	128
PROFIL PENULIS	130

BAB 1

KONSEP KOMUNIKASI TERAPEUTIK

Tujuan Instruksional:

- Menjelaskan pengertian komunikasi terapeutik
- Menjelaskan tujuan komunikasi terapeutik
- Menjelaskan komponen komunikasi terapeutik
- Menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi terapeutik
- Menjelaskan teknik-teknik komunikasi terapeutik
- Menjelaskan hubungan terapeutik klien perawat

Capaian Pembelajaran:

- Mampu menjelaskan pengertian komunikasi terapeutik
- Mampu menjelaskan tujuan komunikasi terapeutik
- Mampu menjelaskan komponen komunikasi terapeutik
- Mampu menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi terapeutik
- Mampu menjelaskan teknik-teknik komunikasi terapeutik
- Mampu menjelaskan hubungan terapeutik klien perawat

Pendahuluan

Komunikasi terapeutik adalah elemen fundamental dalam praktik keperawatan yang berfokus pada interaksi antara perawat dan pasien dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pasien. Dalam konteks ini, komunikasi terapeutik melibatkan lebih dari sekadar pertukaran informasi medis tetapi juga mencakup pembentukan hubungan yang saling percaya dan mendukung antara perawat dan pasien. Hubungan ini sangat penting untuk memberikan kenyamanan emosional bagi pasien, membantu mereka mengatasi kecemasan, dan mempercepat proses penyembuhan.

Komunikasi terapeutik memungkinkan perawat untuk memahami lebih dalam mengenai kebutuhan fisik dan psikologis pasien. Komunikasi yang efektif dapat menurunkan tingkat kecemasan pasien, memberikan rasa aman, serta meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rencana perawatan yang diberikan. Sebagai contoh, perawat yang mampu mengkomunikasikan informasi medis dengan cara yang jelas

dan penuh empati akan membantu pasien memahami kondisi mereka dengan lebih baik, sehingga meningkatkan keterlibatan pasien dalam proses perawatan (Stuart, 2013)

Perawat juga berperan dalam mengelola komunikasi nonverbal, seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh, yang semuanya mempengaruhi cara pasien merasakan dan memahami pesan yang disampaikan. Hal ini sangat relevan, terutama dalam situasi di mana pasien mengalami kesulitan untuk mengungkapkan perasaan atau kekhawatiran mereka secara verbal. Dengan memanfaatkan keterampilan komunikasi terapeutik, perawat dapat menciptakan ruang bagi pasien untuk merasa dihargai dan dipahami, yang sangat mendukung proses pemulihan mereka.

A. Pengertian Komunikasi Terapeutik

Interaksi dengan individu yang mengalami gangguan jiwa memerlukan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar komunikasi yang tepat. Komunikasi terapeutik merupakan bentuk komunikasi khusus yang diterapkan dalam konteks kesehatan, yang bertujuan untuk mendukung serta secara efektif menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi Kesehatan (Bajo et al., 2025)

Komunikasi terapeutik adalah bentuk komunikasi yang digunakan dalam setting kesehatan untuk membangun hubungan yang mendukung penyembuhan fisik, emosional, dan psikologis pasien. Para ahli di bidang komunikasi dan kesehatan telah memberikan berbagai definisi dan perspektif mengenai komunikasi terapeutik. Berikut dibawah ini merupakan pengertian komunikasi terapeutik menurut beberapa ahli, yaitu:

1. Carl Rogers (1951) - Pendekatan *Person-Centered Therapy*

Carl Rogers adalah seorang psikolog humanistik, mengembangkan konsep komunikasi terapeutik dalam kerangka pendekatan *person-centered therapy*. Menurut Rogers, komunikasi terapeutik adalah hubungan yang dibangun atas dasar empati, penerimaan tanpa syarat, dan mendengarkan secara aktif. Rogers menekankan bahwa komunikasi terapeutik terjadi ketika seorang terapis (perawat atau tenaga medis) mendengarkan klien dengan penuh perhatian dan tanpa penilaian, untuk membantu klien memahami dan mengatasi perasaan klien (C. Rogers, 1995).

2. Hildegard Peplau (1952) - *Interpersonal Relations Theory*

Hildegard Peplau, seorang perawat teori, mengembangkan teori hubungan interpersonal yang mengidentifikasi komunikasi terapeutik sebagai proses di mana perawat dan pasien bekerja sama untuk mencapai pemahaman bersama dan memenuhi kebutuhan pasien. Menurut Peplau, komunikasi terapeutik melibatkan beberapa tahapan, termasuk orientasi, identifikasi, eksploitasi, dan resolusi. Dalam setiap tahap, komunikasi digunakan untuk membangun hubungan dan memperjelas peran masing-masing pihak (Agustina, 2023; Peplau, 1991).

3. *Therapeutic Use of Self* (Megan & Ziegler, 2012)

Menurut Megan dan Ziegler (2012), konsep *"therapeutic use of self"* mengacu pada penggunaan diri perawat sebagai alat dalam komunikasi terapeutik. Dalam hal ini, perawat harus bisa menyadari perasaan, reaksi, dan sikap pribadi mereka untuk memastikan bahwa komunikasi dengan pasien tetap

objektif dan efektif. Dalam komunikasi terapeutik, penggunaan diri ini melibatkan empati, kesabaran, dan keterbukaan terhadap pasien untuk menciptakan hubungan yang saling mendukung dan membantu pasien mengatasi permasalahan yang dihadapinya (Megan & Ziegler, 2012).

4. Theory of Communication Competence (Lazarus & Folkman, 1984)

Lazarus dan Folkman dalam teori komunikasi kompeten menjelaskan bahwa komunikasi terapeutik berfokus pada kualitas komunikasi yang terjadi antara perawat dan pasien. Kompetensi komunikasi melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi komunikasi yang berbeda, baik itu dalam berbicara, mendengarkan, atau memberikan umpan balik. Lazarus & Folkman menyatakan bahwa komunikasi terapeutik sangat bergantung pada keterampilan interpersonal perawat dalam membangun hubungan dengan pasien yang berdasarkan pada kepercayaan dan kenyamanan (Lazarus & Folkman, 1984).

5. Communication Theory by Shannon & Weaver (1949)

Dalam teori komunikasi klasik yang dikembangkan oleh Shannon dan Weaver, komunikasi terapeutik dapat dilihat sebagai proses pengiriman pesan dari satu pihak (perawat) ke pihak lain (pasien), dengan tujuan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dipahami dengan jelas oleh penerima. Meskipun ini adalah teori komunikasi umum, aplikasinya dalam konteks terapeutik menekankan pentingnya mengatasi gangguan atau hambatan komunikasi dan memastikan bahwa pesan perawatan yang penting diterima dengan jelas oleh pasien (Shannon & Weaver, 1949).

6. Kurt Lewin's Field Theory (1943) - Dynamic Communication

Kurt Lewin, seorang psikolog sosial, mengemukakan teori medan (*field theory*), yang menyatakan bahwa komunikasi terjadi dalam suatu konteks atau medan yang dinamis. Dalam konteks komunikasi terapeutik, ini berarti bahwa perawat harus memahami faktor-faktor eksternal (seperti lingkungan atau situasi sosial) yang dapat mempengaruhi komunikasi dengan pasien. Komunikasi terapeutik harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan ini untuk menciptakan hubungan yang mendukung dan efektif (Lewin, 1943).

7. Transactional Model of Communication (Barnlund, 1970)

Model komunikasi transaksional yang dikembangkan oleh Barnlund menyatakan bahwa komunikasi bukanlah proses linier tetapi lebih bersifat dua arah dan simultan. Dalam komunikasi terapeutik, model ini menggambarkan hubungan dinamis antara perawat dan pasien, di mana keduanya berkomunikasi secara terus-menerus dan mempengaruhi satu sama lain. Kedua pihak bertukar perasaan, pikiran, dan respons secara interaktif, sehingga menciptakan pemahaman yang lebih mendalam (Barnlund, 1970).

B. Tujuan Komunikasi Terapeutik

Tujuan dari komunikasi terapeutik mencakup: 1) Pengembangan dan penerimaan diri, serta peningkatan penghargaan terhadap diri sendiri; 2) Kemampuan untuk membangun hubungan interpersonal yang mendalam dan saling bergantung dengan individu lain; 3) Peningkatan fungsi dan kapasitas dalam memenuhi kebutuhan pasien serta mencapai tujuan yang realistis; 4) Pemeliharaan harga diri; dan 5) Terbentuknya hubungan saling percaya (Suryani, 2005)

Komunikasi terapeutik dapat berfungsi sebagai jembatan penghubung antara tenaga perawat sebagai pemberi layanan dan pasien sebagai penerima layanan. Komunikasi terapeutik mampu mengakomodasi pertimbangan status kesehatan yang dialami oleh pasien. Komunikasi ini memperhatikan pasien secara holistik, mencakup aspek kesejahteraan, menggali permasalahan yang dihadapi pasien, serta mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, komunikasi terapeutik juga mengajarkan cara-cara yang dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan marah dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa harus bersikap merusak atau agresif.

Tujuan komunikasi terapeutik adalah untuk membangun hubungan yang efektif dan mendukung antara profesional kesehatan (misalnya, perawat, dokter, atau psikolog) dan pasien, dengan tujuan utama meningkatkan kesehatan fisik dan mental pasien. Komunikasi terapeutik dirancang untuk mendukung proses penyembuhan melalui interaksi yang mendalam, empatik, dan saling percaya.

1. Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Pasien: Komunikasi terapeutik bertujuan untuk memberikan dukungan emosional kepada pasien, membantu mereka merasa dihargai, didengar, dan dipahami. Hal ini bisa mengurangi kecemasan dan stres, serta meningkatkan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan Kesehatan klien
2. Membantu Pasien Mengungkapkan Perasaan dan Pengalaman: Dengan mendengarkan secara aktif dan penuh empati, komunikasi terapeutik memungkinkan pasien untuk berbagi perasaan dan pengalaman mereka. Ini penting dalam membantu mereka memahami dan memproses emosi terkait kondisi kesehatan mereka, baik fisik maupun psikologis
3. Memfasilitasi Proses Penyembuhan: Komunikasi terapeutik berperan dalam mempercepat proses penyembuhan, baik secara fisik maupun mental. Melalui dukungan emosional dan informasi yang tepat, pasien dapat lebih memahami kondisi mereka dan menerima perawatan yang diperlukan
4. Meningkatkan Keterampilan adaptasi terhadap penyakit atau kondisi medis: dalam komunikasi terapeutik, tujuan lainnya adalah untuk mengedukasi pasien mengenai kondisi kesehatan mereka dan bagaimana cara terbaik untuk

menghadapinya. Ini membantu pasien beradaptasi dengan penyakit atau kondisi medis mereka, serta memotivasi mereka untuk mengubah perilaku atau kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup mereka

5. **Membangun Hubungan Terpercaya:** Salah satu tujuan utama dari komunikasi terapeutik adalah membangun hubungan yang saling percaya antara pasien dan tenaga kesehatan. Kepercayaan yang kuat ini penting untuk keberhasilan terapi atau perawatan yang diberikan, karena pasien lebih cenderung mengikuti rekomendasi perawatan jika mereka merasa didukung dan dipahami).

Tujuan komunikasi terapeutik sangat bergantung pada membangun hubungan yang mendalam, empatik, dan mendukung bagi pasien, dengan harapan untuk memfasilitasi penyembuhan fisik dan psikologis secara lebih efektif.

C. Komponen Komunikasi Terapeutik

Komunikasi terapeutik merupakan suatu bentuk komunikasi yang digunakan dalam konteks terapi atau pengobatan untuk membantu pasien dalam proses penyembuhan fisik dan mental. Komunikasi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk menciptakan hubungan yang saling menghargai dan mendukung antara tenaga kesehatan dan pasien. Beberapa komponen penting dalam komunikasi terapeutik (Beauchamp & Childress, 2013; Gergen et al., 2016; Hargie & David, 2011; C. R. Rogers, 1961; Watson, 2008) adalah:

1. Mendengarkan Aktif (*Active Listening*)

Mendengarkan secara aktif adalah salah satu komponen utama dalam komunikasi terapeutik. Ini melibatkan perhatian penuh terhadap apa yang disampaikan oleh pasien, bukan hanya mendengar kata-kata mereka tetapi juga mencoba memahami makna di balik kata-kata tersebut. Mendengarkan aktif mencakup penggunaan bahasa tubuh yang mendukung, seperti kontak mata, anggukan kepala, dan ekspresi wajah yang empatik.

2. Empati (*Empathy*)

Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain tanpa menghakimi. Dalam komunikasi terapeutik, empati membantu tenaga kesehatan memahami keadaan emosional pasien, yang dapat meningkatkan hubungan kepercayaan dan kenyamanan. Empati juga membantu pasien merasa dihargai dan didengarkan.

3. Kejelasan (*Clarity*)

Kejelasan dalam komunikasi sangat penting untuk menghindari kebingungannya pasien. Petunjuk atau informasi yang diberikan kepada pasien harus jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Hal ini mencakup penggunaan bahasa yang sederhana dan menghindari penggunaan jargon medis yang rumit.

4. Konfirmasi (*Validation*)

Konfirmasi adalah suatu bentuk pengakuan terhadap perasaan atau pendapat pasien yang disampaikan. Dengan mengonfirmasi, tenaga kesehatan menunjukkan bahwa mereka memperhatikan dan menghargai pengalaman atau perasaan pasien. Ini dapat membangun rasa aman dan meningkatkan keterbukaan pasien.

5. Pertanyaan Terbuka (*Open-Ended Questions*)

Pertanyaan terbuka memungkinkan pasien untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka lebih bebas dan lebih mendalam. Ini juga memungkinkan terjadinya diskusi lebih lanjut yang dapat memperjelas masalah yang sedang dihadapi pasien.

6. Kesabaran (*Patience*)

Kesabaran dalam komunikasi terapeutik penting untuk memberi waktu kepada pasien untuk berpikir dan berbicara tanpa merasa terburu-buru. Ini menciptakan ruang yang aman bagi pasien untuk berbagi perasaan atau kekhawatiran mereka secara lebih terbuka.

7. Penghormatan terhadap Privasi (*Respect for Privacy*)

Kepercayaan antara pasien dan tenaga kesehatan sangat bergantung pada penghormatan terhadap privasi pasien. Ini berarti menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh pasien dan menciptakan ruang yang nyaman untuk berbicara tanpa ada rasa takut atau cemas.

D. Prinsip-Prinsip Komunikasi Terapeutik

Komunikasi terapeutik memiliki prinsip-prinsip yang penting untuk menciptakan hubungan yang efektif dan mendukung proses penyembuhan pasien. Prinsip-prinsip ini membantu membangun kepercayaan, memberikan kenyamanan, dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik antara tenaga kesehatan dan pasien. Berikut adalah prinsip-prinsip komunikasi terapeutik (Beauchamp & Childress, 2013; Gergen et al., 2016; Hargie & David, 2011; Suryani, 2005; Watson, 2008), yaitu

1. Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan adalah dasar dari komunikasi terapeutik. Pasien harus merasa bahwa mereka dapat mempercayai tenaga kesehatan untuk mendengarkan, menghargai, dan menjaga kerahasiaan informasi mereka. Kepercayaan ini memungkinkan pasien untuk terbuka dan berbagi perasaan atau masalah yang mereka hadapi.

2. Empati (*Empathy*)

Empati dalam komunikasi terapeutik melibatkan pemahaman dan merasakan perasaan pasien tanpa menghakimi. Ini memungkinkan tenaga

kesehatan untuk menyelami pengalaman pasien dengan cara yang mendalam, yang dapat meningkatkan kualitas hubungan terapeutik dan membuat pasien merasa dihargai. Sehingga, perawat dapat membantu masalah pasien sesuai kebutuhannya.

3. Non-Judgmental Attitude (Sikap Tidak Menghakimi)

Sikap tidak menghakimi berarti tenaga kesehatan menerima pasien apa adanya tanpa memberikan penilaian terhadap perilaku, perasaan, atau masalah yang mereka alami. Hal ini menciptakan ruang yang aman bagi pasien untuk berbicara tanpa takut dihakimi.

4. Kejelasan (*Clarity*)

Kejelasan adalah prinsip yang memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada pasien mudah dipahami. Ini mencakup penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas, serta menjelaskan informasi yang mungkin sulit bagi pasien untuk dimengerti, seperti istilah medis.

5. Kerjasama (*Collaboration*)

Kerjasama dalam komunikasi terapeutik berarti tenaga kesehatan dan pasien bekerja bersama untuk mencapai tujuan kesehatan yang diinginkan. Ini termasuk melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan mereka dan menghargai input pasien.

6. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan adalah prinsip yang memastikan bahwa segala informasi yang dibagikan oleh pasien tetap dilindungi. Pasien harus merasa aman bahwa apa yang mereka bagikan tidak akan tersebar kepada pihak lain tanpa izin mereka, kecuali dalam situasi yang sangat terbatas.

7. Penerimaan (*Acceptance*)

Penerimaan dalam komunikasi terapeutik berarti bahwa tenaga kesehatan menerima pasien tanpa syarat. Ini berarti menghargai pasien sebagai individu yang unik dan memperlakukan mereka dengan rasa hormat, meskipun mungkin ada perbedaan dalam pandangan atau nilai-nilai yang dimiliki.

8. Fokus pada Pasien (*Patient-Centered Focus*)

Komunikasi terapeutik harus berfokus pada kebutuhan, perasaan, dan perspektif pasien. Tenaga kesehatan harus memberi perhatian penuh pada pasien dan memastikan bahwa komunikasi tersebut relevan dengan pengalaman atau kekhawatiran pasien.

9. Kesabaran (*Patience*)

Kesabaran adalah prinsip yang memungkinkan tenaga kesehatan memberikan waktu yang cukup kepada pasien untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka tanpa terburu-buru. Kesabaran juga memungkinkan tenaga

kesehatan untuk menangani situasi yang mungkin sulit atau emosional dengan ketenangan.

10. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan melibatkan komunikasi yang jujur dan transparan antara tenaga kesehatan dan pasien. Ini juga mencakup kesiapan untuk menerima umpan balik dari pasien mengenai perawatan yang mereka terima dan menunjukkan bahwa tenaga kesehatan siap untuk bekerja dengan pasien untuk meningkatkan hasil kesehatan.

E. Teknik-Teknik Komunikasi Terapeutik

Dalam komunikasi terapeutik, teknik-teknik yang digunakan bertujuan untuk membantu pasien merasa dihargai, dipahami, dan diberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyembuhan mereka. Berikut adalah beberapa teknik komunikasi terapeutik, yaitu:

1. Mendengarkan Aktif (*Active Listening*)

Mendengarkan aktif adalah teknik yang melibatkan perhatian penuh terhadap apa yang dikatakan oleh pasien. Ini bukan hanya mendengarkan kata-kata mereka tetapi juga memperhatikan nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Teknik ini sangat penting untuk memahami perasaan dan kebutuhan pasien secara mendalam.

2. Refleksi (*Reflection*)

Refleksi adalah teknik yang digunakan untuk mengulang kembali kata-kata atau perasaan pasien dengan cara yang lebih sederhana atau dengan pertanyaan klarifikasi. Teknik ini membantu pasien merasa dipahami dan mendorong mereka untuk mengeksplorasi perasaan atau pikiran mereka lebih dalam.

3. Mengajukan Pertanyaan Terbuka (*Open-Ended Questions*)

Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang memungkinkan pasien untuk mengungkapkan lebih banyak informasi tanpa merasa terjebak dalam jawaban singkat atau terbatas. Teknik ini mendorong pasien untuk berbicara lebih banyak tentang perasaan dan pengalaman mereka.

4. Penggunaan Klarifikasi (*Clarification*)

Klarifikasi adalah teknik yang digunakan untuk meminta penjelasan lebih lanjut atau memperjelas apa yang telah dikatakan pasien. Ini penting untuk menghindari kebingungannya dan memastikan bahwa tenaga kesehatan memahami dengan benar apa yang dimaksudkan oleh pasien.

5. Memberikan Umpan Balik Positif (*Providing Positive Feedback*)

Memberikan umpan balik positif adalah teknik untuk mengakui perasaan atau pencapaian pasien, serta memberikan dorongan yang konstruktif. Teknik ini meningkatkan rasa percaya diri pasien dan memperkuat hubungan terapeutik.

6. Penggunaan Parafernal (*Paraphrasing*)

Parafernal adalah teknik untuk menyampaikan kembali pesan pasien dengan kata-kata yang berbeda tetapi tetap mempertahankan makna aslinya. Teknik ini membantu memastikan bahwa pesan yang diterima benar dan memberikan kesempatan bagi pasien untuk mengoreksi jika ada kesalahpahaman.

7. Menggunakan Persuasi (*Persuasion*)

Persuasi dalam komunikasi terapeutik digunakan untuk memberikan informasi atau motivasi kepada pasien, sehingga mereka dapat melihat suatu masalah atau pilihan dari perspektif yang berbeda. Ini penting dalam memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pengobatan atau langkah-langkah yang harus diambil untuk proses penyembuhan.

8. *Silence* (Diam)

Diam atau memberikan jeda dalam komunikasi terapeutik merupakan teknik yang memungkinkan pasien untuk merenung, berpikir, dan mengungkapkan perasaan mereka lebih dalam. Keheningan ini memberikan waktu bagi pasien untuk merespons atau memproses informasi sebelum melanjutkan percakapan.

9. Menggunakan Humor

Humor dapat digunakan dengan hati-hati untuk meredakan ketegangan atau kecemasan pasien, tetapi harus dilakukan dengan cara yang sensitif dan sesuai dengan situasi. Humor yang baik dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dan mengurangi kecemasan pasien.

10. Empati Terbalik (*Empathic Confrontation*)

Empati terbalik adalah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan ketidaksesuaian atau ketegangan antara apa yang dikatakan pasien dan apa yang terlihat dalam perilaku atau perasaan mereka. Teknik ini dilakukan dengan penuh empati untuk membantu pasien menyadari perasaan yang mungkin belum mereka akui.

Teknik-teknik ini adalah kunci untuk menciptakan komunikasi yang efektif dalam konteks terapeutik, yang dapat mendukung pasien dalam proses penyembuhan dan meningkatkan kualitas interaksi antara pasien dan tenaga kesehatan.

F. Hubungan Terapeutik Klien Perawat

Komunikasi yang efektif antara perawat akan meningkatkan citra profesionalisme perawat tersebut. Sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif dapat berdampak negatif pada persepsi klien terhadap perawat. Dalam konteks komunikasi terapeutik, terdapat beberapa karakteristik yang diperlukan dari seorang perawat untuk menyelesaikan masalah dan membangun hubungan terapeutik yang efektif. Karakteristik tersebut meliputi kejujuran (*trustworthy*), kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan ekspresif dan positif agar pasien merasa dihargai, serta sikap empati yang lebih daripada simpati. Selain itu, perawat diharapkan mampu melihat permasalahan pasien dari perspektif pasien, sensitif terhadap perasaan pasien, dan tidak terpengaruh oleh latar belakang klien atau pengalaman pribadi perawat.

Perawat yang memiliki keahlian di bidangnya akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, terutama jika hubungan yang terjalin memiliki dampak terapeutik yang mendukung proses kesembuhan pasien. Oleh karena itu, perawat diharuskan untuk terus meningkatkan keahlian dan pengetahuan mereka mengenai dinamika komunikasi terapeutik, serta memiliki pemahaman yang baik mengenai kelebihan dan kelemahan diri, serta sensitivitas terhadap kebutuhan orang lain.

Perawat yang terampil dalam komunikasi terapeutik akan lebih mudah membangun hubungan saling percaya dengan pasien, mencegah terjadinya pelanggaran kode etik, dan memperkuat pandangan positif terhadap profesi keperawatan. Keterbukaan, pemahaman, dan kepekaan terhadap kebutuhan, keinginan, serta tugas semua pihak merupakan dasar penting dalam membangun hubungan saling percaya. Komunikasi terapeutik yang efektif dapat memperkuat hubungan terapeutik antara perawat dan pasien, yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Keberhasilan hubungan terapeutik terlihat dari kemampuan perawat dalam melaksanakan komunikasi terapeutik yang efektif selama asuhan keperawatan. Sebaliknya, kegagalan hubungan terapeutik sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan perawat dalam melaksanakan komunikasi terapeutik, serta kurangnya komunikasi interpersonal yang efektif antara perawat dan pasien. Hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan komunikasi terapeutik, yang pada akhirnya dapat menghambat proses penyembuhan pasien.

Hubungan terapeutik antara klien dan perawat sangat penting dalam dunia kesehatan karena membentuk dasar dari interaksi yang efektif, membantu klien

merasa dihargai, aman, dan terlibat dalam proses penyembuhan. Hubungan ini berfokus pada pengembangan kepercayaan, rasa hormat, dan empati, yang memungkinkan perawat untuk memberikan perawatan yang holistik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan klien.

1. Kepercayaan dan Rasa Aman

Kepercayaan adalah fondasi utama dari hubungan terapeutik antara perawat dan klien. Ketika klien merasa percaya pada perawat, mereka cenderung lebih terbuka untuk berbagi perasaan, kekhawatiran, atau informasi penting lainnya. Hal ini sangat penting dalam memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan klien dan bahwa klien merasa dihargai.

2. Empati dalam Hubungan Terapeutik

Empati memainkan peran penting dalam hubungan terapeutik antara perawat dan klien. Dengan merasakan dan memahami perasaan klien tanpa menghakimi, perawat dapat menciptakan hubungan yang mendalam dan penuh perhatian. Empati ini memungkinkan perawat untuk memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan oleh klien, yang tidak hanya bermanfaat bagi kesejahteraan mental tetapi juga mempercepat pemulihan fisik.

3. Kolaborasi dan Keterlibatan Pasien

Hubungan terapeutik yang efektif melibatkan kolaborasi antara perawat dan klien dalam merencanakan dan mengelola perawatan. Klien harus merasa menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan tentang perawatan mereka. Dengan demikian, klien merasa diberdayakan dan lebih bertanggung jawab terhadap kesehatannya.

4. Komunikasi Terbuka dan Jelas

Komunikasi yang jujur dan terbuka antara perawat dan klien adalah kunci untuk memastikan pemahaman yang baik. Perawat harus mampu memberikan informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh klien, sementara klien harus merasa bebas untuk mengungkapkan kekhawatiran atau perasaan mereka tanpa rasa takut akan penilaian.

5. Penghormatan terhadap Autonomi Klien

Dalam hubungan terapeutik, perawat harus menghormati hak klien untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka sendiri. Ini berarti bahwa perawat harus menyediakan informasi yang diperlukan untuk memungkinkan klien membuat pilihan yang informasional, serta mendukung keputusan yang dibuat oleh klien, bahkan jika keputusan tersebut berbeda dengan rekomendasi medis.

6. Membangun Rasa Percaya Diri pada Klien

Hubungan terapeutik yang kuat juga dapat meningkatkan rasa percaya diri klien dalam menghadapi masalah kesehatan mereka. Perawat yang mendukung dan menghargai kemampuan klien untuk membuat keputusan dapat memperkuat ketahanan emosional mereka, yang pada gilirannya dapat mendukung proses pemulihan.

7. Dukungan Emosional dan Psikologis

Perawat juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional kepada klien, terutama ketika mereka mengalami stres, kecemasan, atau trauma. Kehadiran yang penuh perhatian dan empatik dari perawat dapat membantu klien merasa diterima dan dihargai, yang sangat penting dalam proses penyembuhan yang menyeluruh.

8. Penerimaan dan Tidak Menghakimi

Perawat harus menunjukkan penerimaan tanpa syarat terhadap klien, terutama dalam kasus di mana klien mungkin merasa cemas atau malu untuk berbicara tentang masalah mereka. Sikap tidak menghakimi ini sangat penting dalam membangun hubungan terapeutik yang mendalam, memungkinkan klien merasa aman untuk mengungkapkan perasaan atau kesulitan mereka.

G. Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan komunikasi terapeutik menurut Carl Rogers?
 - A. Komunikasi yang berfokus pada penerimaan tanpa syarat dan mendengarkan secara aktif
 - B. Komunikasi yang melibatkan pengiriman pesan dari satu pihak ke pihak lain
 - C. Komunikasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan umpan balik dari pasien
 - D. Komunikasi yang terjadi antara dua pihak dalam situasi formal dan profesional
 - E. Komunikasi yang mengutamakan hasil penyembuhan fisik pasien
2. Menurut Hildegard Peplau, apa yang menjadi salah satu tahap dalam komunikasi terapeutik?
 - A. Orientasi
 - B. Refleksi
 - C. Penghargaan
 - D. Klarifikasi
 - E. Pertanyaan terbuka

3. Apa tujuan utama dari komunikasi terapeutik dalam konteks penyembuhan?
 - A. Meningkatkan keterampilan fisik pasien
 - B. Meningkatkan hubungan emosional pasien dan keluarga
 - C. Meningkatkan kesehatan fisik dan mental pasien
 - D. Meningkatkan kemampuan teknis perawat
 - E. Menyembuhkan penyakit fisik pasien

4. Apa prinsip dasar yang membentuk hubungan terapeutik yang efektif antara perawat dan pasien?
 - A. Kepercayaan
 - B. Kepastian
 - C. Persaingan
 - D. Otoritas
 - E. Standar

5. Apa yang dimaksud dengan teknik mendengarkan aktif dalam komunikasi terapeutik?
 - A. Mengabaikan perasaan pasien untuk memberikan ruang bagi perawat
 - B. Mendengarkan kata-kata pasien tanpa merespon
 - C. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan mencoba memahami makna di balik kata-kata pasien
 - D. Menjawab pertanyaan pasien dengan cepat tanpa mempertimbangkan perasaan mereka
 - E. Hanya menunggu giliran untuk berbicara tanpa memperhatikan perasaan pasien

Kunci Jawaban

1. A
2. C
3. C
4. A
5. C

H. Rangkuman Materi

Komunikasi terapeutik adalah jenis komunikasi yang diterapkan dalam konteks kesehatan untuk membangun hubungan yang mendukung penyembuhan fisik, emosional, dan psikologis pasien. Tujuan utama dari komunikasi terapeutik adalah untuk membantu pasien mengatasi permasalahan kesehatan melalui interaksi yang empatik dan saling percaya. Terdapat berbagai pandangan dari para ahli terkait konsep komunikasi terapeutik.

Carl Rogers (1951) menyatakan bahwa komunikasi terapeutik didasarkan pada empati, penerimaan tanpa syarat, dan mendengarkan aktif, yang bertujuan untuk membantu pasien memahami dan mengatasi perasaan mereka. Hildegard Peplau (1952) mengembangkan teori hubungan interpersonal, menekankan pentingnya tahapan komunikasi yang membantu perawat dan pasien bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pasien. Konsep "*therapeutic use of self*" yang dikemukakan oleh Megan & Ziegler (2012) mengharuskan perawat untuk menggunakan empati, kesabaran, dan keterbukaan diri mereka dalam komunikasi dengan pasien.

Komunikasi terapeutik juga dipengaruhi oleh teori-teori lainnya, seperti teori komunikasi kompeten dari Lazarus & Folkman (1984), yang menekankan kemampuan beradaptasi dalam komunikasi yang efektif antara perawat dan pasien. Model komunikasi transaksional (Barnlund, 1970) menggambarkan hubungan dinamis yang terjadi antara perawat dan pasien dalam komunikasi yang berlangsung secara dua arah dan simultan.

Tujuan komunikasi terapeutik mencakup pengembangan penerimaan diri, pembentukan hubungan interpersonal yang mendalam, peningkatan fungsi untuk memenuhi kebutuhan pasien, pemeliharaan harga diri, serta membangun hubungan saling percaya. Komunikasi terapeutik juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis pasien, membantu pasien mengungkapkan perasaan, mempercepat proses penyembuhan, meningkatkan keterampilan adaptasi terhadap kondisi medis, dan memperkuat hubungan kepercayaan antara pasien dan tenaga kesehatan.

Komponen penting dalam komunikasi terapeutik meliputi mendengarkan aktif, empati, kejelasan, konfirmasi, dan kesabaran. Selain itu, prinsip-prinsip komunikasi terapeutik seperti kepercayaan, empati, sikap tidak menghakimi, dan penghormatan terhadap privasi pasien juga sangat penting. Teknik-teknik seperti refleksi, pertanyaan terbuka, serta penggunaan humor dapat memperkuat komunikasi terapeutik.

Dalam hubungan terapeutik antara perawat dan pasien, aspek penting adalah kepercayaan, empati, kolaborasi, komunikasi terbuka, penghormatan terhadap

otonomi pasien, dan dukungan emosional, yang ke semuanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses penyembuhan pasien.

I. Daftar Pustaka

- Agustina, H. S. (2023). Teori Keperawatan Terpilih: Hildegard Peplau. In Buku Ajar Falsafah dan Teori Keperawatan (1st ed., Vol. 1, pp. 77–91). CV. Eureka Media Aksara.
- Bajo, A., Bataona, M. R, & Hendrikus, S. B. (2025). Model komunikasi terapeutik psikoanalisis dan interpersonal perawat dengan pasien gangguan jiwa. *Jurnal Deliberatio: Jurnal Mahasiswa Komunikasi*, 5(1), 34–50.
- Barnlund, D. C. (1970). A transactional model of communication. In *Communication Theory: A Reader*. Thomas S. Larkin.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2013). *Principles of biomedical ethics*. Oxford University Press.
- Gergen, K. J., McCool, D. M., & Lunt, S. (2016). Communication and the health professions: A study in clarity. *Health Communication Journal*, 31(4), 345–359.
- Hargie, O., & David, D. (2011). *Skilled interpersonal communication: research, theory, and practice*. (5th ed.). Routledge.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer Publishing Company.
- Lewin, K. (1943). Defining the field at a given time. *Psychological Review*, 50(3), 292–310.
- Megan, J., & Ziegler, L. (2012). The therapeutic use of self in nursing practice. *Journal of Nursing Education and Practice*, 2(2), 35–42.
- Peplau, H. E. (1991). *Interpersonal relations in nursing: A conceptual framework for application to professional practice*. Springer Publishing Company.
- Rogers, C. (1995). *On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Rogers, C. R. (1961). *On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy*. Houghton Mifflin.

- Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). The mathematical theory of communication. University of Illinois Press.
- Stuart, W. G. (2013). Prinsip dan praktik keperawatan kesehatan jiwa (Vols. 1 & 2). Elsevier.
- Suryani. (2005). Komunikasi Terapeutik: Teori dan praktik. EGC.
- Watson, J. (2008). Nursing: The philosophy and science of caring. University Press of Colorado.

BAB 2

SELF AWARENESS (KESADARAN INTRAPERSONAL DALAM HUBUNGAN INTERPERSONAL)

Tujuan Instruksional:

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan model keperawatan holistik kesadaran diri
2. Meningkatkan kesadaran diri dalam hubungan interpersonal
3. Menjelaskan tentang perawat dan pertumbuhan diri

Capaian Pembelajaran:

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu Mampu melakukan analisa diri untuk menumbuhkan *self awareness* dalam hubungan interpersonal.

Pendahuluan:

Hubungan perawat-klien yang terapeutik merupakan pengalaman belajar bersama dan memperbaiki pengalaman emosi klien. Dalam hubungan ini perawat menggunakan kualitas pribadi dan keterampilan klinis dalam menangani pasien untuk merubah wawasan dan perilaku (Stuart, 2013). Supaya perawat dapat melaksanakan komunikasi terapeutik yang efektif, perawat harus mempunyai kemampuan keterampilan yang cukup dan memahami tentang dirinya.

Instrumen utama yang digunakan dalam komunikasi terapeutik adalah diri perawat sendiri. Oleh karena itu sebelum melakukan komunikasi dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas, perawat harus melakukan “analisis diri”, meliputi: kesadaran diri (self awareness), klarifikasi nilai, eksplorasi perasaan, kemampuan menjadi model, panggilan jiwa (altruisme), tanggung jawab dan etika.

Kesadaran diri perawat dapat ditingkatkan dengan mampu menjawab pertanyaan, “Siapakah saya?”. Perawat memperhatikan kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial budaya klien dan sudut pandang klien. Perawat harus belajar mengatasi kecemasan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan yang mungkin terjadi pada klien dalam menghadapi kesehatannya. Perawat harus mampu mengkaji perasaan, reaksi dan perilakunya secara pribadi maupun sebagai pemberi pelayanan keperawatan. Pemahaman yang baik dan penerimaan diri memungkinkan perawat untuk mengetahui perbedaan dan keunikan klien.

Uraian Materi

Materi yang dibahas pada bab ini meliputi: a) Model keperawatan holistik kesadaran diri; b) Meningkatkan kesadaran diri; c) Perawat dan pertumbuhan diri.

A. Model Keperawatan Holistik Kesadaran Diri

Menurut Campbell (1980), model keperawatan holistik tentang kesadaran diri terdiri dari empat komponen yang saling terkait, yaitu: psikologis, fisik, lingkungan, dan filosofis.

1. Komponen psikologis mencakup pengetahuan tentang emosi, motivasi, konsep diri, dan kepribadian. Menyadari diri secara psikologis berarti peka terhadap perasaan dan kejadian luar yang mempengaruhi perasaan tersebut.
2. Komponen fisik adalah pengetahuan tentang fisiologi pribadi dan umum, serta sensasi tubuh, citra tubuh, dan potensi fisik.
3. Komponen lingkungan terdiri dari lingkungan sosial budaya, hubungan dengan orang lain, dan pengetahuan tentang hubungan antara manusia dan alam.
4. Komponen filosofis adalah rasa hidup yang bermakna. Filosofi pribadi tentang hidup dan mati atau mungkin tidak mencakup makhluk spiritual, tetapi memperhitungkan tanggung jawab terhadap dunia dan etika perilaku.

Komponen-komponen ini secara bersama menyediakan model yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran diri dan pertumbuhan diri perawat dan pasien yang mereka rawat.

B. Meningkatkan Kesadaran Diri

Kesadaran diri dan perkembangan diri perawat perlu ditingkatkan agar penggunaan diri secara terapeutik dapat lebih efektif. Konsep teori yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran diri adalah teori Johari Window. Menurut Johari Window dalam (Stuart, 2013), menggambarkan perilaku, pikiran dan perasaan seseorang dalam empat kuadran (Gambar 2.1).

1 Dirinya dan orang lain tahu	2 Hanya orang lain yang tahu
3 Hanya dirinya yang tahu	4 Dirinya dan orang lain tidak tahu

Gambar 2.1: Johari Window dalam (Stuart, 2013)

1. Kuadran 1 adalah kuadran terbuka; mencakup perilaku, perasaan, dan pikiran yang diketahui oleh individu dan orang lain di sekitarnya.
2. Kuadran 2 adalah kuadran buta; mencakup semua hal-hal yang diketahui orang lain tetapi tidak diketahui oleh individu sendiri.
3. Kuadran 3 adalah kuadran tersembunyi; termasuk hal-hal tentang diri yang hanya diketahui oleh individu.
4. Kuadran 4 adalah kuadran tidak diketahui; berisi aspek diri yang tidak diketahui oleh individu dan orang lain.

Terdapat tiga prinsip yang dapat membantu menjelaskan tentang fungsi diri, meliputi:

1. Perubahan di salah satu kuadran akan mempengaruhi kuadran lainnya.
2. Semakin kecil kuadran satu, semakin buruk komunikasinya.
3. Pembelajaran interpersonal berarti telah terjadi perubahan sehingga kuadran satu lebih besar dan satu atau lebih kuadran lain lebih kecil.

Terjadinya perubahan pada satu kuadran akan mempengaruhi kuadran yang lain. Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dari pergeseran masing-masing kuadran menurut teori tersebut, antara lain (Mundakir, 2016; Stuart, 2013):

1. Kuadran 1 yang diperbesar.

Menunjukkan individu dengan keterbukaan besar terhadap dunia. Sebagian besar potensi orang ini sedang dikembangkan dan diwujudkan. Orang ini juga memiliki sedikit pertahanan diri dan dapat berinteraksi lebih spontan dan jujur dengan orang lain. Individu ini cenderung bahkan selalu terbuka dengan orang lain. Ciri khas dari individu ini adalah periang, familier, mudah akrab, tidak kikir, banyak teman dan menyenangkan

2. Kuadran 2 yang diperbesar.

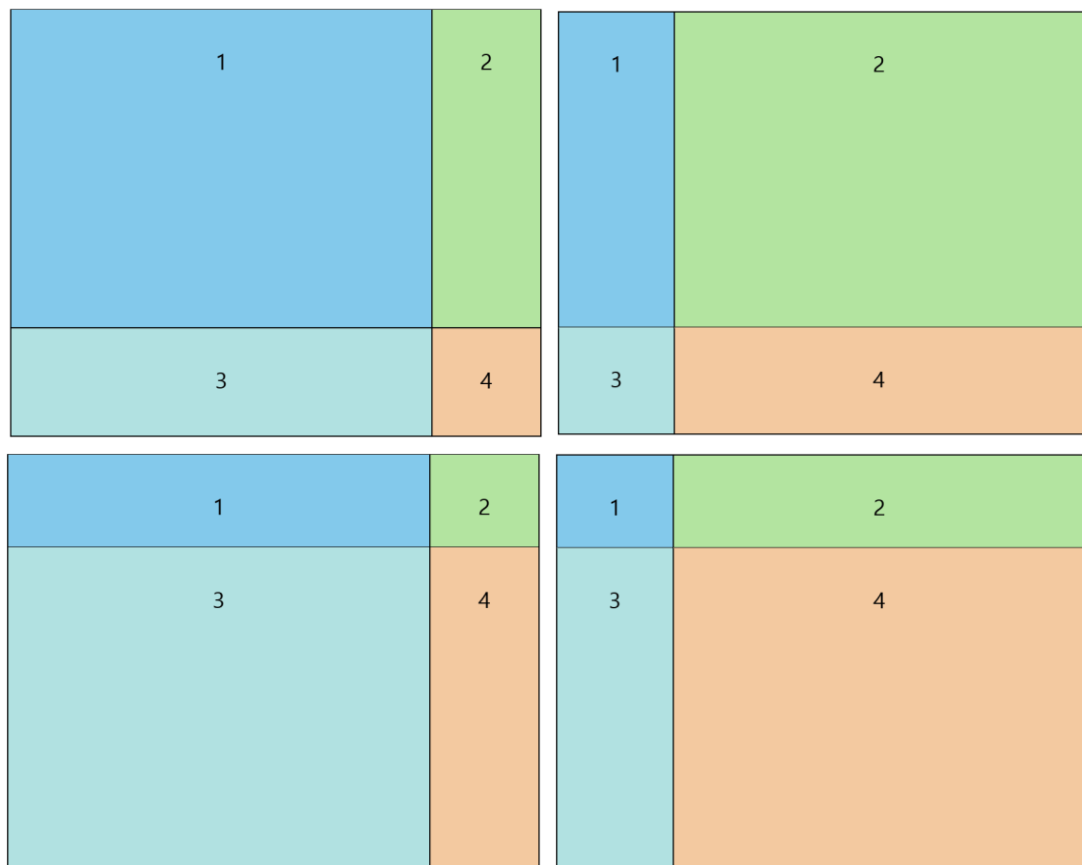
Individu ini suka menonjolkan dirinya sendiri, dia merasa paling hebat, seperti katak dalam tempurung. Dia tidak menyadari bahwa tindakannya tidak benar, dia buta terhadap dirinya sendiri sehingga area ini disebut juga *Blind Area* (area buta).

3. Kuadran 3 yang diperbesar.

Individu ini suka menyendiri, pendiam, tidak suka bergaul atau berinteraksi dengan orang lain. Individu ini lebih banyak menyimpan rahasia, sehingga area ini dapat disebut dengan "*Secret area*".

4. Kuadran 4 yang diperbesar.

Menggambarkan seseorang dengan sedikit kesadaran diri yang perilaku dan perasaannya terbatas. individu ini tidak diketahui oleh orang lain namun dia tahu banyak tentang orang lain. Dia tertutup terhadap dirinya, tidak ada yang tahu tentang dirinya sekalipun dirinya sendiri, hanya Tuhan yang mengetahui segala sesuatu tentang dirinya.



Gambar 1.2: A dan B, Johari Window yang Menunjukkan Berbagai Tingkat Kesadaran Diri (Stuart, 2013).

Kesadaran diri dapat ditingkatkan melalui tiga cara, yaitu:

1. Mempelajari diri sendiri

Hal ini dapat dilakukan dengan memperbesar kuadran satu sekaligus mengurangi ukuran tiga kuadran lainnya. Seorang perawat perlu mempelajari dirinya supaya tahu kelebihan dan kekurangannya. Perawat yang kurang menyadari tentang aspek yang ada dalam dirinya merupakan salah satu penyebab tidak efektifnya komunikasi perawat-klien. Aspek diri yang berada di luar kesadaran seseorang akan berada di luar kendalinya sehingga dapat merusak interaksinya dengan orang lain (Ellis et al., 2000).

2. Mendengarkan dan belajar dari orang lain

Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi ukuran kuadran dua. Tidak ada seseorang yang mampu mengenal dirinya secara keseluruhan sehingga seseorang perlu mendengarkan dan terbuka terhadap saran dan umpan balik dari orang lain.

3. Mengembangkan sikap terbuka

Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi ukuran kuadran tiga. Sikap terbuka merupakan salah satu tanda kepribadian yang sehat dan sarana untuk mengembangkan kepribadian yang sehat. Sikap terbuka kepada orang lain, dapat membuat seseorang lebih aman ketika berinteraksi karena tidak ada sesuatu yang disembunyikan.

Selain menggunakan Johari Window untuk meningkatkan kesadaran diri, menurut DeVito (1998) menjelaskan bahwa perawat juga dapat melakukan pengungkapan dirinya. Dengan cara ini, perawat dilatih untuk jujur dalam mengungkapkan siapa dirinya (Anjaswarni, 2016). Berikut cara pengungkapan diri yang dapat dilakukan oleh perawat.

1. Ungkapan informasi tentang diri kita sendiri yang biasa kita sembunyikan.
2. Ungkapan hal-hal yang menyangkut diri kita yang tidak disadari.
3. Ungkapan hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui orang lain.
4. Ungkapan informasi tentang diri kita: pikiran, perasaan, dan perilaku.
5. Ungkapan informasi yang biasa dan secara aktif disembunyikan.
6. Libatkan minimal satu orang untuk lebih banyak mengungkapkan diri kita (perawat), baik tentang kebaikan, kejelekan, kelebihan, maupun kekurangan.

C. Perawat dan Pertumbuhan Diri

Perawat perlu waktu untuk mengeksplorasi dan mendefinisikan berbagai bagian dari kepribadian mereka. Jika pengalaman keperawatan mereka melibatkan persepsi, perasaan, dan pemikiran, maka mahasiswa keperawatan harus diberi waktu dan kesempatan untuk mempelajari pengalaman-pengalaman ini. Keaslian dalam

hubungan harus dipelajari, dan perawat harus terlebih dahulu terbuka dalam hubungan dengan instruktur dan supervisor. Mahasiswa dan instruktur dapat berpartisipasi dalam hubungan yang menerima dan menghargai perbedaan individu mereka. Instruktur dapat membantu mahasiswa dengan memfasilitasi kesadaran diri mahasiswa, meningkatkan tingkat fungsi mereka, merangsang lebih banyak pengarahan diri, dan membantu mereka mengatasi stresor.

Keaslian dalam hubungan melibatkan keterbukaan terhadap eksplorasi diri terhadap pikiran, kebutuhan, emosi, nilai, pertahanan, tindakan, komunikasi, masalah, dan tujuan. Mahasiswa keperawatan memiliki banyak pengalaman baru yang memberikan kesempatan untuk belajar mandiri. Mahasiswa akan dihadapkan pada penyakit, perilaku aneh, masalah kompleks, dan bahkan kematian. Perasaan yang terkait dengan pengalaman ini harus didiskusikan. Misalnya, mahasiswa mungkin memasuki lingkungan klinis dengan cita-cita yang tinggi dan gambaran yang tidak realistis. Mungkin mereka memandang perawat sebagai "pekerja ajaib" yang serba tahu dan peduli. Selama pertemuan awal, mahasiswa mungkin merasa takut, cemas, dan tidak mampu, bertanya-tanya bagaimana seorang perawat memperoleh pengetahuan yang diperlukan.

Mahasiswa keperawatan mungkin merendahkan kemampuan mereka dan merasa seperti beban bagi pasien, atau mereka mungkin mengidentifikasi diri secara dekat dengan pasien dan merasa marah terhadap sistem yang impersonal dan personel yang tidak responsif. Perasaan yang terlibat dalam semua situasi ini harus diidentifikasi, didiskusikan, dan dianalisis. Dengan demikian, perawat dapat menyelesaikannya dengan cara yang konstruktif. Selama proses pertumbuhan, mahasiswa membutuhkan dukungan dan bimbingan dari instruktur yang tidak kritis tetapi menantang. Bersama-sama mereka dapat menganalisis perilaku mahasiswa, dan mahasiswa dapat menilai kekuatan dan keterbatasan pribadi. Sering kali membantu jika mahasiswa berbagi pengalaman ini dengan kelompok sebaya. Mahasiswa dapat berempati, mengkritik, dan saling mendukung saat mereka belajar lebih banyak tentang diri mereka sendiri. Pemeriksaan diri yang objektif tidak mudah atau menyenangkan, terutama ketika temuan bertentangan dengan cita-cita diri. Namun, seperti banyak pengalaman menyakitkan lainnya, menemukan kesadaran diri menghadirkan tantangan, menerima keterbatasan diri atau mengubah perilaku yang mendukungnya (Stuart, 2013).

D. Latihan Soal

Soal Pilihan Ganda

1. Pengetahuan tentang fisiologi pribadi dan umum, serta sensasi tubuh, citra tubuh, dan potensi fisik. Pernyataan tersebut merupakan model keperawatan holistik tentang kesadaran diri pada komponen?
 - A. Komponen fisik
 - B. Komponen filosofis
 - C. Komponen spiritual
 - D. Komponen psikologis
 - E. Komponen lingkungan
2. Meningkatkan kesadaran diri dapat dilakukan dengan mengurangi ukuran kuadran dua. Tidak ada seseorang yang mampu mengenal dirinya secara keseluruhan sehingga seseorang perlu mendengarkan dan terbuka terhadap saran dan umpan balik dari orang lain. Cara ini disebut?
 - A. Mempelajari diri sendiri
 - B. Mengembangkan sikap terbuka
 - C. Mendengarkan dan belajar dari orang lain
 - D. Mengungkapkan informasi tentang diri kita
 - E. Mengungkapkan hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui orang lain.
3. Kesadaran diri dapat ditingkatkan dengan memperbesar kuadran satu sekaligus mengurangi ukuran tiga kuadran lainnya. Seorang perawat perlu mempelajari dirinya supaya tahu kelebihan dan kekurangannya. Perawat yang kurang menyadari tentang aspek yang ada dalam dirinya merupakan salah satu penyebab tidak efektifnya komunikasi perawat-klien. Aspek diri yang berada di luar kesadaran seseorang akan berada di luar kendalinya sehingga dapat merusak interaksinya dengan orang lain. Cara ini disebut?
 - A. Mempelajari diri sendiri
 - B. Mengembangkan sikap terbuka
 - C. Mendengarkan dan belajar dari orang lain
 - D. Mengungkapkan informasi tentang diri kita
 - E. Mengungkapkan hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui orang lain.
4. Perilaku, perasaan, dan pikiran yang diketahui oleh individu dan orang lain di sekitarnya. Menurut Johari Window merupakan area?
 - A. Kuadran 1
 - B. Kuadran 2

- C. Kuadran 3
 - D. Kuadran 4
 - E. Kuadran 1 dan 2
5. Semua hal-hal yang diketahui orang lain tetapi tidak diketahui oleh individu sendiri. Menurut Johari Window merupakan area?
- A. Kuadran 1
 - B. Kuadran 2
 - C. Kuadran 3
 - D. Kuadran 4
 - E. Kuadran 1 dan 2

Soal Essay

1. Jelaskan makna kuadran 2 (kuadran buta) dari Johari Window?
2. Sebutkan dan jelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran diri!
3. Sebutkan tiga prinsip yang dapat membantu menjelaskan tentang fungsi diri!
4. Jelaskan komponen psikologis dari model keperawatan holistik tentang kesadaran diri?
5. Jelaskan cara pengungkapan diri yang dapat dilakukan oleh perawat menurut DeVito (1998)?

Kunci Jawaban

1. A
2. C
3. A
4. A
5. B

E. Rangkuman Materi

Model keperawatan holistik tentang kesadaran diri terdiri dari empat komponen yang saling terkait, yaitu: psikologis, fisik, lingkungan, dan filosofis. Komponen-komponen ini secara bersama menyediakan model yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran diri dan pertumbuhan diri perawat dan pasien yang mereka rawat. Kesadaran diri dan perkembangan diri perawat perlu ditingkatkan agar penggunaan diri secara terapeutik dapat lebih efektif. Konsep teori yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran diri adalah teori Johari Window. Menurut Johari Window, menggambarkan perilaku, pikiran dan perasaan

seseorang dalam empat kuadran yaitu: 1) Kuadran 1 adalah kuadran terbuka; 2) Kuadran 2 adalah kuadran buta; 3) Kuadran 3 adalah kuadran tersembunyi; dan 4) Kuadran 4 adalah kuadran tidak diketahui. Terjadinya perubahan pada satu kuadran akan mempengaruhi kuadran yang lain. Kesadaran diri dapat ditingkatkan melalui tiga cara, yaitu: 1) Mempelajari diri sendiri; 2) Mendengarkan dan belajar dari orang lain; dan 3) Mengembangkan sikap terbuka.

F. Glosarium

Altruisme	: Panggilan jiwa
Blind area	: individu yang suka menonjolkan dirinya sendiri, merasa paling hebat, seperti katak dalam tempurung. Tidak menyadari bahwa tindakannya tidak benar, dia buta terhadap dirinya sendiri.
Pengungkapan diri	: perawat dilatih untuk jujur dalam mengungkapkan siapa dirinya.
Secret area	: individu yang suka menyendiri, pendiam, tidak suka bergaul atau berinteraksi dengan orang lain dan lebih banyak menyimpan rahasia.
Self awareness	: kesadaran diri.
Teori Johari Window	: Teori yang menggambarkan perilaku, pikiran dan perasaan seseorang.

G. Daftar Pustaka

- Anjaswarni, T. (2016). *Komunikasi dalam Keperawatan*. Kemenkes RI: Pusdik SDM Kesehatan.
- Ellis, R., Gates, R., & Kenworthy, N. (2000). *Komunikasi Interpersonal dalam Keperawatan: Teori dan Praktik*. Alih Bahasa: Susi Purwoko. EGC.
- Mundakir. (2016). *Buku Ajar Komunikasi Pelayanan Kesehatan*. Indomedia Pustaka.
- Stuart, G. W. (2013). *Principles and Practice of Psychiatric Nursing*. Elsevier Mosby.

BAB 3

DIMENSI RESPON DAN TINDAKAN

Tujuan Intruksional :

- Menjelaskan Pengertian Dimensi Respon
- Menjelaskan Jenis-jenis Dimensi Respon
- Menjelaskan Pengertian Dimensi Tindakan
- Menjelaskan Jenis-jenis Dimensi Tindakan
- Menerapkan Dimensi Respon dan Tindakan dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik keperawatan kepada klien

Capaian Pembelajaran :

- **CPL** : Mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif, inovatif serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat profesi dan klien
- **CPMK** : Mahasiswa mampu menerapkan dimensi respon dan tindakan dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik keperawatan
- **Sub – CPMK** :
 1. Sub – CPMK 1: Mampu menjelaskan pengertian dimensi respon
 2. Sub – CPMK 2: Mampu menjelaskan Jenis-jenis Dimensi Respon
 3. Sub – CPMK 3: Mampu menjelaskan Pengertian Dimensi Tindakan
 4. Sub – CPMK 4: Mampu menjelaskan Jenis-jenis Dimensi Tindakan
 5. Sub – CPMK 5: Mampu menerapkan Dimensi Respon dan Tindakan dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik keperawatan kepada klien

Pendahuluan

Latar belakang

Kemampuan berkomunikasi terapeutik sangat penting dimiliki tenaga kesehatan termasuk perawat, karena selain membantu terjadinya perubahan perilaku pasien kearah yang lebih baik, juga dapat mencegah timbulnya masalah legal etik dalam pelaksanaan pelayanan. Langkah bijaksana dalam meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan mengasah dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi terapeutik yang efektif pada para tenaga kesehatan, dan ini harus mulai dilatih sejak masa pendidikan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, kemampuan perawat untuk memahami dan merespons kebutuhan psikososial pasien telah terbukti dapat mempengaruhi hasil perawatan. Komunikasi yang efektif tidak hanya meningkatkan kenyamanan pasien, tetapi juga membantu mengurangi kecemasan, meningkatkan kepatuhan terhadap rencana perawatan, dan mempercepat proses penyembuhan. Dengan demikian, penerapan dimensi respons dan tindakan dalam keperawatan bukan hanya tugas profesional, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Namun, data menunjukkan bahwa penerapan komunikasi terapeutik oleh perawat masih menghadapi berbagai tantangan. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2024 oleh Putriyanti Sitorus, et.al. mengungkapkan adanya hubungan signifikan antara komunikasi terapeutik yang diterapkan perawat dan tingkat kepuasan pasien, dengan data menunjukkan bahwa 82% responden merasa puas dengan komunikasi yang dilakukan oleh perawat. Hal ini berakibat pada sekitar 40% pasien yang merasa kebutuhan emosionalnya belum terpenuhi secara optimal. Selain itu, laporan dari World Health Organization (WHO) pada tahun 2020 mengindikasikan bahwa komunikasi yang buruk antara tenaga kesehatan dan pasien dapat meningkatkan risiko ketidakpuasan pasien serta memperburuk kondisi psikologis mereka (WHO, 2020). Prevalensi kecemasan pada pasien yang dirawat di rumah sakit juga menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas komunikasi terapeutik. Sebagai contoh, penelitian oleh Lee et al. (2020) menunjukkan bahwa lebih dari 30% pasien pra-operasi mengalami tingkat kecemasan yang tinggi akibat kurangnya informasi yang jelas dan dukungan emosional dari tenaga kesehatan. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi pengalaman pasien, tetapi juga dapat berdampak pada hasil klinis mereka, seperti peningkatan risiko komplikasi pasca-operasi. Kurangnya pelatihan formal dan keterbatasan waktu yang dimiliki perawat seringkali menjadi hambatan utama dalam penerapan dimensi respons dan tindakan yang efektif. Beban kerja yang tinggi, terutama di rumah sakit dengan rasio perawat terhadap pasien yang tidak ideal, membuat perawat sulit memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan psikososial pasien. Sebagai tambahan, budaya organisasi yang belum sepenuhnya

mendukung pentingnya komunikasi terapeutik juga turut memperburuk situasi ini (Johnson et al., 2020).

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, maka langkah bijaksana dalam meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan meningkatkan dan mengasah kemampuan berkomunikasi terapeutik yang baik dan efektif pada para tenaga kesehatan. Kemampuan berkomunikasi ini harus mulai dilatih sejak masa pendidikan, sehingga dirasa penting untuk memulai membudayakan literasi komunikasi khususnya pada komunikasi terapeutik bagi mahasiswa keperawatan agar dapat mengasah kemampuan mereka dalam melakukan konseling atau KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada klien nantinya. Disamping itu, untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Salah satunya adalah dengan menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi perawat dalam hal komunikasi terapeutik. Program pelatihan ini dapat mencakup simulasi kasus, pelatihan keterampilan interpersonal, dan pembekalan tentang pentingnya aspek psikososial dalam perawatan pasien. Penelitian oleh Brown et al. (2021) menunjukkan bahwa pelatihan semacam ini mampu meningkatkan kompetensi perawat hingga 40% dalam menerapkan komunikasi terapeutik. Selain itu, pengaturan beban kerja yang lebih seimbang juga penting untuk memungkinkan perawat memiliki waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan pasien. Manajemen rumah sakit dapat berperan dalam mendukung upaya ini melalui kebijakan yang memastikan rasio perawat terhadap pasien yang ideal, sehingga perhatian terhadap kebutuhan emosional pasien dapat ditingkatkan. Dukungan teknologi, seperti penggunaan perangkat komunikasi digital, juga dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi interaksi yang lebih efektif antara perawat dan pasien. Implementasi kebijakan yang mendukung praktik komunikasi terapeutik harus diiringi dengan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutannya. Audit internal, survei kepuasan pasien, dan pelaporan rutin tentang penerapan komunikasi terapeutik dapat menjadi alat untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan dimensi respons dan tindakan dalam keperawatan dapat diterapkan secara optimal, sehingga memberikan dampak baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan.

Tujuan Pembelajaran

Tujuan dari penulisan buku ajar ini adalah :

1. Memahami konsep dasar dimensi respons, dan dimensi tindakan dalam praktik keperawatan profesional.
2. Mengidentifikasi jenis-jenis dimensi respons dan tindakan serta menganalisis contoh kasus yang relevan.

3. Mengembangkan keterampilan komunikasi terapeutik berdasarkan pemahaman definisi, tujuan, dan teknik yang sesuai dalam berbagai situasi klinis.
4. Meningkatkan kemampuan dalam membangun hubungan terapeutik yang efektif dengan pasien.
5. Menerapkan teknik-teknik komunikasi terapeutik secara profesional untuk mendukung asuhan keperawatan yang berkualitas.

Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan buku ajar ini yaitu :

Bagi Mahasiswa

Membantu mahasiswa keperawatan memahami konsep dasar dimensi respons, hubungan, dan dimensi tindakan dalam praktik keperawatan. Buku ajar ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa melalui pengembangan keterampilan komunikasi terapeutik, kepercayaan diri dalam membangun hubungan terapeutik, serta kesiapan menghadapi berbagai situasi klinis dengan pendekatan yang efektif.

Bagi Kemajuan Ilmu Keperawatan

Buku ajar ini berkontribusi pada pengembangan ilmu keperawatan melalui eksplorasi konsep hubungan terapeutik dan komunikasi terapeutik. Materi ini memperkaya literatur ilmiah, mendorong penelitian lebih lanjut, meningkatkan standar praktik komunikasi terapeutik, serta mendukung pengembangan model asuhan keperawatan berbasis bukti.

Bagi Institusi pendidikan

Mendukung institusi pendidikan keperawatan dalam menyediakan program pembelajaran yang berfokus pada penguasaan komunikasi terapeutik. Buku ini dirancang dengan materi terstruktur untuk memudahkan pencapaian kompetensi komunikasi, mendukung akreditasi program pendidikan, serta membantu dalam perancangan metode pembelajaran interaktif dan berbasis praktik

A. Dimensi Respon

1. Pengertian Dimensi Respon

Dimensi respon dalam komunikasi terapeutik merujuk pada aspek psikologis yang melibatkan perasaan dan reaksi perawat terhadap pasien. Dimensi ini mencakup kemampuan perawat untuk menunjukkan empati, respek, dan perhatian terhadap perasaan pasien, serta memberikan tanggapan yang sesuai dengan kebutuhan emosional mereka. Tujuan utamanya adalah membangun hubungan yang saling percaya dan mendukung proses penyembuhan pasien. Menurut Wiwi (2020), dimensi respon berfungsi untuk mempertahankan respons perawat terhadap perasaan klien, memberikan penjelasan yang akurat tentang masalah, dan mendorong klien untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyembuhan.

2. Jenis-jenis dimensi Respon

Dimensi respon terapeutik dalam komunikasi keperawatan sangat penting untuk membangun hubungan yang efektif antara perawat dan pasien. adapun beberapa jenis dari dimensi respon menurut Wiwi (2020) yaitu :

- a. Empati, adalah salah satu dimensi yang paling mendasar dalam komunikasi terapeutik. Empati bukan hanya sekedar memahami perasaan pasien, tetapi juga merasakan dan mengidentifikasi diri dengan pengalaman emosional pasien. Perawat yang menunjukkan empati akan menciptakan rasa kepercayaan yang mendalam dan memungkinkan pasien merasa dihargai. Empati juga berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan membantu mereka merasa didengarkan dan dipahami dalam situasi yang seringkali penuh tekanan. Dengan empati, perawat dapat merespons kebutuhan emosional pasien dengan cara yang tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga mendalam secara emosional. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wiwi (2020), empati menjadi dasar untuk menciptakan hubungan yang terjalin erat, di mana pasien merasa diakui sebagai individu, bukan hanya sebagai objek perawatan medis.
- b. Respek, dalam komunikasi terapeutik berarti memberikan penghormatan terhadap martabat pasien, nilai-nilai, serta keyakinan mereka. Respek sangat penting untuk menghindari sikap paternalistik dan mengutamakan otonomi pasien dalam pengambilan keputusan. Dalam praktik keperawatan, perawat diharapkan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghargai pandangan serta perasaan pasien tanpa adanya penilaian atau intervensi yang mengurangi hak mereka sebagai individu. Respek ini juga mencakup

pemahaman bahwa setiap pasien adalah unik, dengan latar belakang dan perspektif yang berbeda. Dalam hal ini, perawat bertindak sebagai mitra yang mendukung pasien untuk membuat keputusan yang tepat bagi kesehatannya, bukan sebagai otoritas yang memaksakan pendapat.

- c. Kesejatian (*Genuineness*), merujuk pada kejujuran dan keterbukaan perawat dalam interaksi mereka dengan pasien. Seorang perawat yang sejati akan menunjukkan keautentikan dalam berkomunikasi, tidak menggunakan topeng atau gaya komunikasi yang terkesan dibuat-buat. Kesejatian ini sangat penting dalam membangun kepercayaan antara pasien dan perawat, karena pasien akan lebih mudah untuk terbuka dan berbagi kekhawatiran mereka jika merasa bahwa perawat mereka adalah pribadi yang tulus dan tidak berpura-pura. Perawat yang menunjukkan kesejatian juga cenderung lebih efektif dalam memberikan dukungan emosional dan fisik, karena interaksi yang autentik membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih berarti.
- d. Konkrit dalam komunikasi terapeutik berarti memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pasien. Kadang-kadang, perawat mungkin berbicara menggunakan istilah medis yang rumit, yang bisa membingungkan pasien. Oleh karena itu, sangat penting bagi perawat untuk menyampaikan informasi dengan cara yang sederhana dan langsung, menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman pasien. Menyampaikan informasi secara konkret juga membantu pasien memahami kondisi mereka dengan lebih baik, yang berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih informasional mengenai perawatan mereka. Ini juga dapat mengurangi kecemasan dan kebingungannya, memberi mereka rasa kontrol terhadap situasi yang mereka hadapi.
- e. Kehangatan (*Warmth*) adalah dimensi yang menunjukkan perhatian dan empati perawat melalui ekspresi wajah, nada suara, serta sikap tubuh yang ramah dan terbuka. Kehangatan ini penting karena dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi pasien untuk berbicara tentang perasaan dan kekhawatiran mereka. Pasien sering kali merasa cemas atau tertekan dengan kondisi medis mereka, dan sikap hangat dari perawat dapat membantu meredakan ketegangan tersebut. Kehangatan tidak hanya terbatas pada komunikasi verbal, tetapi juga mencakup cara perawat memberikan perhatian penuh kepada pasien, seperti memegang tangan pasien dengan lembut atau menggunakan kontak mata yang menunjukkan empati.
- f. Keterbukaan (*Openness*), dalam komunikasi terapeutik berarti kesiapan perawat untuk mendengarkan dan menerima perasaan, pikiran, serta pengalaman pasien tanpa penilaian atau prasangka. Perawat yang terbuka

akan memberikan ruang bagi pasien untuk berbicara secara bebas dan jujur tentang apa yang mereka rasakan dan alami. Keterbukaan ini penting karena dapat meningkatkan hubungan antara perawat dan pasien, serta memberikan kesempatan bagi pasien untuk merasa lebih aman dan dihargai dalam berbagi hal-hal yang mungkin sangat pribadi. Dengan keterbukaan, perawat dapat menilai lebih akurat kebutuhan pasien dan memberikan intervensi yang lebih tepat.

- g. Konsistensi (*Consistency*), merujuk pada keteguhan dalam memberikan respons yang dapat diandalkan terhadap kebutuhan dan perasaan pasien. Konsistensi ini penting karena menciptakan stabilitas dalam hubungan terapeutik. Pasien membutuhkan perawat yang dapat diandalkan, yang memberikan respons yang sesuai dan tetap sama setiap kali mereka berinteraksi. Konsistensi dalam komunikasi juga membantu pasien merasa lebih aman, karena mereka tahu bahwa perawat mereka akan selalu memberikan perhatian dan perawatan yang dibutuhkan tanpa ada perubahan sikap atau kebingungan.

Secara keseluruhan, penerapan berbagai dimensi respon dalam komunikasi terapeutik sangat krusial dalam mendukung proses penyembuhan pasien. Melalui empati, respek, kesejatan, konkret, kehangatan, keterbukaan, dan konsistensi, perawat dapat menciptakan hubungan yang tidak hanya mendukung kesejahteraan fisik pasien, tetapi juga kesejahteraan emosional dan psikologis mereka.

3. Contoh Kasus Dimensi Respon

Berikut ini adalah contoh kasus yang menggambarkan penerapan dimensi respon dalam komunikasi terapeutik:

Kasus

Seorang pasien, Ibu Sekar, datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pada bagian perut. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, dokter mendiagnosisnya dengan tukak lambung dan merekomendasikan perawatan lebih lanjut serta perubahan gaya hidup, termasuk pengaturan pola makan. Pasien merasa cemas dan takut terhadap diagnosis ini karena khawatir tentang proses pengobatan dan efek samping dari obat-obatan. Ibu Sekar juga merasa khawatir tentang bagaimana perubahan pola makan akan mempengaruhi kehidupan sehari-harinya.

Dari kasus diatas adapun penerapan dimensi respon yang bisa dilakukan yaitu :

- a. Empati : Perawat Ratna, menyadari kecemasan pasien dan mendekati Ibu Sekar dengan sikap penuh perhatian. Ratna berkata, "Saya mengerti betapa

cemasnya Anda dengan kondisi ini, dan saya ingin membantu Anda merasa lebih tenang. Ini adalah kondisi yang dapat diobati, dan kami akan bekerja sama untuk membuat Anda merasa lebih baik.” Ratna berusaha memahami perasaan pasien dan menunjukkan dukungan emosional yang kuat. Pasien merasa dihargai dan lebih terbuka dalam berbicara tentang ketakutannya.

- b. Respek : Dalam menjelaskan kondisi pasien, Ratna menunjukkan penghargaan terhadap pilihan dan otonomi Ibu Sekar. Dia tidak hanya menjelaskan diagnosisnya, tetapi juga memberi ruang bagi Ibu Sekar untuk mengajukan pertanyaan tentang pilihan pengobatan dan bagaimana perubahan pola makan bisa dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu kehidupan sehari-harinya. Ratna berkata, “Kami bisa mendiskusikan pilihan pengobatan yang paling sesuai dengan gaya hidup Anda, dan saya akan mendengarkan apa yang menjadi kekhawatiran Anda.” Perawat menghormati keputusan pasien dalam menentukan langkah-langkah pengobatan.
- c. Kesejatian (*Genuineness*) : Ratna berkomunikasi dengan kejujuran penuh, menjelaskan prosedur medis yang perlu dilakukan dan dampaknya terhadap kehidupan pasien dengan cara yang jelas dan terbuka. “Saya ingin Anda tahu bahwa pengobatan ini aman, namun ada beberapa efek samping ringan yang mungkin Anda rasakan. Saya akan selalu ada untuk menjawab pertanyaan atau memberikan dukungan jika Anda merasa tidak nyaman,” kata Ratna. Pendekatan ini memperkuat hubungan yang tulus antara perawat dan pasien.
- d. Konkret : Ratna menjelaskan dengan sangat jelas tentang apa yang bisa diharapkan oleh Ibu Sekar selama perawatan dan bagaimana perubahan pola makan harus dilakukan. “Kita akan mulai dengan mengatur pola makan yang lebih ringan dan menghindari makanan yang memicu nyeri lambung. Saya akan membantu Anda menyusun menu yang sehat dan mudah diikuti,” jelas Ratna. Informasi yang disampaikan sangat konkret dan spesifik, sehingga Ibu Sekar dapat memahaminya dengan baik.
- e. Kehangatan : Ratna menunjukkan perhatian penuh dengan ekspresi wajah yang ramah dan nada suara yang menenangkan. “Saya di sini untuk membantu Anda. Tidak perlu khawatir, kita akan bekerja sama agar Anda merasa lebih baik,” ujar Ratna dengan senyum yang tulus. Sikap hangat ini membuat pasien merasa lebih nyaman dan kurang cemas tentang pengobatan yang akan dijalannya.
- f. Keterbukaan (*Openness*) : Ratna mendengarkan dengan sabar setiap kekhawatiran Ibu Sekar dan tidak terburu-buru memberikan solusi. “Saya ingin mendengar lebih lanjut tentang apa yang Anda rasakan, dan saya di sini untuk menjawab semua pertanyaan Anda tentang pengobatan dan diet,” kata Ratna.

Keterbukaan ini memberi ruang bagi Ibu Sekar untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya, yang meningkatkan keterlibatan dalam pengobatan.

g. Konsistensi : Ratna memastikan bahwa semua instruksi yang diberikan konsisten dengan informasi yang diberikan sebelumnya. Pada kunjungan berikutnya, Ratna kembali mengingatkan Ibu Sekar tentang pengaturan pola makan dan penggunaan obat yang telah dijelaskan sebelumnya. "Saya tahu Anda mungkin merasa sedikit kesulitan dengan perubahan pola makan, tapi ingat bahwa ini adalah langkah penting untuk kesembuhan Anda, dan saya akan tetap mendukung Anda," ucap Ratna. Dengan konsistensi dalam pendekatan ini, pasien merasa lebih yakin dan didukung sepanjang perjalanan perawatan.

Melalui penerapan dimensi-dimensi respon terapeutik ini, Ratna berhasil membangun hubungan yang lebih kuat dan efektif dengan Ibu Sekar. Pasien merasa lebih dihargai, didengarkan, dan diperhatikan, yang pada gilirannya meningkatkan keterlibatan pasien dalam proses pengobatan dan perubahan gaya hidup yang diperlukan.

B. Dimensi Tindakan

1. Pengertian Dimensi Tindakan

Dimensi tindakan dalam komunikasi terapeutik merujuk pada serangkaian langkah atau intervensi yang dilakukan oleh perawat atau tenaga medis lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pasien. Tindakan ini tidak hanya melibatkan aspek teknis atau fisik dalam perawatan medis, tetapi juga memfokuskan pada aspek komunikasi yang efektif untuk membangun hubungan yang mendalam dan saling percaya antara perawat dan pasien. Dimensi tindakan ini bertujuan untuk memfasilitasi perubahan positif dalam perilaku, perasaan, dan pola pikir pasien, yang pada akhirnya mendukung proses penyembuhan baik secara fisik maupun psikologis. Menurut Sabari (2020), dimensi tindakan dalam komunikasi terapeutik melibatkan berbagai teknik yang diterapkan oleh tenaga medis untuk membimbing pasien melalui proses refleksi diri dan meningkatkan kesadaran akan kondisi mereka. Salah satu aspek penting dari dimensi ini adalah kemampuan perawat untuk menggunakan pendekatan yang empatik dan non-judgmental, yang memungkinkan pasien merasa didengar dan diterima. Melalui dimensi tindakan ini, perawat diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan emosional atau psikologis yang menghalangi proses penyembuhan, sehingga perawat dapat membantu pasien mengatasi perasaan atau keyakinan yang membatasi mereka. Dimensi tindakan ini juga melibatkan konfrontasi, di mana perawat dengan bijak menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pikiran,

perasaan, atau tindakan pasien, serta membantu mereka melihat bagaimana inkonsistensi tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mereka. Pendekatan lain yang diterapkan adalah mendorong pasien untuk segera mengatasi perasaan atau masalah yang mereka hadapi, tanpa menunda-nunda, yang dapat membantu mencegah rasa cemas atau stres yang berlarut-larut.

Selain itu, dalam proses dimensi tindakan, perawat juga berperan dalam memfasilitasi katarsis emosional, yang memungkinkan pasien mengekspresikan perasaan terpendam mereka, seperti kesedihan atau kemarahan, sebagai cara untuk melepaskan beban emosional yang dapat menghambat penyembuhan. Proses ini penting untuk memberikan ruang bagi pasien untuk merasa lebih lega secara emosional (Sabari, 2020). Seluruh dimensi tindakan ini memerlukan keterampilan komunikasi yang sangat baik dari perawat, termasuk kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menunjukkan empati yang tulus. Dimensi ini juga menuntut perawat untuk mengembangkan keterampilan interpersonal yang dapat membantu membangun hubungan terapeutik yang kuat, sehingga pasien merasa lebih nyaman dan percaya dalam mengikuti saran atau instruksi medis.

2. Jenis-jenis Dimensi Tindakan

Dimensi tindakan dalam komunikasi terapeutik mencakup berbagai teknik yang digunakan oleh perawat untuk membantu pasien menyadari ketidaksesuaian antara perasaan, perilaku, dan keyakinan mereka, serta mendorong perubahan positif dalam diri pasien. Adapun beberapa jenis dimensi tindakan yang umum diterapkan dalam praktik keperawatan menurut Sabari (2020) yaitu:

a. Konfrontasi

Konfrontasi adalah proses interpersonal yg digunakan perawat utk memfasilitasi, memodifikasi, dan perluasan dari gambaran diri orang lain (Smith, 1992). Konfrontasi merupakan ekspresi perasaan perawat tentang perilaku klien yang tidak sesuai. Konfrontasi berguna untuk meningkatkan kesadaran klien akan kesesuaian peran, sikap, kepercayaan dan perilaku. Perawat menunjukkan ketidakcocokan antara pikiran, perasaan, kata-kata, atau tindakan pasien untuk membantu mereka menyadari inkonsistensi dalam diri mereka. Konfrontasi dilakukan dengan hati-hati dan penuh pengertian, sehingga pasien tidak merasa diserang atau dipermalukan.

Cara melakukan konfrontasi :

- 1) Clarify: membuat lebih dimengerti/lebih jelas dipahami oleh orang lain

2) Artikulate: mengekspresikan opini sendiri dg kalimat yg jelas

3) Request: permintaan

4) Encourage: memberikan suport, harapan, kepercayaan

Tujuan dari konfrontasi adalah agar orang lain sadar adanya ketidaksesuaian pada dirinya

Dua bagian konfrontasi

1) Membuat orang lain sadar terhadap perilaku yang tidak produktif/merusak

2) Membuat pertimbangan tentang bagaimana dia bertindak laku yang lebih produktif dengan jelas dan konstruktif

Waktu yang tepat dilakukannya konfrontasi:

1) Tingkah lakunya tidak produktif

2) Tingkah lakunya merusak

3) Ketika mereka melanggar hak kita atau hak orang lain

Konfrontasi seharusnya dilakukan secara asertif bukan agresif/marah. Oleh karena itu sebelum melakukan konfrontasi perawat perlu mengkaji antara lain: tingkat hubungan saling percaya dengan klien, waktu yang tepat, tingkat kecemasan dan kekuatan koping klien. Konfrontasi sangat berguna untuk klien yang telah mempunyai kesadaran diri tetapi perilakunya belum berubah

- b. Kesegeraan : Perawat mendorong pasien untuk segera mengatasi masalah atau perasaan yang muncul, tanpa menunda-nunda. Pendekatan ini membantu pasien untuk tidak terjebak dalam perasaan negatif atau perilaku yang tidak produktif.
- c. Membuka Diri : Perawat berbagi pengalaman pribadi yang relevan dengan pasien untuk menunjukkan empati dan membangun hubungan yang lebih dekat. Hal ini membantu pasien merasa lebih diterima dan dipahami, yang dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam proses penyembuhan.
- d. Emosional Katarsis : Perawat memungkinkan pasien untuk mengekspresikan perasaan mereka secara bebas, seperti menangis atau marah, sebagai cara untuk melepaskan emosi yang terpendam. Proses ini penting untuk mengurangi stres dan kecemasan yang dapat menghambat proses penyembuhan.
- e. Bermain Peran: Perawat membantu pasien untuk memerankan situasi tertentu yang mungkin mereka hadapi, untuk melatih keterampilan coping dan meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menghadapi tantangan. Pendekatan ini juga dapat membantu pasien melihat masalah dari perspektif yang berbeda.

Penerapan dimensi tindakan ini memerlukan keterampilan komunikasi yang tinggi dari perawat, termasuk kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menunjukkan empati yang tulus. Dengan menerapkan dimensi tindakan secara efektif, perawat dapat membantu pasien untuk lebih memahami diri mereka sendiri, mengatasi hambatan psikologis, dan mencapai proses penyembuhan yang lebih optimal.

C. Latihan Soal

Pilihan Ganda

1. Seorang pasien tampak menangis saat pertama kali harus menjalani rawat inap karena penyakit yang diderita, dan dia merasa sangat khawatir dengan penyakitnya. Untuk menunjukkan sikap profesionalnya, ada dimensi respon psikologis yang perlu ditunjukkan perawat. Apakah dimensi respon yang dimaksud?
A. melakukan konfrontasi
B. mengalihkan topik pembicaraan
C. menunjukkan empati kepada pasien
D. segera menasihati pasien untuk tidak khawatir
E. menunjukkan sikap terbuka dan menerima pasien
2. Berikut ini yang BUKAN termasuk dimensi tindakan dalam kehadiran psikologis perawat saat berkomunikasi dengan pasien adalah?
A. konkret
B. segera
C. terbuka
D. konfrontasi
E. emotional katarsis
3. Berikut ini adalah contoh komunikasi dalam dimensi respon yang menunjukkan sikap menghargai. Manakah contoh yang dimaksud tersebut?
A. Ibu tidak perlu khawatir, semua akan baik-baik saja
B. Ibu tidak perlu khawatir, kami akan membantu
C. Saya paham dengan apa yang ibu rasakan
D. Ibu tidak perlu memikirkan penyakit ibu
E. Saya tau apa yang ibu pikirkan
4. Manakah dari berikut ini yang termasuk dalam teknik dimensi tindakan dalam komunikasi terapeutik?
A. Mengabaikan emosi pasien

- B. Menghindari kontak mata dengan pasien
- C. Menunda komunikasi untuk waktu yang tepat
- D. Memberikan umpan balik negatif kepada pasien
- E. Menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali perasaan pasien

5. "Anda mengatakan ingin hidup sehat, tetapi anda juga seorang perokok."

Kalimat diatas adalah bentuk sikap perawat dalam komunikasi terapeutik yang ditunjukkan melalui dimensi tindakan dimana perawat menunjukkan dan mengumpambalik perilaku klien yang tidak sesuai.

Apakah dimensi tindakan yang tepat untuk pernyataan diatas ?

- A. keterbukaan
- B. konfrontasi
- C. kesegeraan
- D. respek
- E. konkrit

Soal Essay

1. Apa saja yang termasuk sebagai bagian dari sikap dalam dimensi respon ?
2. Jelaskan yang dimaksud dengan sikap ikhlas dalam dimensi respon.
3. Jelaskan yang dimaksud dengan konfrontasi dalam dimensi tindakan. Berikan contohnya.
4. Keterbukaan merupakan hal penting untuk membangun hubungan saling percaya antara perawat dengan pasiennya, maka perawat perlu membuka diri berbagi pengalaman yang berguna untuk terapi pasiennya. Sebutkan minimal 3 cara membuka diri perawat dalam dimensi tindakan.
5. Apa yang dimaksud dengan empati dalam dimensi respon komunikasi terapeutik perawat? berikan contoh.

- 1. C
- 2. A
- 3. C
- 4. E
- 5. B

D. Rangkuman Materi

Dimensi respons dan tindakan dalam keperawatan merupakan komponen esensial dalam komunikasi terapeutik yang bertujuan untuk membangun hubungan yang mendukung kesembuhan pasien. Dimensi respons melibatkan aspek psikologis seperti empati, keikhlasan, penghargaan, dan konkretisasi dalam interaksi antara perawat dan pasien. Dimensi respon berfungsi untuk mempertahankan respons perawat terhadap perasaan klien, memberikan penjelasan yang akurat tentang masalah, dan mendorong klien untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyembuhan. Sikap yang dapat ditunjukkan perawat kepada pasien melalui dimensi respon antara lain empati, menghargai, kesejatan, kehangatan, konkret, keterbukaan dan konsisten. Melalui sikap responsif ini perawat dapat menciptakan hubungan yang tidak hanya mendukung kesejahteraan fisik pasien, tetapi juga kesejahteraan emosional dan psikologis mereka.

Dimensi tindakan dalam komunikasi terapeutik merujuk pada serangkaian langkah atau intervensi yang tidak hanya melibatkan aspek teknis atau fisik dalam perawatan medis, tetapi juga memfokuskan pada aspek komunikasi yang efektif untuk membangun hubungan yang mendalam dan saling percaya antara perawat dan pasien. Dimensi tindakan ini bertujuan untuk memfasilitasi perubahan positif dalam perilaku, perasaan, dan pola pikir pasien, yang mencakup upaya untuk memfasilitasi kesadaran pasien terhadap ketidaksesuaian antara perasaan, perilaku, dan keyakinan mereka, melalui konfrontasi, keterbukaan, katarsis emosional, dan bermain peran.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, kedua dimensi ini memainkan peran penting dalam memastikan kualitas interaksi terapeutik dan keberhasilan asuhan keperawatan secara keseluruhan. Kemampuan perawat untuk memahami dan merespons kebutuhan psikososial pasien telah terbukti dapat mempengaruhi hasil perawatan. Penerapan dimensi respons dan tindakan dalam keperawatan bukan hanya tugas profesional, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

E. Glosarium

Dimensi = aspek atau sudut pandang tertentu dari sesuatu yang lebih luas/ menunjukkan keragaman atau kompleksitas dari reaksi yang diberikan

Dimensi respon = berbagai aspek atau elemen yang membentuk respon seseorang terhadap suatu situasi, peristiwa, atau rangsangan

Dimensi tindakan = aspek atau elemen yang membentuk suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang/ berbagai sudut pandang yang bisa digunakan untuk memahami atau menilai sebuah tindakan

Empati = kemampuan untuk menempatkan diri sesuai situasi dan kondisi yang dialami klien

Katarsis Emosional = proses pelepasan atau pembersihan emosi yang terpendam melalui pengalaman atau ekspresi yang kuat, seperti menangis, berbicara terbuka, atau bahkan mengalami suatu peristiwa yang sangat emosional.

KIE = singkatan dari Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Istilah ini sering digunakan dalam konteks program atau kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cara yang efektif, serta memberikan pemahaman dan pembelajaran

Komunikasi verbal = proses penyampaian pesan atau informasi melalui kata-kata, baik secara lisan (berbicara) maupun tulisan

Komunikasi terapeutik = bentuk komunikasi yang digunakan oleh tenaga kesehatan, seperti perawat atau dokter, untuk membangun hubungan yang efektif dan mendukung proses penyembuhan atau pemulihan pasien

Konfrontasi = situasi atau peristiwa di mana dua pihak atau lebih saling menghadapi, biasanya dengan ketegangan atau konflik

Konstruktif = sesuatu yang bersifat membangun, positif, atau produktif, terutama dalam konteks pemikiran, saran, atau tindakan

Literasi = kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari

F. Daftar Pustaka

- Brown, K., et al. (2021). Enhancing communication competence in nurses: Evidence-based training programs. *Nurse Education Today*, 42(3), 89-96. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.04.006>.
- Hairani, M., Salviana, D., & Bakar, A. (2020). Kepuasan pasien ditinjau dari komunikasi perawat-pasien. *Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 12(1). <http://doi.org/10.29080/jpp.v12i1.520>.
- Johnson, R., et al. (2020). Barriers to effective nurse-patient communication: A qualitative study. *Nursing Research and Practice*, 22(4), 78-85. <https://doi.org/10.1155/2020/7896357>.
- Lee, H., et al. (2020). Preoperative anxiety and its management: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies*, 58(1), 45-52. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.01.004>.

- Lestari, R., Sari, S. M., & Rasyid, T. A. (2021). Penerapan komunikasi terapeutik perawat pada saat tindakan keperawatan. *Jurnal Keperawatan Hang Tuah*, 1(1). <https://jom.http.ac.id/index.php/jkh>.
- Lubis, M. S. I. (2020). Komunikasi antarpribadi guru dan siswa dalam mencegah kenakalan remaja. *Network Media*, 3(1), 95. <https://doi.org/10.17509/nmj.v3i1.2444>.
- Pratiwi, D. (2020). Komunikasi terapeutik dalam keperawatan: Membangun hubungan terapeutik yang efektif dengan pasien. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(3), 234-241. <https://doi.org/10.20473/jki.v25i3.234-241>.
- Sabari, S. (2020). Dimensi tindakan dalam komunikasi terapeutik. *SYI'AR: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat Islam*, 3(2), 94-103. <https://syiarjournal.com>.
- Sitorus, P., et al. (2024). Hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat kepuasan pasien. *Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat Dengan Tingkat Kepuasan Pasien*, NAI: Nursing Applied Journal.
- Syahrozi, A. (2020). Analisis strategi komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) dalam mensosialisasikan program keluarga berencana (KB) di Tanah Grogot. *eJournal S1 Ilmu Komunikasi*, 8(4).
- Wahyudin, W. (2021). Komunikasi terapeutik pada pasien pre operasi apendisitis dalam mengurangi kecemasan. *Mandala of Health*, 13(2), 01-10. <http://doi.org/10.20884/1.mandala.2021.13.2.8205>.
- World Health Organization (WHO). (2020). The World Health Organization (WHO) approach to healthy ageing. Diakses dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7385442/>.
- Yankes Kemenkes. (2022). Komunikasi terapeutik. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses pada 22 Desember 2024, dari https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1344/komunikasi-terapeutik.

BAB 4

HAMBATAN DALAM KOMUNIKASI TERAPEUTIK

Tujuan Instruksional:

Menjelaskan konsep hambatan - hambatan dalam komunikasi terapeutik

Capaian pembelajaran:

1. Mendiskusikan macam-macam hambatan dalam komunikasi terapeutik
2. Mempraktikan macam-macam hambatan dalam komunikasi terapeutik
3. Mendiskusikan solusi dari berbagai hambatan dalam komunikasi terapeutik

Pendahuluan

Komunikasi terapeutik merupakan elemen fundamental dalam dunia pelayanan kesehatan, keperawatan, psikologi, dan bidang-bidang lain yang berfokus pada relasi interpersonal. Komunikasi ini tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan hubungan yang penuh empati, kepercayaan, dan dukungan emosional antara tenaga profesional dan klien atau pasien.

Dalam praktiknya, komunikasi terapeutik tidak selalu berjalan dengan lancar. Terdapat berbagai hambatan yang bisa muncul, baik dari pihak tenaga profesional maupun dari individu yang dilayani. Hambatan tersebut bisa bersifat verbal maupun nonverbal, internal maupun eksternal, dan sering kali dipengaruhi oleh faktor psikologis, budaya, bahasa, lingkungan, hingga kondisi fisik atau emosional masing-masing pihak.

Kurangnya pemahaman terhadap hambatan-hambatan ini dapat mengganggu efektivitas komunikasi dan bahkan memperburuk kondisi klien. Komunikasi yang tidak tepat berisiko menimbulkan salah paham, kecemasan, resistensi terhadap terapi, hingga menurunnya kualitas pelayanan. Oleh karena itu, penting bagi para tenaga profesional untuk tidak hanya menguasai teknik komunikasi terapeutik, tetapi juga memiliki kepekaan dalam mengenali dan mengatasi setiap bentuk hambatan yang mungkin muncul selama proses interaksi.

Uraian Materi

Komunikasi terapeutik merupakan elemen krusial dalam praktik keperawatan, karena dapat mempengaruhi kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Komunikasi yang dilakukan mencakup interaksi yang penuh perhatian, empati, dan responsif antara perawat dan pasien yang dirawat dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan pasien saat dirawat yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesehatan fisik, emosional, dan psikologis pasien. Namun dalam prakteknya, terdapat berbagai hambatan yang dapat mengganggu efektivitas komunikasi terapeutik. Hambatan-hambatan ini bisa bersumber dari berbagai faktor, baik yang bersifat individu, sosial, budaya, maupun lingkungan. Uraian ini akan membahas hambatan-hambatan utama dalam komunikasi terapeutik di bidang keperawatan, faktor-faktor penyebabnya, serta cara-cara untuk mengatasi hambatan tersebut agar komunikasi yang efektif dapat tercapai.

A. Hambatan Verbal

Hambatan verbal salah satu kendala utama dalam komunikasi terapeutik yang sering kali terjadi ketika pesan yang disampaikan oleh perawat tidak dapat dipahami dengan jelas oleh pasien. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya kejelasan, atau ketidakmampuan perawat untuk menyesuaikan bahasa dengan tingkat pemahaman pasien dan penggunaan bahasa yang terlalu teknis, tidak sesuai dengan tingkat pemahaman pasien, atau bahkan penggunaan kata-kata yang ambigu. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan terminologi medis yang kompleks, kurangnya kejelasan, atau ketidakmampuan perawat untuk menyesuaikan bahasa dengan tingkat pemahaman pasien seringkali menjadi masalah. Adapun hambatan verbal yang sering terjadi adalah:

1. Penggunaan Bahasa Medis yang Rumit

Dalam dunia keperawatan, perawat sering kali menggunakan terminologi medis yang sulit dipahami oleh pasien. Hal ini dapat menyebabkan kebingungannya dan mengurangi kualitas komunikasi. Penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Jones (2018) menunjukkan bahwa penggunaan bahasa medis yang terlalu teknis dapat menghambat pemahaman pasien terhadap informasi yang disampaikan. Setiawati (2020) menemukan bahwa hambatan serupa terjadi pada pasien dengan latar belakang pendidikan rendah, yang sulit memahami istilah medis

2. Gaya Bahasa yang Tidak Sensitif terhadap Bahasa lokal.

Penggunaan bahasa oleh perawat yang kurang empatik atau terkesan menghakimi juga menjadi kendala dalam komunikasi.. Misalnya, dalam situasi

yang penuh tekanan, perawat mungkin menggunakan nada yang keras atau mengabaikan perasaan pasien, yang dapat menciptakan jarak emosional (Smith & Jones, 2018). Adams (2020) mengungkapkan bahwa di beberapa negara dengan populasi multibahasa, perawat sering kali gagal menyesuaikan bahasa dengan kebutuhan pasien. Rahmawati et al. (2019) menunjukkan bahwa penggunaan bahasa daerah dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, terutama di wilayah pedesaan.

B. Hambatan Non-Verbal

Komunikasi non-verbal, yang mencakup ekspresi wajah, gerak tubuh, kontak mata, dan intonasi suara, juga memainkan peran penting dalam komunikasi terapeutik. Namun, sering kali terdapat hambatan non-verbal yang mempengaruhi efektivitas komunikasi.

1. Ekspresi Wajah yang Tidak Empatik

Green (2019) menyoroti ekspresi wajah yang tidak sesuai dengan situasi dapat menciptakan ketegangan, kurangnya ekspresi empatik seperti senyuman atau kontak mata yang tulus, sering kali membuat pasien merasa tidak didukung secara emosional. Misalnya perawat tidak menunjukkan ekspresi empatik saat berbicara dengan pasien yang sedang cemas, pasien mungkin merasa tidak diperhatikan atau tidak dipahami. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan pasien terhadap perawat. **Suryani (2018)** mencatat bahwa pasien dengan penyakit kronis sering merasa diabaikan karena kurangnya kontak non-verbal yang hangat dari perawat

2. Postur dan Gestur yang Menyebabkan Keterasingan

Brown et al. (2021) dalam penelitiannya di rumah sakit Amerika menemukan bahwa postur tubuh yang kaku atau terlalu formal dari perawat dapat menciptakan kesan kurangnya keterbukaan. Hal serupa ditemukan oleh Yulianti dan Hartono (2021) di rumah sakit Jawa Timur, di mana pasien merasa enggan berbicara karena postur perawat yang tampak terburu-buru. Postur tubuh yang terlalu kaku atau terlalu jauh dari pasien dapat memberikan kesan bahwa perawat tidak peduli atau tidak terbuka untuk berinteraksi. Sebaliknya, gestur yang terlalu mendominasi atau agresif dapat menambah kecemasan pasien, terutama jika pasien sudah dalam keadaan tertekan (Green, 2019).

C. Hambatan Psikologis

Faktor psikologis baik pada pasien maupun perawat dapat menjadi hambatan besar dalam komunikasi terapeutik. Pasien yang mengalami stres, kecemasan, atau depresi mungkin merasa sulit untuk berkomunikasi secara terbuka. Selain itu yang

menjadi hambatan psikologis yang dating dari perawatan adalah beban kerja yang tinggi dapat mengurangi kemampuan perawat dalam berkomunikasi secara baik. Berikut hambatan psikologis dalam komunikasi:

1. Kecemasan dan Ketakutan Pasien

Banyak pasien yang merasa cemas tentang kondisi kesehatannya dan ini dapat menghambat komunikasi yang efektif. Green (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa kecemasan pasien sering kali mengarah pada ketidakmampuan untuk menyampaikan keluhan atau perasaan mereka secara jelas.

2. Perasaan Tidak Percaya atau Trauma

Pasien yang pernah mengalami trauma atau merasa tidak percaya kepada sistem perawatan kesehatan juga cenderung sulit berkomunikasi. Perawat harus peka terhadap kebutuhan emosional pasien dan menciptakan lingkungan yang aman untuk membangun hubungan saling percaya (Green, 2019).

3. Beban kerja dan Burnout pada perawat

Maslach and Leiter (2016) menyatakan bahwa burnout atau kondisi kelelahan fisik, mental dan emosional yang dialami perawat dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara efektif. Purnamasari (2021) menunjukkan bahwa perawat dengan beban kerja tinggi atau jumlah tugas dan tanggungjawab yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu membuat perawat cenderung memiliki waktu terbatas untuk mendengarkan pasien secara mendalam.

D. Hambatan Budaya dan Sosial

Perbedaan budaya dan sosial antara perawat dan pasien dapat menjadi hambatan dalam komunikasi terapeutik. Setiap budaya memiliki norma, nilai, dan cara komunikasi yang berbeda, yang bisa menyebabkan misinterpretasi.

1. Perbedaan Bahasa dan Dialek

Salah satu hambatan terbesar dalam komunikasi terapeutik adalah perbedaan bahasa. Pasien yang tidak berbicara bahasa yang sama dengan perawat akan kesulitan untuk memahami instruksi medis atau untuk mengungkapkan keluhannya. Leininger (2002), dalam teorinya tentang keperawatan transkultural, menekankan pentingnya memahami nilai dan norma budaya pasien untuk meningkatkan komunikasi. Susanto et al. (2019) menemukan bahwa perawat yang tidak memahami nilai budaya lokal, seperti tabu dalam membahas kematian, sering kali menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi dengan pasien.. Adams (2020) menyoroti pentingnya penggunaan penerjemah atau teknologi terjemahan untuk mengatasi masalah bahasa ini.

2. Perbedaan Nilai dan Kepercayaan

Nilai dan kepercayaan budaya juga dapat mempengaruhi komunikasi. Sebagai contoh, dalam beberapa budaya, berbicara tentang penyakit tertentu atau kematian dianggap tabu. Adams (2020) mencatat bahwa stigma sosial terhadap penyakit seperti HIV/AIDS dapat menghambat pasien untuk berbicara secara terbuka. Perawat perlu menghindari kesalahan dalam pendekatan terhadap pasien dengan latar belakang budaya yang berbeda dan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan budaya pasien. Rahman (2019) menemukan bahwa stigma ini juga membuat perawat cenderung menjaga jarak emosional dari pasien, sehingga mengurangi efektivitas komunikasi.

E. Hambatan Lingkungan

Lingkungan fisik di sekitar perawat dan pasien dapat mempengaruhi komunikasi terapeutik. Ruang yang sempit, bising, atau kurangnya privasi dapat menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi.

1. Gangguan dari Lingkungan

Johnson et al. (2021) menyoroti bahwa lingkungan rumah sakit yang bising atau kurangnya ruang privat dapat mengganggu komunikasi antara perawat dan pasien. Suara bising di rumah sakit, interupsi yang sering, atau ruang yang tidak nyaman dapat mengalihkan perhatian baik perawat maupun pasien, dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam komunikasi dan membuat pasien merasa diabaikan. Utami et al. (2020) mencatat bahwa pasien di rumah sakit umum sering merasa tidak nyaman berbicara tentang masalah pribadi karena ruangan yang tidak memadai.

2. Keterbatasan Aksesibilitas & Sumber Daya

Selain itu, keterbatasan aksesibilitas fisik bagi pasien dengan disabilitas atau pasien lansia juga dapat menjadi hambatan dalam komunikasi. Perawat perlu memastikan bahwa lingkungan mendukung interaksi yang nyaman dan produktif (Johnson et al., 2021). Penelitian oleh Parker dan Smith (2018) menunjukkan bahwa keterbatasan waktu dan staf di rumah sakit dapat mengurangi interaksi terapeutik. Di Indonesia, Fauziah (2020) menemukan bahwa kekurangan tenaga keperawatan menyebabkan perawat lebih fokus pada tugas teknis daripada membangun hubungan dengan pasien.

F. Hambatan Teknologi

Seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi terapeutik semakin banyak dilakukan secara daring melalui telemedicine atau konsultasi digital. Meskipun teknologi dapat meningkatkan akses layanan kesehatan, ada beberapa

tantangan yang muncul Ketika teknologi dapat menjadi alat yang sangat membantu dalam komunikasi terapeutik, tetapi juga dapat menciptakan hambatan jika tidak digunakan dengan tepat.

1. Kurangnya Interaksi Langsung

Komunikasi terapeutik yang dilakukan secara digital, seperti konsultasi video atau melalui aplikasi pesan, dapat mengurangi elemen sentuhan personal dan empati yang biasanya terjadi dalam pertemuan langsung (Bani Issa et al., 2021).

2. Keterbatasan Komunikasi Nonverbal

Ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan kontak mata adalah elemen penting dalam komunikasi terapeutik. Dalam komunikasi berbasis teknologi, elemen ini sering hilang atau tidak dapat ditangkap dengan baik, yang bisa menyebabkan kesalahpahaman antara pasien dan tenaga medis (Shen et al., 2022).

3. Masalah Teknologi dan Aksesibilitas

Tidak semua pasien memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi digital. Hambatan seperti keterbatasan internet, kurangnya perangkat yang memadai, dan rendahnya literasi digital dapat menghalangi komunikasi yang efektif (Kruse et al., 2018).

4. Keamanan dan Privasi Data

Penggunaan teknologi dalam komunikasi terapeutik meningkatkan risiko kebocoran data pribadi pasien. Jika sistem keamanan tidak kuat, informasi medis yang bersifat rahasia dapat disalahgunakan (Bansal et al., 2020).

5. Kurangnya Pelatihan bagi Tenaga Medis

Tidak semua tenaga kesehatan terlatih dalam menggunakan teknologi komunikasi terapeutik. Kurangnya keterampilan teknis dapat menyebabkan pelayanan yang kurang optimal dan pengalaman pasien yang tidak memuaskan (Mair et al., 2019).

6. Penggunaan Teknologi yang Tidak Tepat

Penggunaan perangkat komunikasi yang rumit atau aplikasi medis yang tidak dapat diakses oleh pasien dapat membatasi efektivitas komunikasi. Johnson et al. (2021) mencatat bahwa meskipun teknologi dapat meningkatkan efisiensi, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi tanpa interaksi manusia dapat mengurangi hubungan interpersonal yang penting dalam perawatan pasien.

G. Latihan Soal

Pilihan Ganda

1. Seorang perawat sedang berbicara dengan pasien lansia yang baru didiagnosa diabetes. Saat pasien bertanya tentang pola makan yang harus dijalani, perawat menjawab dengan istilah medis yang kompleks: "Bapak harus menerapkan diet rendah glikemik dengan kontrol ketat terhadap asupan karbohidrat sederhana dan lemak trans, agar kadar HbA1c tetap stabil." Pasien tampak bingung dan tidak menanggapi. Apa hambatan komunikasi yang terjadi dalam situasi ini?
 - A. Perawat terlalu banyak menggunakan bahasa tubuh
 - B. Pasien mengalami gangguan psikologis
 - C. Perawat menggunakan istilah yang sulit dipahami pasien
 - D. Lingkungan yang terlalu ramai mengganggu pemahaman pasien
 - E. Pasien mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi komunikasi

2. Seorang pasien dengan kecemasan tinggi sedang berbicara dengan perawat mengenai prosedur operasi yang akan dijalankan. Saat pasien berbicara, perawat hanya sesekali mengangguk tanpa kontak mata, sambil melihat ke layar komputer. Pasien menjadi ragu untuk melanjutkan percakapan dan terlihat semakin gelisah. Apa hambatan komunikasi yang terjadi dalam situasi ini?
 - A. Pasien mengalami gangguan psikologis yang berat
 - B. Perawat tidak memberikan perhatian penuh secara nonverbal
 - C. Perawat terlalu banyak menggunakan istilah medis
 - D. Pasien berasal dari budaya yang berbeda sehingga sulit berkomunikasi
 - E. Teknologi yang digunakan perawat menghalangi komunikasi

3. Seorang pasien yang baru didiagnosis kanker merasa putus asa dan menolak berbicara dengan perawat tentang pengobatan lebih lanjut. Ketika perawat mencoba menjelaskan opsi perawatan, pasien menjawab dengan nada datar, "Tidak ada gunanya lagi. Saya pasti tidak akan sembuh." Apa hambatan komunikasi yang terjadi dalam situasi ini?
 - A. Hambatan psikologis karena pasien mengalami keputusasaan
 - B. Hambatan verbal karena pasien tidak memahami informasi medis
 - C. Hambatan lingkungan karena ruangan tidak mendukung komunikasi
 - D. Hambatan teknologi karena pasien tidak bisa mengakses informasi digital
 - E. Hambatan budaya karena perbedaan keyakinan antara pasien dan perawat

4. Seorang perawat pria berusaha melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien wanita dari budaya konservatif yang tidak terbiasa berbicara langsung dengan lawan jenis. Pasien tampak enggan berbicara, hanya menjawab singkat, dan sering menundukkan pandangan. Apa hambatan komunikasi yang terjadi dalam situasi ini?
 - A. Hambatan teknologi karena pasien tidak paham cara menggunakan alat komunikasi
 - B. Hambatan verbal karena pasien tidak memahami bahasa perawat
 - C. Hambatan budaya karena adanya perbedaan norma sosial
 - D. Hambatan psikologis karena pasien mengalami kecemasan berlebihan
 - E. Hambatan lingkungan karena ruang konsultasi terlalu bising
5. Seorang perawat sedang melakukan sesi edukasi kesehatan dengan seorang pasien di ruang tunggu rumah sakit. Namun, suara televisi yang keras dan lalu-lalang orang di sekitar membuat pasien sering meminta perawat mengulangi informasi yang disampaikan. Apa hambatan komunikasi dalam situasi ini?
 - A. Hambatan verbal karena pasien tidak memahami istilah medis
 - B. Hambatan lingkungan karena kebisingan mengganggu komunikasi
 - C. Hambatan psikologis karena pasien mengalami stres
 - D. Hambatan budaya karena pasien berasal dari latar belakang berbeda
 - E. Hambatan teknologi karena pasien tidak terbiasa dengan alat komunikasi

Essay 5 Soal

1. Bagaimana cara perawat dapat mengatasi hambatan verbal dalam komunikasi terapeutik dengan pasien tersebut? Jelaskan dengan contoh konkret?
2. Bagaimana pengaruh hambatan nonverbal dalam komunikasi terapeutik terhadap hubungan perawat dan pasien? Berikan contoh strategi yang dapat digunakan perawat untuk meningkatkan komunikasi nonverbal yang efektif
3. Bagaimana perawat dapat mengatasi hambatan psikologis dalam komunikasi terapeutik dengan pasien yang mengalami keputusasaan? Jelaskan pendekatan yang dapat digunakan dalam situasi ini
4. Bagaimana perawat dapat mengatasi hambatan budaya dan sosial dalam komunikasi terapeutik? Jelaskan pentingnya memahami latar belakang budaya pasien dalam memberikan perawatan yang efektif
5. Bagaimana cara perawat mengatasi hambatan lingkungan dalam komunikasi terapeutik agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pasien?

Kunci Jawaban

1. C
2. B
3. A
4. C
5. B

H. Rangkuman Materi

Hambatan dalam komunikasi terapeutik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara verbal, nonverbal, psikologis, budaya, lingkungan, maupun teknologi. Untuk mengatasi hambatan ini, perawat/tenaga kesehatan perlu meningkatkan keterampilan komunikasi, bersikap empati, dan menyesuaikan pendekatan sesuai dengan kebutuhan pasien. Komunikasi terapeutik adalah interaksi antara perawat/tenaga kesehatan dan pasien yang bertujuan untuk membantu pasien memahami kondisi kesehatannya, mengatasi emosinya, dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, berbagai hambatan dapat muncul dalam proses komunikasi ini. Berikut adalah beberapa jenis hambatan dalam komunikasi terapeutik beserta contoh atau ilustrasinya. Hambatan terjadi ketika pesan yang disampaikan tidak dapat dipahami dengan baik karena penggunaan bahasa yang tidak sesuai, terlalu teknis, atau tidak jelas. Seorang perawat menjelaskan kepada pasien tentang prosedur operasi dengan istilah medis yang kompleks contohnya seorang bapak akan menjalani prosedur laparoskopi dengan anastomosis usus untuk mengatasi obstruksi parsial. Pasien tampak bingung karena tidak memahami istilah yang disampaikan. Keadaan seperti ini dapat menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti; Pastikan pasien benar-benar memahami informasi dengan meminta mereka mengulangi dalam kata-kata mereka sendiri dan menggunakan analogi yang mudah dipahami pasien. Selain diatas hambatan juga terjadi ketika bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau gerakan nonverbal tenaga kesehatan tidak mendukung pesan yang disampaikan. Seperti Seorang pasien yang cemas bertanya kepada perawat tentang efek samping obat, tetapi perawat tidak melakukan kontak mata, bersedekap, dan hanya mengangguk tanpa memberikan respons verbal. Pasien merasa perawat tidak peduli dan enggan melanjutkan percakapan sehingga yang mesti dilakukan adalah gunakan kontak mata yang wajar untuk menunjukkan perhatian; perlihatkan ekspresi wajah yang ramah dan empati dan gunakan gestur yang mendukung, seperti mengangguk atau menyentuh bahu pasien dengan lembut. Hambatan psikologis juga menjadi hambatan ketika pasien mengalami kondisi emosional tertentu, seperti kecemasan, ketakutan, stres, atau depresi, yang menghalangi mereka untuk menerima atau memahami informasi dengan baik.

Menghadapi keadaan ini, perawat harus bersikap empati dan mendengarkan tanpa menghakimi; memberikan dukungan emosional sebelum memberikan informasi medis dan menggunakan teknik refleksi dan validasi perasaan pasien sebelum melanjutkan komunikasi. Hambatan ini muncul karena perbedaan budaya, adat, keyakinan, atau norma sosial yang mempengaruhi cara pasien dan tenaga kesehatan berkomunikasi. Sebagai Solusi dalam menghadapi keadaan ini perawat mesti memahami dan menghormati budaya serta kebiasaan pasien; menyesuaikan pendekatan komunikasi sesuai dengan latar belakang pasien dan Jika memungkinkan, menyediakan tenaga kesehatan yang sesuai dengan preferensi pasien

I. Glosarium

Komunikasi Terapeutik: Interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien yang bertujuan untuk membantu pasien memahami kondisi kesehatannya, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kesejahteraan..

Hambatan Verbal: Kendala dalam komunikasi yang disebabkan oleh penggunaan bahasa yang sulit dipahami, seperti istilah medis yang kompleks atau kalimat yang terlalu panjang

Hambatan Non Verbal: Gangguan dalam komunikasi yang terjadi karena penggunaan bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau gerakan yang tidak sesuai sehingga menghambat pemahaman pesan

Hambatan Psikologis: Hambatan komunikasi yang muncul akibat faktor emosional atau mental pasien, seperti kecemasan, ketakutan, stres, atau depresi, yang menghalangi penerimaan informasi

Hambatan Budaya dan Sosial: Kesulitan dalam komunikasi akibat perbedaan budaya, norma sosial, atau keyakinan yang mempengaruhi cara individu berinteraksi dan menerima informasi

Hambatan Lingkungan: Faktor eksternal yang mengganggu komunikasi, seperti kebisingan, pencahayaan yang buruk, atau ruang yang tidak kondusif untuk percakapan

Hambatan Teknologi: keluarnya feses secara tidak sengaja melalui anus atau ketidakmampuan untuk mengendalikan pengeluaran isi usus Kendala yang muncul akibat kurangnya pemahaman atau akses terhadap alat komunikasi digital, seperti aplikasi kesehatan, telemedicine, atau rekam medis elektronik

Empati: Kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi serta perspektif orang lain, yang penting dalam komunikasi terapeutik untuk membangun hubungan yang baik dengan pasien

.Refleksi Teknik komunikasi di mana tenaga kesehatan mengulangi atau merangkum perkataan pasien untuk memastikan pemahaman dan menunjukkan bahwa mereka didengarkan.

Validasi: Teknik komunikasi yang bertujuan mengakui dan menghargai perasaan atau pengalaman pasien agar mereka merasa dihormati dan dipahami.

Istilah Medis: Kosakata atau jargon yang digunakan dalam dunia medis yang sering kali sulit dipahami oleh pasien dan dapat menjadi hambatan komunikasi jika tidak dijelaskan dengan baik.

Komunikasi Efektif : Pertukaran informasi yang jelas, terbuka, dan sesuai dengan kebutuhan pasien agar pesan dapat diterima dan dipahami dengan baik.

Komunikasi Nonverbal : Bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, seperti kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan nada suara, yang dapat memperkuat atau menghambat pesan verbal.

Kecemasan : Perasaan gelisah atau khawatir yang dapat mempengaruhi penerimaan dan pemahaman informasi dalam komunikasi terapeutik.

Telemedicine : Layanan kesehatan yang dilakukan secara jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi, seperti konsultasi video, yang dapat menghadapi hambatan jika pasien tidak terbiasa dengan teknologi.

Adaptasi Budaya : Kemampuan tenaga kesehatan untuk menyesuaikan pendekatan komunikasi dengan latar belakang budaya pasien agar lebih efektif.

Linguistik : Studi tentang bahasa dan struktur komunikasi yang dapat membantu dalam memahami hambatan verbal dalam komunikasi terapeutik.

Kompetensi Interkultural : Kemampuan tenaga kesehatan untuk memahami dan menghormati perbedaan budaya pasien agar komunikasi dapat berjalan dengan baik.

Gangguan Perhatian : Kondisi di mana pasien atau tenaga kesehatan sulit fokus dalam komunikasi akibat gangguan lingkungan atau faktor psikologis.

Aksesibilitas Teknologi : Ketersediaan dan kemudahan penggunaan alat digital dalam komunikasi terapeutik, yang dapat menjadi hambatan jika pasien memiliki keterbatasan dalam memahami atau menggunakan teknologi.

J. Daftar Pustaka

- Adams, R. (2020). *Cultural competence in healthcare: A guide for nurses*.
- Anzani, D., et al. (2020). *Barriers to effective communication in nursing: Language and cultural differences*. **Journal of Communicology**, **14**(3), 45–52.
- Bani Issa, W., Al Akour, I., Al Dhaheri, F., & Al Blooshi, N. (2021). Nurses' use of therapeutic communication skills in remote consultations: Challenges and opportunities. **Journal of Clinical Nursing**, **30**(5-6), 789–799. <https://doi.org/10.1111/jocn.15688>
- Bansal, G., Zahedi, F. M., & Gefen, D. (2020). Privacy and security concerns in digital health: A review and research agenda. **Health Informatics Journal**, **26**(3), 2135–2152. <https://doi.org/10.1177/1460458219886357>
- Fauziah, S. (2020). *Keterbatasan sumber daya dalam komunikasi keperawatan*.
- Green, L. (2019). *Psychological barriers to effective communication in nursing*.
- Irawandi, S., et al. (2024). *Cultural understanding in therapeutic communication: A study on Indonesian nurses*. **Journal of Social Medicine**, **8**(1), 89–95.
- Johnson, S., Brown, T., & Davis, M. (2021). *The impact of the environment on therapeutic communication*.
- Kruse, C. S., Krowski, N., Rodriguez, B., Tran, L., Vela, J., & Brooks, M. (2018). Telehealth and patient satisfaction: A systematic review and narrative analysis. **BMJ Open**, **8**(8), e025733. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-025733>
- Latifah, A. (2024). *Stress and workload among nurses as barriers to therapeutic communication*. **Journal of Clinical Nursing Management**, **11**(2), 34–41.
- Leininger, M. (2002). *Transcultural nursing theory*.
- Mair, F. S., May, C. R., O'Donnell, C., Finch, T., Sullivan, F., & Murray, E. (2019). Factors that promote or inhibit the implementation of e-health systems: A systematic review. **Bulletin of the World Health Organization**, **97**(3), 188–198. <https://doi.org/10.2471/BLT.18.217422>

- Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. **Journal of Occupational Behavior**, 2(2), 99–113. Retrieved from <https://etheses.iainkediri.ac.id/1987/3/933401815%20bab2.pdf>
- Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). *Burnout in healthcare professions*.
- Nugroho, T., et al. (2020). *Stress management for effective nursing communication in Indonesia*.
- Shen, Y., Choe, E. K., Ram, S., & Faiola, A. (2022). Understanding the impact of telemedicine on nonverbal communication in therapeutic settings. **Journal of Medical Internet Research**, 24(3), e27358. <https://doi.org/10.2196/27358>
- Smith, J., & Jones, M. (2018). *The impact of medical jargon on patient understanding*.
- Sukmandari, T. (2020). *The role of therapeutic communication training in improving nurse-patient interaction*. **Journal of Nursing Practice**, 5(4), 120–130.
- Susanto, T., et al. (2019). *Cultural sensitivity in Indonesian nursing practices*.
- Utami, R., et al. (2020). *Environmental factors affecting nurse-patient communication in Indonesia*.

BAB 5

TAHAP – TAHAP DALAM KOMUNIKASI TERAPEUTIK

Tujuan Instruksional:

Tujuan instruksional pada pembelajaran bab ini adalah: Mampu menjelaskan tahapan dalam komunikasi terapeutik dan mendemonstrasikan tahapan komunikasi terapeutik.

Capaian Pembelajaran:

Capaian pembelajaran pada pembelajaran bab ini adalah:

1. Menjelaskan definisi komunikasi terapeutik.
2. Menjelaskan tujuan komunikasi terapeutik.
3. Mengidentifikasi prinsip-prinsip komunikasi terapeutik.
4. Mengidentifikasi tahap-tahap komunikasi terapeutik.
5. Memahami tahapan dalam komunikasi terapeutik.

Pendahuluan

Komunikasi Terapeutik (Kom-Ter) adalah bagian penting dari keperawatan. Komunikasi terapeutik bertujuan untuk membantu pasien dalam proses penyembuhan fisik dan mental. Perawat tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menjadi pendengar yang aktif dan empatik dan membantu pasien memahami pikiran, perasaan, dan kebutuhan mereka.

Keterampilan mendengarkan yang efektif, kemampuan untuk membaca bahasa non-verbal, dan penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas adalah bagian dari proses komunikasi terapeutik. Melalui komunikasi yang efektif, perawat dapat membangun hubungan saling percaya dengan pasien, yang sangat penting untuk keberhasilan terapi dan perawatan.

Komunikasi terapeutik juga membantu pasien mengurangi kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian yang mungkin mereka alami selama perawatan medis. Ini membantu pasien merasa lebih nyaman dan aman, dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses penyembuhan.

Oleh karena itu, pemahaman dan penggunaan komunikasi terapeutik sangat penting untuk meningkatkan pelayanan keperawatan dan kesejahteraan pasien secara keseluruhan.

Uraian Materi

A. Komunikasi Terapeutik

Komunikasi terapeutik adalah suatu pengalaman yang dilakukan oleh perawat dan pasien dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah pasien. Komunikasi adalah kunci dalam hubungan perawat-pasien. Komunikasi terapeutik sangat penting dalam keperawatan, terutama dalam kesehatan mental dan psikososial. Untuk membantu pasien mengatasi masalah sosial, emosional, atau psikologis mereka dengan cara yang lebih sehat, perawat dan pasien harus membangun hubungan yang saling mendukung.

Hubungan terapeutik didefinisikan sebagai pengalaman belajar antara perawat dan pasien yang terdiri dari empat tindakan yang harus dilakukan antara perawat dan pasien, yaitu:

1. Tindakan awal perawat;
2. Respon reaksi pasien;
3. Interaksi di mana perawat dan pasien mempelajari kebutuhan dan tujuan;
4. Transaksi di mana hubungan timbal balik dibangun untuk mencapai tujuan hubungan.

Perawat dapat membangun hubungan yang positif dengan pasien dan mendukung proses penyembuhan mereka melalui komunikasi terapeutik yang efektif. Komunikasi terapeutik juga melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, memvalidasi perasaan pasien, dan memberikan dukungan emosional dan psikologis.

B. Tujuan Komunikasi Terapeutik

1. Membangun hubungan saling percaya antara perawat dan pasien.
2. Meningkatkan pemahaman pasien tentang kondisi kesehatan mental atau fisiknya.
3. Mendukung proses penyembuhan dengan mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri.
4. Membantu pasien mengeksplorasi perasaan dan pikiran yang mungkin sulit diungkapkan.
5. Memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pasien untuk berbicara secara terbuka.

C. Prinsip Komunikasi Terapeutik

Prinsip-prinsip komunikasi terapeutik adalah pedoman yang membantu tenaga kesehatan, khususnya perawat, berinteraksi secara efektif dengan pasien mereka. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa komunikasi yang terjadi bersifat profesional, empatik, dan mendukung proses penyembuhan pasien. Berikut ini prinsip-prinsip dalam melakukan komunikasi terapeutik:

1. Empati:

Empati merupakan kemampuan untuk menerima dan memahami perasaan pasien dari sudut pandang mereka. Perawat dalam komunikasi terapeutik tidak hanya mendengarkan pasien tetapi juga memahami emosinya tanpa menghukum.

Contoh komunikasi terapeutik dari prinsip empati seperti: "Saya bisa memahami betapa sulitnya situasi ini bagi Anda".

2. Keaslian (Genuineness)

Perawat harus berkomunikasi dengan pasien secara jujur dan tulus. Kejujuran membuat pasien lebih percaya diri dan mengurangi kecemasan mereka. Perawat tidak boleh bertindak seolah-olah mereka peduli. Contoh komunikasi terapeutik dari prinsip keaslian ini seperti: Menunjukkan ketulusan melalui bahasa tubuh yang mendukung, seperti kontak mata, anggukan, atau ekspresi wajah yang tepat.

3. Respek (Respect)

Perawat menghormati pasien sebagai individu tanpa mempertimbangkan masalah sosial, budaya, atau kesehatan mereka. Menghormati pasien juga berarti menghormatinya selama komunikasi berlangsung.

Contoh komunikasi terapeutik dari prinsip respek seperti: jangan menggunakan sikap yang menghakimi atau bahasa yang merendahkan.

4. Konfidensialitas (Confidentiality)

Informasi yang diberikan pasien harus disimpan. Kecuali dalam hal informasi diperlukan untuk kepentingan keselamatan pasien atau orang lain. Salah satu contohnya adalah, "Informasi yang Anda bagikan kepada saya akan tetap rahasia, kecuali jika saya harus membagikannya untuk keselamatan Anda."

5. Fokus pada Pasien (Patient-Centered)

Komunikasi harus berpusat pada pasien, bukan pada perawat atau orang lain. Ini berarti mendengarkan pasien dengan hati-hati dan membantu mereka memahami dan mengungkapkan perasaan mereka. Untuk melakukan ini, berikan pasien waktu untuk berbicara tanpa terganggu dan fokus pada masalah yang mereka bicarakan.

6. Mendengarkan Aktif (Active Listening)

Mendengarkan aktif berarti mendengarkan pasien selain mendengarkan bahasa tubuh, nada suara, dan emosi yang diungkapkan. Ini menunjukkan bahwa perawat benar-benar mendengarkan dan terlibat dalam diskusi. Mempertahankan kontak mata, mengangguk, dan memberi umpan balik seperti, "Ceritakan lebih lanjut" adalah contohnya.

7. Klarifikasi dan Validasi

Klarifikasi dan validasi memastikan bahwa perawat memahami perasaan pasien. Ini penting untuk menghindari salah pengertian. Contoh validasi: "Saya bisa melihat bahwa situasi ini sangat membuat Anda cemas". Contoh klarifikasi: "Apakah yang Anda maksudkan adalah bahwa Anda merasa tertekan setiap hari?"

8. Batasan Profesional (Professional Boundaries)

Hubungan terapeutik harus tetap profesional agar tidak melibatkan hal-hal pribadi. Perawat harus mampu mengelola hubungan tanpa terlibat secara pribadi atau emosional. Contoh komunikasi terapeutiknya seperti tidak memberikan informasi pribadi atau bertindak di luar tugas perawat secara profesional.

9. Komunikasi Verbal dan Non-Verbal

Dalam melakukan interaksi perawat harus memperhatikan bahasa non-verbal dan verbal pasien. Postur tubuh, kontak mata, dan ekspresi wajah sering kali memiliki makna yang lebih besar daripada kata-kata yang diucapkan. Sebagai contoh, pasien mungkin merasa tidak diperhatikan jika perawat mengatakan, "Saya peduli dengan Anda," tetapi tidak menunjukkan ekspresi wajah yang mendukung.

10. Kesabaran dan Toleransi

Saat bertemu dengan pasien yang mungkin lambat untuk mengungkapkan perasaannya atau yang mengalami kesulitan untuk memahami informasi, perawat harus bersabar. Dalam menghadapi masalah, toleransi adalah penting untuk menghormati perbedaan individu. Contoh komunikasi terapeutik dari prinsip ini seperti: Beri pasien waktu yang cukup untuk menceritakan perasaannya tanpa terburu-buru.

11. Pemberdayaan (Empowerment)

Pemberdayaan berarti mendorong pasien untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyembuhan dengan membantu mereka menemukan kekuatan dan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah. Hal ini dapat meningkatkan keyakinan pasien untuk sembuh dan semangat menjalani perawatan.

Contoh komunikasi terapeutik dari prinsip ini seperti katakan: "Saya tahu

Anda mampu mengatasi tantangan ini".
"Apa yang bisa kita lakukan bersama?"

D. Tahapan Komunikasi Terapeutik

Tahapan komunikasi terapeutik merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh tenaga kesehatan, seperti perawat, dalam upaya membangun hubungan yang saling mendukung dengan klien atau pasien. Tahapan komunikasi terapeutik bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental dan emosional pasien melalui interaksi yang penuh empati, mendengarkan, dan memberikan dukungan. Berikut tahap-tahap dalam komunikasi terapeutik perawat – pasien:

1. Tahap Pra - Interaksi

Pada tahap ini, perawat mempersiapkan dirinya secara fisik, mental, dan emosional untuk melakukan interaksi terapeutik sebelum bertemu pasien. Perawat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pasien dengan mengumpulkan informasi tentang kondisi medis pasien, riwayat medis pasien, dan latar belakang mereka. Pada tahap ini, perawat juga harus berpikir secara pribadi dan mempertimbangkan kemungkinan bias atau prasangka.

Tahap pra - interaksi adalah tahap persiapan perawat sebelum bertemu pasien. Perawat melihat riwayat medis pasien, melihat catatan pasien, dan mempersiapkan diri secara mental dan emosional. Perawat juga perlu refleksi diri untuk memastikan bahwa interaksi tidak terganggu oleh prasangka.

Tujuan dari tahap pra-interaksi ini adalah membantu perawat membuat rencana untuk menangani masalah pasien dan mengantisipasi respons emosional atau masalah yang mungkin muncul selama komunikasi.

Tahap Pra-Interaksi memiliki ciri-ciri:

- a. Pengumpulan Informasi: Perawat mendapatkan informasi tentang pasien dari berbagai sumber, termasuk catatan medis, hasil wawancara sebelumnya, dan laporan dari tim perawatan lain. Ini membantu perawat belajar tentang riwayat medis pasien, kondisi medis, dan kebutuhan khusus.
- b. Persiapan Emosional dan Intelektual: Perawat mempersiapkan diri untuk menghadapi pasien secara profesional dengan mempertahankan emosi dan pikiran yang positif agar siap memberikan dukungan yang tepat. Ini sangat penting untuk mengurangi kecemasan atau bias yang mungkin muncul sebelum melihat pasien.
- c. Penetapan Tujuan: Dalam interaksi terapeutik, perawat menetapkan tujuan yang jelas, termasuk tujuan yang berkaitan dengan perawatan pasien dan tujuan yang ingin dicapai selama hubungan terapeutik.

Tantangan dalam Tahap Pra-Interaksi adalah tantangan yang dihadapi oleh perawat sebelum bertemu dengan pasien secara langsung. Pada tahap ini, perawat mempersiapkan diri untuk interaksi terapeutik yang akan datang. Berikut adalah beberapa tantangan umum yang mungkin dihadapi selama tahap pra-interaksi:

a. Kekhawatiran tentang Kesiapan:

Perawat mungkin khawatir tentang kesiapan mereka untuk merawat pasien dengan berbagai masalah atau kondisi yang sulit. Untuk itu perawat harus memberikan kepastian bahwa informasi yang dikumpulkan tentang pasien akurat dan relevan. Sebelum bertemu dengan pasien, perawat dapat mengurangi kecemasan dengan mempelajari teknik komunikasi terapeutik dan penanganan masalah.

b. Mengatasi Persepsi atau Stereotip:

Berdasarkan informasi atau pengalaman sebelumnya, perawat mungkin memiliki prasangka atau stereotip tentang pasien. Ini dapat memengaruhi bagaimana perawat mempersiapkan diri untuk interaksi. Hal yang dapat dilakukan perawat adalah dengan membangun kesadaran diri dan refleksi terhadap prasangka yang mungkin ada sangat penting. Berusaha untuk mendekati setiap pasien dengan ramah dan tanpa penilaian awal.

c. Mengendalikan Ekspektasi Pribadi:

Perawat mungkin memiliki harapan atau ekspektasi tertentu tentang bagaimana interaksi dengan pasien akan berjalan. Ini dapat memengaruhi persiapan mereka dan interaksi mereka dengan pasien. Hal yang dilakukan perawat adalah tetap jadikan harapan realistis dan fokus pada tujuan terapi yang ditetapkan bersama pasien. Ingatlah bahwa setiap pasien adalah unik dan proses komunikasi harus fleksibel.

d. Pengumpulan Data yang Berhasil:

Mengumpulkan informasi tentang pasien yang relevan dan akurat mungkin sulit, terutama jika catatan medis tidak lengkap atau informasi sulit diakses. Hal yang dapat dilakukan perawat adalah: Menggunakan berbagai sumber informasi yang tersedia dan memastikan bahwa catatan yang ada diperbarui dan tepat. Jika ada kekurangan informasi, perawat harus siap untuk mencari informasi tambahan atau mengklarifikasinya saat bertemu dengan pasien.

e. Persiapan Emosional:

Perawat mungkin merasa cemas atau tidak siap secara emosional untuk menghadapi masalah pasien, terutama jika pasien memiliki kondisi emosional atau psikologis yang kompleks. Melakukan refleksi pribadi dan pengelolaan stres sebelum interaksi dan menerima dukungan dari rekan kerja atau mentor

untuk membahas kekhawatiran dan mendapatkan saran merupakan solusi yang dapat dilakukan perawat.

f. Penentuan Batasan Profesional:

Menetapkan batasan yang jelas dan menjaga batasan profesional sebelum bertemu dengan pasien bisa menjadi tantangan, terutama dalam kasus di mana hubungan sebelumnya mungkin memengaruhi dinamika. Hal yang dapat dilakukan perawat dengan memahami dan menetapkan batasan profesional sejak awal, dan berkomunikasi dengan jelas tentang batasan tersebut dengan pasien. Mengikuti pedoman etika dan kebijakan organisasi terkait hubungan profesional.

2. Tahap Orientasi

Pada tahap ini, pasien dan perawat pertama kali bertemu. Melalui komunikasi yang jujur, penuh empati, dan memperhatikan kebutuhan pasien, perawat mulai menemukan masalah atau kekhawatiran utama

pasien dan membangun kepercayaan. Ini adalah tahap awal dalam membangun hubungan antara perawat dan pasien. Pada tahap ini, perawat memperkenalkan diri, menjelaskan peran dan tujuan mereka, dan memulai interaksi awal dengan pasien.

Kegiatan dalam tahapan orientasi diantaranya:

- a. Mengenalkan diri kepada pasien dan menjelaskan tujuan pertemuan;
- b. Mencapai kesepakatan tentang tujuan perawatan dan interaksi;
- c. Membantu pasien merasa nyaman dan percaya dengan perawat;
- d. Menemukan masalah utama pasien dan mengapa mereka memerlukan perawatan.

Karakteristik Tahap Orientasi:

- a. Pembentukan Hubungan Saling Percaya: Pada tahap ini, perawat berusaha membangun kepercayaan dengan pasien. Perawat memperkenalkan diri, menjelaskan peran, serta mendiskusikan batasan dan tujuan perawatan.
- b. Identifikasi Masalah: Perawat mengajak pasien untuk mengidentifikasi masalah utama yang mereka alami. Melalui komunikasi yang terbuka, perawat berusaha memahami kebutuhan, harapan, dan kekhawatiran pasien.
- c. Penentuan Kontrak: Dalam komunikasi terapeutik, kontrak biasanya ditetapkan dalam bentuk kesepakatan waktu, frekuensi pertemuan, serta batasan profesional. Kontrak ini memberikan struktur yang jelas pada interaksi antara perawat dan pasien.
- d. Membangun Keamanan: Perawat memastikan bahwa pasien merasa aman secara emosional dalam berkomunikasi, mendorong keterbukaan dan kepercayaan.

Tantangan dalam Tahap Orientasi adalah tantangan yang dihadapi oleh perawat dan pasien saat memulai hubungan terapeutik. Pada tahap ini, perawat berusaha membangun dasar hubungan yang kuat dengan pasien dan menetapkan tujuan perawatan. Berikut adalah beberapa tantangan umum yang mungkin dihadapi selama tahap orientasi:

a. **Membangun Kepercayaan**

Membangun kepercayaan antara perawat dan pasien bisa sulit, terutama jika pasien memiliki pengalaman negatif sebelumnya dengan perawatan kesehatan atau merasa curiga terhadap profesional kesehatan. Perawat harus menunjukkan empati, konsistensi, dan kejujuran. Komunikasikan tujuan interaksi secara jelas dan terbuka, serta tunjukkan kepedulian dan dukungan yang tulus.

b. **Mengelola Kecemasan Pasien:**

Pasien sering merasa cemas atau tidak nyaman saat memulai interaksi terapeutik, yang dapat menghambat keterbukaan mereka. Menggunakan teknik relaksasi atau pendekatan yang lembut untuk mengurangi kecemasan pasien. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengajak pasien untuk berbicara secara bertahap dapat membantu.

3. Menetapkan Batasan Profesional:

Menetapkan batasan profesional yang jelas bisa menjadi tantangan, terutama jika pasien mengharapkan hubungan yang lebih personal atau jika perawat merasa kesulitan untuk menegakkan batasan. Diskusikan dan sepakati batasan profesional secara jelas di awal interaksi. Pastikan untuk menjelaskan dengan tegas namun lembut tentang peran, tanggung jawab, dan batasan yang ada dalam hubungan terapeutik.

Mengidentifikasi dan Memahami Masalah Pasien:

Mencapai pemahaman yang jelas tentang masalah atau kekhawatiran pasien bisa sulit, terutama jika pasien merasa sulit untuk mengungkapkan perasaan atau tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah mereka. Gunakan teknik komunikasi yang efektif seperti pertanyaan terbuka dan refleksi. Sabar dan beri waktu kepada pasien untuk mengungkapkan masalah mereka secara detail.

4. Mengatur Ekspektasi:

Perawat dan pasien mungkin memiliki ekspektasi yang berbeda mengenai tujuan dan hasil dari interaksi terapeutik. Ekspektasi yang tidak selaras bisa menghambat proses. Diskusikan dan tetapkan tujuan dan ekspektasi secara bersama-sama dengan pasien. Pastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang ingin dicapai dalam perawatan.

5. Menangani Resistensi atau Penolakan:

Pasien mungkin menunjukkan resistensi atau penolakan terhadap proses terapi atau interaksi dengan perawat, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti rasa malu, ketidakpercayaan, atau keengganan untuk mengubah perilaku. Tanggapi resistensi dengan empati dan pemahaman.

Cari tahu alasan di balik resistensi tersebut dan bicarakan cara-cara untuk mengatasi kekhawatiran atau hambatan pasien.

Menghadapi Dinamika Hubungan Awal:

Dinamika hubungan yang belum sepenuhnya terjalin dapat memengaruhi bagaimana perawat dan pasien berinteraksi. Misalnya, perawat mungkin mengalami tantangan dalam menyesuaikan pendekatan mereka dengan kebutuhan unik pasien. Beradaptasi dengan kebutuhan dan gaya komunikasi pasien. Gunakan pendekatan fleksibel dan peka terhadap sinyal-sinyal yang diberikan oleh pasien.

6. Tahap Kerja

Dalam komunikasi terapeutik, tahap kerja adalah fase di mana perawat dan pasien bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahap orientasi. Tahap ini merupakan bagian penting dari hubungan terapeutik karena di sinilah terjadi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, pasien dan perawat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Perawat membantu pasien mengeksplorasi perasaannya, menghadapi masalah, dan membuat perubahan positif. Ini adalah fase penting dalam terapi, di mana perawat menggunakan berbagai teknik

komunikasi seperti mendengarkan aktif, refleksi, dan klarifikasi. Tujuan utama tahap kerja adalah :

- a. Menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi selama tahap orientasi.
- b. Membuat solusi atau pendekatan yang tepat untuk mencapai tujuan terapi.
- c. Mendorong pasien untuk mengubah sikapnya menjadi positif.
- d. Meningkatkan kesadaran pasien dan kemampuan coping mereka. Tahapan dalam tahap kerja ini terdiri dari:
 - 1) Eksplorasi Masalah: Perawat mendengarkan secara aktif dan mendorong pasien untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah tersebut. Pasien dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kekhawatiran mereka dengan bantuan teknik seperti eksplorasi, refleksi, dan klarifikasi.
Dalam tahap ini, beberapa metode yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a) Refleksi: Mengulangi atau merangkum apa yang dikatakan pasien untuk membantu mereka memahami dan memahami perasaan mereka.
 - b) Klarifikasi: Meminta pasien untuk memberikan lebih banyak informasi agar perawat dapat benar-benar memahami maksud mereka.

- c) Dorongan minimal: Dorong pasien untuk berbicara dengan kata-kata atau isyarat seperti "ya" atau "teruskan".
- 2) Bekerja Sama dalam Pemecahan Masalah: Setelah masalah ditemukan dengan jelas, perawat bekerja sama dengan pasien untuk membuat strategi pemecahan masalah. Perawat tidak memberikan solusi secara langsung, tetapi membantu pasien menemukan jawaban sendiri. Ini membuat pasien lebih terlibat dalam proses penyembuhan dan membuat mereka merasa lebih bertanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri.
- 3) Dukungan dan Validasi: Untuk memastikan bahwa perasaan pasien dihargai dan diakui, perawat memberikan dukungan emosional yang konsisten kepada pasien selama tahap kerja. Membuat pasien merasa didengar dan dipahami juga membantu mengurangi kecemasan.
- 4) Intervensi Terapeutik: Bergantung pada kondisi pasien, perawat mungkin menggunakan intervensi tertentu, seperti teknik manajemen stres, latihan relaksasi, atau membantu pasien belajar keterampilan baru. Intervensi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pasien dan membantu mereka mencapai tujuan kesehatan mereka.

Tahap kerja bisa menjadi fase yang menantang karena pasien mungkin menghadapi hambatan dalam menyelesaikan masalah mereka. Contoh tantangan yang mungkin muncul meliputi:

- a) Resistensi terhadap perubahan: Pasien mungkin enggan mengubah perilaku mereka atau menghadapi kesulitan dalam menerima kenyataan.
- b) Kecemasan yang meningkat: Diskusi mendalam tentang masalah emosional dapat meningkatkan kecemasan pasien, dan perawat perlu tahu bagaimana menanganinya dengan lembut.
- c) Ketergantungan pada perawat: Beberapa pasien mungkin terlalu bergantung pada perawat dan mengalami kesulitan mengembangkan kemandirian.

Ketika tahap kerja berjalan dengan baik, hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- pasien mulai lebih memahami diri mereka sendiri dan mengenali pola perilaku yang merugikan mereka;
- pasien mulai menunjukkan kemajuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi;
- pasien menjadi lebih percaya diri dalam menggunakan strategi coping yang efektif;
- pasien merasakan peningkatan kesejahteraan fisik, emosional, atau sosial.

7. Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan hubungan terapeutik perawat dan pasien berakhir. Perawat dan pasien berbicara tentang apa yang telah mereka lakukan selama proses terapi, dan mereka memberikan penguatan untuk apa yang telah mereka lakukan dengan baik. Perpisahan dilakukan secara positif, dan perawat membantu pasien mengatasi transisi setelah hubungan berakhir.

Tahap Terminasi memiliki karakteristik berikut:

- a. Evaluasi Kemajuan: Perawat melakukan evaluasi bersama pasien tentang kemajuan yang telah dicapai selama hubungan terapeutik. Evaluasi ini mencakup pencapaian tujuan yang telah disepakati, perubahan yang terjadi, dan keberhasilan strategi coping yang telah dibuat.
- b. Penutupan Hubungan: Perawat secara bertahap mengakhiri hubungan mereka dengan pasien. Ini dapat mencakup membahas rencana tindak lanjut pasien atau mengurangi jumlah pertemuan yang dilakukan.
- c. Mempersiapkan Pasien untuk Kemandirian: Pasien diharapkan dapat menerapkan strategi coping yang telah mereka pelajari dan memiliki rencana perawatan lanjutan sebelum terminasi.
- d. Diskusi Tindak Lanjut: Perawat dan pasien berbicara tentang rencana untuk tindak lanjut, seperti rujukan ke perawatan tambahan, sumber dukungan, atau penjadwalan sesi ulang.

Dalam tahapan terminasi terdapat tantangan yang dihadapi saat mengakhiri hubungan terapeutik antara perawat dan pasien. Tahap terminasi penting untuk memastikan bahwa perpisahan dilakukan secara profesional dan pasien siap untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan

atau tanpa dukungan tambahan. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin dihadapi selama tahap terminasi:

- a. Resistensi Terhadap Terminasi

Pasien mungkin mengalami kesulitan menerima kenyataan bahwa hubungan terapeutik akan berakhir. Mereka mungkin merasa cemas atau tidak siap untuk mengakhiri dukungan dari perawat. Diskusikan rencana terminasi dengan pasien jauh sebelum hubungan berakhir untuk mempersiapkan mereka. Tawarkan dukungan emosional dan bantu pasien memahami pencapaian mereka serta rencana tindak lanjut.

- b. Emosi yang Menguat

Baik pasien maupun perawat dapat merasakan emosi seperti kesedihan, kehilangan, atau kekhawatiran saat hubungan terapeutik berakhir. Bicarakan perasaan ini secara terbuka selama proses terminasi. Tawarkan dukungan emosional dan pastikan pasien merasa dihargai serta didengar. Perawat juga

bisa mencari dukungan dari rekan kerja atau supervisor jika merasakan beban emosional.

c. Memastikan Transisi yang Lancar

Mengatur transisi yang mulus dari dukungan terapeutik ke kemandirian pasien bisa sulit, terutama jika pasien memerlukan dukungan tambahan atau layanan berkelanjutan. Bantu pasien menyusun rencana tindak lanjut yang jelas, termasuk informasi tentang sumber daya tambahan, layanan lanjutan, atau rujukan ke profesional lain jika diperlukan. Pastikan pasien memahami bagaimana mengakses dukungan tambahan setelah hubungan berakhir.

d. Menangani Ketergantungan

Beberapa pasien mungkin menjadi terlalu bergantung pada perawat dan merasa sulit untuk melanjutkan tanpa dukungan langsung. Fokus pada pengembangan keterampilan coping dan kemandirian pasien selama fase kerja. Diskusikan secara terbuka tentang pentingnya kemandirian dan bagaimana pasien dapat terus menerapkan strategi yang telah mereka pelajari.

e. Evaluasi dan Ulasan Kemajuan

Menilai kemajuan pasien dan menentukan apakah tujuan perawatan telah tercapai bisa menjadi tantangan, terutama jika ada perbedaan pendapat tentang pencapaian tujuan. Lakukan evaluasi kemajuan bersama dengan pasien dan tinjau pencapaian yang telah dicapai. Diskusikan secara objektif hasil yang diperoleh dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi keputusan untuk mengakhiri hubungan terapeutik dapat dijadikan jalan keluar tantangan ini.

f. Mengatasi Ketidakpastian

Pasien mungkin merasa tidak pasti tentang masa depan mereka setelah hubungan berakhir, terutama jika mereka tidak yakin tentang bagaimana mengatasi tantangan yang ada. Berikan informasi dan strategi konkret tentang bagaimana pasien dapat mengatasi tantangan di masa depan. Diskusikan rencana tindak lanjut dan sumber daya yang tersedia untuk membantu mereka merasa lebih siap.

g. Komunikasi yang Efektif

Menyampaikan bahwa hubungan terapeutik akan berakhir dan mengkomunikasikan langkah-langkah selanjutnya secara efektif bisa sulit. Gunakan komunikasi yang jelas dan empatik saat membahas terminasi. Pastikan bahwa pasien memahami alasan di balik terminasi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melanjutkan perawatan atau dukungan.

E. Latihan Soal

1. Apa tujuan utama dari komunikasi terapeutik?
 - A. Meningkatkan hubungan sosial antara perawat dan pasien
 - B. Mendiagnosis masalah medis pasien
 - C. Membantu pasien mengungkapkan perasaan dan pikiran dengan aman
 - D. Menyampaikan informasi tentang kondisi medis pasien
 - E. Membina hubungan dengan pasien

2. Manakah dari teknik berikut yang TIDAK termasuk dalam komunikasi terapeutik?
 - A. Menyediakan ruang bagi pasien untuk diam
 - B. Menunjukkan empati
 - C. Memberikan informasi secara jujur
 - D. Membandingkan pasien dengan orang lain
 - E. Membantu pasien menyampaikan permasalahan yang dirasakan dengan tenang

3. Pada tahap mana dalam proses komunikasi terapeutik perawat membangun rasa saling percaya dengan pasien?
 - A. Orientasi
 - B. Pra-interaksi
 - C. Kerja
 - D. Terminasi
 - E. Evaluasi

4. Tahap komunikasi mana yang difokuskan pada eksplorasi masalah dan bekerja sama dengan pasien dalam mengembangkan rencana intervensi?
 - A. Orientasi
 - B. Kerja
 - C. Terminasi
 - D. Pra-interaksi
 - E. Evaluasi

5. Apa tujuan utama dari tahap orientasi dalam komunikasi terapeutik?
 - A. Mengakhiri hubungan
 - B. Mengevaluasi kemajuan
 - C. Membangun kepercayaan dan batas-batas
 - D. Memberikan intervensi langsung
 - E. Memulai komunikasi

6. Tahap apa yang terjadi ketika perawat mengakhiri hubungan terapeutik dan pasien diharapkan melanjutkan tanpa dukungan intensif?
 - A. Orientasi
 - B. Kerja
 - C. Terminasi
 - D. Pra-interaksi
 - E. Evaluasi
7. Apa yang menjadi fokus perawat selama tahap pra-interaksi?
 - A. Pengumpulan informasi pasien
 - B. Pemberian instruksi medis
 - C. Pembinaan hubungan saling percaya
 - D. Mengevaluasi keberhasilan intervensi
 - E. Melakukan interaksi
8. Dalam tahap kerja, peran utama perawat adalah?
 - A. Mengakhiri hubungan
 - B. Mendengarkan dengan empati dan membantu pasien mengidentifikasi masalah
 - C. Mengarahkan pasien ke fasilitas lain
 - D. Mengatur jadwal follow-up
 - E. Melakukan tindakan
9. Tahap komunikasi yang mana yang membutuhkan perawat untuk mengevaluasi respons pasien terhadap intervensi?
 - A. Orientasi
 - B. Terminasi
 - C. Evaluasi
 - D. Pra-interaksi
 - E. Kerja
10. Salah satu tanda keberhasilan tahap orientasi adalah?
 - A. Pasien memahami rencana tindakan
 - B. Pasien mulai mengekspresikan perasaannya dengan bebas
 - C. Pasien menunjukkan peningkatan fungsi kognitif
 - D. Pasien siap untuk mengakhiri hubungan terapeutik
 - E. Pasien tidak mau interaksi

11. Apa tujuan utama dari tahap terminasi dalam komunikasi terapeutik?
 - A. Membantu pasien menyelesaikan masalah yang dihadapi
 - B. Mengakhiri hubungan tanpa mengarahkan pasien pada dukungan lebih lanjut
 - C. Menyusun rencana untuk tindak lanjut setelah perawatan berakhir
 - D. Meningkatkan hubungan interpersonal pasien
 - E. Memutus hubungan dengan pasien
12. Tahapan komunikasi apa yang membutuhkan pengembangan strategi untuk mendukung keberhasilan pasien setelah intervensi berakhir?
 - A. Orientasi
 - B. Kerja
 - C. Terminasi
 - D. Evaluasi
 - E. Pra- interaksi

F. Rangkuman Materi

1. Perawat dapat membangun hubungan yang efektif dan mendukung penyembuhan pasien dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi terapeutik untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh empati di mana pasien merasa didengar, dipahami, dan dihargai.
2. Mengatasi tantangan dalam tahap pra-interaksi penting untuk memastikan bahwa perawat siap untuk membangun hubungan terapeutik yang efektif dan mendukung pasien dengan cara yang positif. Persiapan yang baik, refleksi diri, dan pemahaman terhadap batasan profesional dapat membantu perawat mengatasi tantangan ini dan memulai interaksi terapeutik dengan lebih percaya diri dan efektif.
3. Tahap orientasi adalah fase penting di mana hubungan terapeutik mulai dibangun dan fondasi untuk perawatan yang efektif diletakkan. Mengatasi tantangan dalam tahap ini memerlukan keterampilan komunikasi yang baik, kesabaran, dan empati. Dengan pendekatan yang tepat, perawat dapat membantu pasien merasa lebih nyaman dan siap untuk bekerja sama dalam proses perawatan.
4. Tahap kerja adalah fase yang kritis dalam komunikasi terapeutik, di mana perawat dan pasien bekerja sama untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi. Perawat bertindak sebagai pendamping yang mendukung pasien dalam proses penyembuhan, sambil memberikan intervensi yang dibutuhkan. Kunci dari keberhasilan tahap kerja adalah kemampuan perawat untuk berkomunikasi secara empatik, mendukung otonomi pasien, dan memastikan bahwa pasien merasa didengar dan dihargai. Tahap ini menciptakan dasar yang kuat untuk

menuju tahap terminasi, di mana pasien diharapkan siap untuk melanjutkan tanpa dukungan intensif dari perawat.

5. Tahap terminasi adalah fase penting dalam hubungan terapeutik yang memerlukan perhatian dan keterampilan khusus. Mengatasi tantangan dalam tahap ini memerlukan pendekatan yang empatik, komunikasi yang jelas, dan perencanaan yang cermat untuk memastikan bahwa pasien merasa siap untuk melanjutkan dan memiliki dukungan yang dibutuhkan. Dengan mempersiapkan pasien secara menyeluruh dan menyediakan sumber daya tambahan, perawat dapat membantu memastikan bahwa proses terminasi berjalan dengan lancar dan efektif.

G. Glosarium

KomTer : Komunikasi Terapeutik
RTL : rencana tindak lanjut

H. Daftar Pustaka

10th ed. St. Louis: Mosby.

Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2020). *Interpersonal Relationships: Professional Communication Skills for Nurses*. 8th ed. St. Louis: Elsevier.

Boyd, M. A. (2018). *Psychiatric Nursing: Contemporary Practice*. 6th ed.

Doenges, M. E., Moorhouse, M. F., & Murr, A. C. (2019). *Nursing Care Plans: Guidelines for Individualizing Patient Care Across the Life Span*. 10th ed. F.A. Davis.

Philadelphia: Wolters Kluwer.

Sheldon, L. K., & Barrett, R. (2017). *Communication for Nurses: Talking with Patients*. 3rd ed. Jones & Bartlett Learning.

Stuart, G. W., & Laraia, M. T. (2017). *Principles and Practice of Psychiatric Nursing*.

Tamparo C. & Lindh W. Q.(2019). *Effective Communication for Health Professionals - E-Book*. Netherlands: Elsevier Health Sciences.

Varcarolis, E. M., & Halter, M. J. (2018). *Foundations of Psychiatric-Mental Health Nursing: A Clinical Approach*. 8th ed. St. Louis: Elsevier.

Yura, H., & Walsh, M. B. (2015). *The Therapeutic Relationship in Nursing*. New York: Springer Publishing Company.

BAB 6

TEKNIK-TEKNIK KOMUNIKASI TERAPEUTIK

Tujuan Intruksional:

1. Memahami dan menjelaskan pengertian komunikasi terapeutik
2. Memahami dan menjelaskan tujuan komunikasi terapeutik
3. Menunjukkan prinsip dasar komunikasi terapeutik
4. Berkomunikasi menggunakan teknik-teknik komunikasi terapeutik
5. Mengaplikasikan teknik-teknik komunikasi terapeutik dalam berbagai konteks kehidupan

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian komunikasi terapeutik
2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tujuan komunikasi terapeutik

Afektif:

1. Mahasiswa mampu menunjukkan prinsip dasar komunikasi terapeutik
2. Mahasiswa mampu berkomunikasi menggunakan teknik-teknik komunikasi terapeutik

Psikomotor:

1. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik-teknik komunikasi terapeutik dalam berbagai konteks kehidupan

Pendahuluan

Komunikasi terapeutik merupakan salah satu keterampilan penting dalam bidang kesehatan salah satunya keperawatan. Komunikasi terapeutik bertujuan untuk mendukung proses penyembuhan pasien melalui pendekatan empatik dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Komunikasi terapeutik ini dirancang untuk membantu pasien mengatasi masalah emosional, psikologis, maupun fisik dengan menciptakan hubungan yang saling percaya antara tenaga kesehatan dan pasien.

Bab ini akan membahas tentang konsep teknik-teknik komunikasi terapeutik yang terdiri dari pengertian komunikasi terapeutik, tujuan dan prinsip dasar komunikasi terapeutik, teknik-teknik komunikasi terapeutik, dan pengaplikasian komunikasi

terapeutik dalam berbagai konteks kehidupan. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu memahami konsep teknik-teknik komunikasi terapeutik. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi sarjana keperawatan.

Gambaran pembahasan pada Bab ini adalah pengertian komunikasi terapeutik, tujuan dan prinsip dasar komunikasi terapeutik, teknik-teknik komunikasi terapeutik, dan pengaplikasian komunikasi terapeutik dalam berbagai konteks kehidupan. Untuk memberikan gambaran lebih nyata terkait komunikasi terapeutik keperawatan, akan dilengkapi juga dengan studi kasus singkat tentang komunikasi terapeutik keperawatan. Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, latihan studi kasus, dan dilengkapi dengan rangkuman.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari pengertian komunikasi terapeutik, tujuan dan prinsip dasar komunikasi terapeutik, teknik-teknik komunikasi terapeutik, dan pengaplikasian komunikasi terapeutik dalam berbagai konteks kehidupan.

A. Pengertian Komunikasi Terapeutik

Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin yakni *communicatio* yang artinya pemberitahuan atau pertukaran ide. Maksudnya adalah dalam suatu proses komunikasi akan ada pembicara yang menyampaikan pernyataan ataupun pertanyaan yang dengan harapan akan ada timbal balik atau jawaban dari pendengarnya. Terapeutik merupakan suatu hal yang diarahkan kepada proses dalam memfasilitasi penyembuhan pasien. Sehingga komunikasi terapeutik itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari berbagai macam komunikasi yang dilakukan secara terencana dan dilakukan untuk membantu proses penyembuhan pasien (Kurniyawan et al., 2024).

Komunikasi terapeutik adalah bentuk komunikasi interpersonal yang dirancang untuk membantu individu memahami dirinya sendiri, mengatasi masalah, dan meningkatkan kesejahteraan emosional serta mental. Dalam konteks kesehatan, komunikasi terapeutik sering digunakan untuk mendukung proses penyembuhan pasien, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam profesi keperawatan, komunikasi menjadi lebih bermakna karena merupakan metode utama dalam mengimplementasikan proses keperawatan. Kualitas asuhan yang diberikan kepada klien sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan antara perawat dengan klien tersebut (Abraham et al., 2024).

Komunikasi terapeutik melibatkan proses mendengarkan, merespons, dan memberikan umpan balik secara efektif untuk membangun hubungan saling percaya antara praktisi dan klien. Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang dilakukan atau dirancang untuk tujuan terapi kepada pasien. Seorang penolong atau perawat dapat membantu klien mengatasi masalah yang dihadapinya melalui komunikasi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi klien untuk mengungkapkan perasaan atau pikirannya (El-Abidi et al., 2024).

B. Tujuan Komunikasi Terapeutik

Komunikasi terapeutik bertujuan untuk mengembangkan segala yang ada dalam pikiran dan diri pasien ke arah yang lebih positif yang nantinya akan dapat

mengurangi beban perasaan pasien dalam menghadapi maupun mengambil tindakan tentang kesehatannya. Tujuan lain dari komunikasi terapeutik adalah:

1. Meningkatkan realisasi diri, penerimaan diri dan peningkatan penghormatan terhadap diri. Dengan melakukan komunikasi terapeutik pada pasien, perawat diharapkan dapat mengubah cara pandang pasien sehingga pasien dapat lebih menghargai dan menerima dirinya.
2. Kemampuan membina hubungan interpersonal yang tidak superfisial dan saling bergantung dengan orang lain
3. Meningkatkan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan pasien serta mencapai tujuan yang realistik.
4. Menjaga harga diri. Dalam komunikasi yang dilakukan, perawat harus mampu menjaga harga dirinya dan harga diri pasien.
5. Meningkatkan hubungan saling percaya
6. Meningkatkan Hubungan Interpersonal: Komunikasi terapeutik menciptakan hubungan yang sehat antara individu, seperti pasien dan perawat.
7. Mendukung Proses Penyembuhan: Komunikasi ini membantu individu mengelola stres, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan motivasi.
8. Meningkatkan Pemahaman Diri: Membantu individu memahami pikiran dan emosinya secara lebih baik.
9. Membantu Pengambilan Keputusan: Komunikasi terapeutik mendorong individu untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman dirinya
10. Menyampaikan ide/ informasi/ berita. Komunikasi yang dilakukan perawat kepada klien untuk menjelaskan kondisi klien setelah pengkajian, menyampaikan diagnosis keperawatan yang ditegakkan, rencana tindakan yang akan dilakukan, prosedur tindakan yang akan dilakukan, atau menyampaikan hasil dari tindakan yang telah dilakukan
11. Mempengaruhi orang lain. Komunikasi yang dilakukan perawat kepada klien saat memberikan motivasi untuk mempertahankan kesehatan serta tetap melakukan budaya hidup sehat melalui pengaturan pola makan dan olah raga teratur
12. Mengubah perilaku orang lain. Komunikasi perawat pada saat akan mengubah keyakinan dan perilaku klien yang mendukung kesehatan dari keyakinan dan perilaku yang tidak baik bagi kesehatannya
13. Memberikan pendidikan. Komunikasi yang dilakukan perawat saat memberikan pendidikan atau penyuluhan kesehatan kepada pasien tentang pencegahan penularan penyakit, memberikan pendidikan tentang pertolongan di rumah pada anggota keluarga yang sakit demam berdarah, dan lain-lain yang tujuannya meningkatkan pengetahuan agar lebih baik dari sebelumnya.

14. Memahami (ide) orang lain. Komunikasi antara komunikator dan komunikan untuk saling memahami ide masing-masing dan berusaha untuk memberi makna pada komunikasi yang disampaikan atau diterima
15. Memfasilitasi klien untuk mengatasi masalah dengan mengurangi beban perasaan dan pikiran
16. Membantu klien mengambil tindakan yang efektif
17. Memperbaiki pengalaman klien secara emosional (Kordkolae et al., 2024)

C. Prinsip Dasar Komunikasi Terapeutik

Ada beberapa prinsip yang harus diketahui dalam proses komunikasi terapeutik, yaitu:

1. Hubungan perawat dan pasien adalah hubungan terapeutik yang saling menguntungkan
2. Perawat harus menghargai keunikan pasien, menghargai perbedaan karakter, memahami perasaan, dan perilaku pasien
3. Semua komunikasi yang dilakukan harus dapat menjaga harga diri baik pemberi maupun penerima pesan, dalam hal ini perawat harus mampu menjaga harga dirinya dan harga diri pasien
4. Komunikasi yang menciptakan tumbuhnya hubungan saling percaya harus dicapai terlebih dahulu sebelum menggali permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan masalah
5. Perawat diharapkan untuk bersikap menerima, percaya dan saling menghargai. Perawat bisa memahami dan menghayati nilai yang dianut pasien
6. Perawat menyadari pentingnya kebutuhan pasien
7. Perawat diharapkan untuk menciptakan suasana agar pasien berkembang tanpa rasa takut
8. Perawat diharapkan untuk memotivasi pasien untuk mengubah dirinya
9. Perawat diharapkan untuk menguasai perasaannya sendiri
10. Perawat diharapkan untuk menentukan batas waktu yang sesuai
11. Perawat diharapkan untuk memahami arti dan makna empati
12. Perawat diharapkan untuk jujur dan berkomunikasi secara terbuka
13. Perawat diharapkan untuk berperan sebagai role model
14. Perawat diharapkan untuk mengekspresikan perasaan
15. Perawat memiliki jiwa altruisme (panggilan jiwa) untuk mendapatkan kepuasan dengan menolong orang lain
16. Perawat diharapkan untuk memiliki jiwa empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan klien tanpa memberikan penilaian.

17. Perawat diharapkan untuk memiliki kesabaran dan tidak terburu-buru dalam memahami atau merespons klien.
18. Perawat diharapkan untuk mendengarkan aktif dengan cara fokus pada klien secara penuh, baik secara verbal maupun non-verbal.
19. Perawat diharapkan untuk menghargai klien apa adanya tanpa menghakimi (Abraham et al., 2024)

D. Teknik-Teknik Komunikasi Terapeutik

Teknik komunikasi terapeutik mencakup berbagai metode yang dapat digunakan oleh perawat untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan pasien. Ada dua persyaratan dasar untuk komunikasi yang efektif, yaitu:

1. Semua komunikasi harus ditujukan untuk menjaga harga diri pemberi maupun penerima pesan
2. Komunikasi yang menciptakan saling pengertian harus dilakukan lebih dahulu sebelum memberikan saran, informasi maupun masukan (Kordkolaee et al., 2024).

Berikut adalah teknik-teknik utama dalam komunikasi terapeutik (Abraham et al., 2024):

1. Mendengarkan aktif dengan penuh perhatian

Teknik yang paling umum digunakan dalam komunikasi terapeutik adalah mendengarkan aktif. Mendengar aktif merupakan proses aktif menerima informasi dan mempelajari respon seseorang terhadap pesan yang diterima. Mendengar aktif juga diartikan sebagai konsentrasi aktif dan persepsi terhadap pesan orang lain yang menggunakan semua indra (Moreno-Poyato et al., 2021).

Mendengarkan aktif dengan penuh perhatian tidak hanya pada kata-kata yang diucapkan pasien tetapi juga pada isyarat non verbal seperti ekspresi wajah dan nada suara. Mendengarkan aktif memungkinkan perawat untuk merespons dengan cara yang tepat dan penuh empati, sehingga pasien merasa didengar dan dihargai. Teknik ini melibatkan perhatian penuh terhadap apa yang dikatakan klien, dengan memberikan respons verbal seperti, "Saya memahami," dan respons non-verbal seperti anggukan.

Selama mendengarkan aktif, perawat harus mengikuti apa yang dibicarakan klien dengan penuh perhatian. Perawat memberikan tanggapan dengan tepat dan tidak memotong pembicaraan klien. Perawat juga harus menunjukkan perhatian bahwa perawat mempunyai waktu untuk mendengarkan. Dalam hal ini perawat mencoba untuk memahami pasien dengan cara menjadi pendengar yang baik untuk pasien. Perawat mendengarkan dengan sepenuh hati apa yang dirasakan oleh pasien, memberikan kesempatan untuk pasien berbicara lebih tentang kondisinya.

Contoh mendengar aktif yang dapat perawat lakukan saat melakukan komunikasi terapeutik yaitu mempertahankan kontak mata, menganggukkan kepala, posisi badan sedikit membungkuk ke arah klien (Gul et al., 2024).

2. Empati

Perawat menunjukkan pemahaman terhadap perasaan klien. Misalnya, "Saya bisa memahami mengapa Anda merasa seperti itu."

3. Penyelidikan (Exploration)

Eksplorasi (*Exploration*) merupakan teknik yang bertujuan untuk mencari atau menggali lebih dalam masalah yang dialami klien supaya masalah tersebut bisa diatasi. Teknik ini bermanfaat pada tahap kerja untuk mendapatkan gambaran yang detail tentang masalah yang dialami klien. Bertanya lebih dalam untuk mendorong klien mengungkapkan pikirannya. Contoh: "Apa yang membuat Anda merasa demikian?"

4. Meringkas

Teknik ini membantu memastikan bahwa informasi dari klien dipahami dengan benar. Contoh: "Jadi, Anda merasa khawatir tentang masa depan pekerjaan Anda, benar begitu?"

5. Memberikan Penghargaan

Memberikan penguatan positif terhadap usaha atau keberanian klien, seperti, "Saya menghargai keterbukaan Anda."

6. Menawarkan Diri

Menyatakan kesediaan untuk mendampingi klien, seperti, "Jika Anda membutuhkan, saya siap membantu."

7. Memberi Kesempatan Klien untuk Memulai Pembicaraan

Perawat memberikan ruang bagi klien untuk membuka pembicaraan.

8. Mengajukan untuk Meneruskan Pembicaraan

Perawat memberikan dorongan verbal seperti, "Silakan lanjutkan, saya mendengarkan."

9. Menempatkan Kejadian secara Teratur

Perawat membantu klien memahami urutan kejadian.

10. Mengajukan Klien untuk Menguraikan Persepsinya/ Membagi persepsi (Sharing perception)

Membagi persepsi (*Sharing perception*) merupakan permintaan untuk meminta pendapat klien tentang hal yang perawat rasakan atau pikirkan, Teknik ini digunakan Ketika perawat merasakan atau melihat ada perbedaan antara respons verbal atau respons nonverbal dari klien. Mengajak klien berbagi pandangannya, seperti, "Menurut Anda, apa yang sebenarnya terjadi?"

11. Refleksi

Refleksi adalah teknik lain yang berguna dalam komunikasi terapeutik, dimana perawat mengulangi atau merangkum apa yang dikatakan pasien untuk memastikan pemahaman yang benar. Mengulang perasaan klien agar mereka lebih memahami emosinya. Mengulang Kembali apa yang dibicarakan klien. Contoh refleksi yang dapat perawat lakukan saat melakukan komunikasi terapeutik yaitu

12. Kesenyapan

Perawat memberikan jeda waktu agar klien dapat berpikir sebelum merespons

13. Menunjukkan penerimaan

Menunjukkan Penerimaan yang dapat diberikan perawat seperti mendukung dan menerima informasi dengan tingkah laku yang menunjukkan ketertarikan dan tidak menilai. Menunjukkan penerimaan berarti kesediaan mendengar tanpa menunjukkan keraguan atau ketidaksetujuan. Menerima bukan berarti menyetujui, menerima disini berarti bahwa perawat bersedia mendengarkan apapun yang disampaikan oleh pasien tanpa menunjukkan sikap ragu ataupun tidak setuju.

Beberapa cara untuk menunjukkan penerimaan diantaranya: dengan mendengar tanpa memotong pembicaraan, menyediakan umpan balik yang menunjukkan pengertian, yakin bahwa tanda non verbal sesuai dengan verbal, hindari berdebat, mengekspresikan keraguan atau usaha untuk merubah klien.

14. Menanyakan pertanyaan yang berkaitan

Bertanya merupakan teknik yang dapat mendorong klien untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Dalam hal ini perawat bertanya mengenai hal yang disampaikan oleh pasien agar informasi yang diterima oleh perawat lebih spesifik. Ada berbagai macam pertanyaan yang dapat perawat tanyakan ke pasien, seperti pertanyaan fasilitatif (digunakan apabila saat bertanya, perawat sensitive terhadap pikiran dan perasaan serta secara langsung berhubungan dengan masalah klien), pertanyaan terbuka (digunakan apabila perawat membutuhkan jawaban yang banyak dari klien), dan pertanyaan tertutup (digunakan apabila perawat membutuhkan jawaban yang singkat dari pasien).

15. Mengulangi ucapan pasien dengan menggunakan kata-kata sendiri

Mengulangi (*restating*) merupakan mengulang pokok pikiran yang diungkapkan klien. Maksudnya adalah mengulangi pokok pikiran yang diungkapkan klien dengan menggunakan kata-kata sendiri. Dengan mengulang apa yang disampaikan pasien, perawat memberikan umpan balik bahwa perawat memahami dan mengerti tentang hal yang disampaikan oleh pasien dengan harapan komunikasi tetap berlanjut. *Restating* ini berguna untuk menguatkan

ungkapan klien dan memberi indikasi perawat mengikuti pembicaraan atau memperhatikan klien dan mengharapkan komunikasi berlanjut klien (Keliat, Budi Anna, 1992).

16. Mengklarifikasi

Klarifikasi (*Clarification*) atau validasi adalah penjelasan Kembali ke ide atau pikiran klien yang tidak jelas atau meminta klien untuk menjelaskan arti dari ungkapannya. Fokus utama klarifikasi adalah pada perasaan, karena pengertian terhadap perasaan klien sangat penting dalam memahami klien. Perawat berusaha menjelaskan dengan kata-kata mengenai hal ataupun pikiran yang tidak jelas disampaikan oleh pasien.

Klarifikasi juga penting untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pasien dipahami dengan tepat oleh perawat, misalnya dengan bertanya, "Apakah yang Anda maksud ketika Anda mengatakan rasa nyeri ini terasa tajam?" Teknik-teknik ini membantu perawat untuk memberikan perawat yang lebih tepat sasaran dan mendukung keterlibatan aktif pasien dalam proses pengambilan keputusan terkait kesehatannya.

17. Memfokuskan

Memfokuskan (*Focusing*) adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk membatasi area diskusi sehingga percakapan menjadi lebih spesifik dan dimengerti (Stuart & Sundeen, 1995). Tujuan dari memfokuskan adalah untuk membatasi bahan pembicaraan agar lebih spesifik dan lebih mudah untuk dimengerti.

18. Menyatakan hasil observasi

Dalam hal ini perawat menguraikan kesan yang ditimbulkan oleh isyarat nonverbal pasien.

19. Menawarkan informasi/ menawarkan diri/ memberikan informasi (informing)

Memberikan informasi tambahan merupakan tindakan penyuluhan kesehatan untuk klien. Teknik ini sangat membantu dalam mengajarkan kesehatan atau pendidikan pada klien tentang aspek-aspek yang relevan dengan perawatan diri dan penyembuhan klien. Di sini perawat memberikan informasi tambahan untuk pasien yang tujuannya memfasilitasi pasien dalam mengambil keputusan. Perawat juga menyediakan diri tanpa respons bersyarat atau respons yang diharapkan.

20. Diam

Diam (*Silent*) merupakan teknik untuk memberikan kesempatan pada klien sebelum menjawab pertanyaan perawat, diam akan memberikan kesempatan kepada perawat dan klien untuk mengorganisasi pikiran masing-masing (Stuart

& Sundeen, 1995). Diam memungkinkan pasien untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri untuk bisa mengorganisir dan memproses informasi.

21. Meringkas/ Menyimpulkan (Summerizing)

Menyimpulkan adalah Teknik komunikasi yang membantu klien mengeksplorasi point penting dari interaksi perawat-klien. Teknik ini membantu perawat dan klien untuk memiliki pikiran dan ide yang sama saat mengakhiri pertemuan.

22. Memberi penghargaan/ memberikan pujian (Reinforcement)

Memberikan pujian (*Reinforcement*) merupakan keuntungan psikologis yang didapatkan klien Ketika berinteraksi dengan perawat. *Reinforcement* berguna untuk meningkatkan harga diri dan menguatkan perilaku klien. Reinforcement bisa diungkapkan dengan kata-kata ataupun melalui isyarat non verbal.

Penghargaan yang diberikan kepada pasien jangan sampai membuat pasien merasa bahwa dirinya melakukan sesuatu atau menyampaikan sesuatu hanya untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Contoh memberi penghargaan pada komunikasi terapeutik keperawatan diantaranya, memberi salam pada klien dan keluarga dengan menyebut Namanya, menunjukkan kesadaran tentang perubahan yang terjadi, untuk menghargai klien dan keluarga sebagai manusia seutuhnya yang mempunyai hak dan tanggung jawab atas dirinya sendiri sebagai individu.

23. Memberi kesempatan kepada pasien untuk memulai pembicaraan

Untuk memberi kesempatan kepada pasien untuk berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan, menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan hingga meemberi kesempatan kepada pasien untuk mengarahkan hampir seluruh pembicaraan.

24. Menempatkan kejadian secara berurutan

Kejadian yang ada didalam cerita dijadikan berurutan agar perawat dan pasien melihatnya dalam suatu perspektif.

25. Memberi kesempatan pada pasien untuk menguraikan persepsinya

Jika perawat ingin mengerti pasien maka perawat harus melihat segala sesuatunya dari perspektif pasien.

26. Mengubah cara pandang (reframing)

Teknik ini digunakan untuk memberikan cara pandang lain sehingga klien tidak melihat sesuatu atau masalah dari aspek negatifnya saja sehingga memungkinkan klien untuk membuat perencanaannya yang lebih baik dalam mengatasi masalah yang dihadapinya

27. Refleksi

Refleksi (*Reflection*) adalah mengarahkan kembali ide, perasaan, pertanyaan, dan isi pembicaraan kepada klien. Hal ini digunakan untuk memvalidasi pengertian perawat tentang apa yang diucapkan klien dan menekankan empati, minat, dan penghargaan terhadap klien. Refleksi menganjurkan klien untuk mengungkapkan dan menerima ide dan perasaannya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Memberi kesempatan kepada pasien untuk mengemukakan dan menerima ide dan perasaannya sebagai bagian dari dirinya sendiri

28. Asertif (Assertive)

Asertif merupakan suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Dalam bersikap asertif, seseorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya dan jujur pula dalam mengekspresikan perasaan, pendapat dan kebutuhan secara proporsional, tanpa ada maksud untuk memanipulasi, memanfaatkan ataupun merugikan pihak lainnya.

29. Identifikasi tema

Perawat harus tanggap terhadap cerita yang disampaikan klien dan harus mampu menangkap tema dari seluruh pembicaraan tersebut. Gunanya untuk meningkatkan pengertian dan menggali masalah penting dan memfokuskan pembicaraan pada awal masalah yang benar-benar dirasakan klien

30. Humor

Humor merangsang produksi catecholamine dan hormone yang menimbulkan perasaan sehat, meningkatkan toleransi terhadap rasa sakit, mengurangi ansietas, memfasilitasi relaksasi pernafasan dan menggunakan humor untuk menutupi rasa takut dan tidak enak atau menutupi ketidakmampuannya untuk berkomunikasi dengan klien (Lord et al., 2021)

E. Aplikasi Komunikasi Terapeutik Dalam Berbagai Konteks

Komunikasi terapeutik mempunyai tujuan dan fungsi sebagai terapi untuk pasien, sehingga pelaksanaan komunikasi terapeutik harus direncanakan dan terstruktur dengan baik melalui 4 tahapan yaitu (Engel et al., 2023):

1. Tahap pre interaksi

Tahap ini adalah masa persiapan sebelum berinteraksi dengan pasien. Tugas perawat pada tahap ini, yaitu: a) menggali perasaan, harapan dan kecemasannya; b) mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya agar dapat lebih memaksimalkan dirinya sehingga lebih bernilai terapeutik bagi pasien; c) mencari informasi dengan mengumpulkan data tentang pasien; d) merancang strategi

untuk pertemuan pertama dengan pasien, yang dapat dilakukan secara tertulis (Anders, 2021)

2. Tahap orientasi

Tahap ini merupakan tahap pengenalan yang dilakukan perawat saat pertama kali bertemu dengan pasien. Perawat harus memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada pasien, dengan begitu berarti perawat telah bersikap terbuka kepada pasien. Situasi lingkungan yang peka dan menunjukkan penerimaan serta membantu pasien dalam mengekspresikan perasaan dan pikiran (Kordkolaee et al., 2024).

Tugas perawat pada tahap ini, yaitu: a) membina rasa saling percaya, menunjukkan penerimaan dan komunikasi terbuka; b) merumuskan kontrak (waktu, tempat pertemuan dan topik pembicaraan) dan menjelaskan atau mengklarifikasi Kembali kontrak yang telah disepakati bersama; c) menggali pikiran dan perasaan serta mengidentifikasi masalah klien yang umumnya dilakukan dengan menggunakan teknik komunikasi terbuka; d) merumuskan tujuan interaksi dengan klien (Alkhaqani, 2022)

3. Tahap kerja

Tahap ini merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Tahap ini perawat bekerja sama dengan pasien untuk mengatasi masalah yang dihadapi pasien. Tahap kerja berhubungan dengan rencana pelaksanaan tindakan keperawatan yang akan dilakukan kepada pasien. Perawat dituntut untuk mempunyai tingkat analisa yang tinggi sehingga dapat mengeksplorasi, mendengarkan dengan aktif, refleksi, berbagai persepsi, memfokuskan dan menyimpulkan. Jika perawat tidak menyimpulkan percakapannya dengan pasien pada tahap ini, dapat terjadi perbedaan persepsi antara perawat dengan pasien sehingga penyelesaian masalah menjadi tidak terarah dan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan dan masalah pasien menjadi tidak terselesaikan. Tugas perawat pada tahap ini, yaitu: a) perawat harus memiliki keterampilan dalam mendengarkan masalah pasien dan pengetahuan keperawatan dari perawat; b) perawat harus memiliki kesadaran yang tinggi serta kesabaran dalam mendengarkan masalah klien, perawat juga harus mampu mengenal, mengerti dan mengetahui cara penanggulangan masalah yang sedang dialami pasien (Dartiguelongue & Cafiero, 2021)

4. Tahap terminasi

Terminasi merupakan tahap akhir dari pertemuan antara perawat dengan pasien. Tahap terminasi ini dibagi menjadi dua, yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir (Stuart dan Laraia, 2001). Pertemuan antara perawat dan pasien terdiri atas beberapa kali pertemuan. Setelah terminasi sementara, perawat akan

bertemu kembali dengan pasien pada waktu yang telah ditetapkan, sedangkan terminasi akhir terjadi jika perawat telah menyelesaikan proses keperawatan secara keseluruhan.

Tugas perawat pada tahap ini, yaitu: a) mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah dilaksanakan; b) melakukan evaluasi subyektif; c) menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan; d) membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya (Anders, 2021).

Contoh pengaplikasian komunikasi terapeutik sesuai situasi dan kondisi klien

Situasi 1: Klien merasa cemas sebelum menjalani operasi

- **Perawat:** "Saya mengerti Anda merasa cemas menjelang operasi. Ini adalah reaksi yang wajar. Apa yang paling membuat Anda khawatir saat ini?"
- **Klien:** "Saya takut operasi tidak berhasil dan saya akan merasakan sakit yang hebat."
- **Perawat:** "Wajar sekali Anda merasa seperti itu. Tim medis telah melakukan persiapan yang matang dan akan berusaha semaksimal mungkin agar operasi berjalan lancar. Selain itu, Anda akan diberikan obat penghilang rasa sakit untuk meminimalisir rasa tidak nyaman."
- **Klien:** "Tapi saya tetap saja takut."
- **Perawat:** "Rasanya memang menakutkan untuk menghadapi ketidakpastian. Namun, ingatlah bahwa Anda tidak sendiri. Saya akan selalu ada untuk mendukung Anda."

Teknik komunikasi terapeutik dapat diterapkan dalam berbagai situasi, seperti:

- a. Bidang Kesehatan: Perawat menggunakan refleksi untuk memahami pasien.
- b. Konseling: Konselor menggunakan empati dan eksplorasi untuk mendukung klien.
- c. Hubungan Keluarga: Orang tua menggunakan mendengarkan aktif untuk mendekatkan diri dengan anak-anak.

F. Latihan Soal

1. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi terapeutik?
2. Jelaskan Tujuan dari komunikasi terapeutik!
3. Jelaskan prinsip dalam komunikasi terapeutik!
4. Jelaskan Teknik-teknik komunikasi terapeutik!
5. Berikan contoh aplikasi Teknik komunikasi terapeutik yang dapat dilakukan perawat kepada pasien!

G. Rangkuman Materi

Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang dilakukan atau dirancang untuk tujuan terapi/ penyembuhan kepada pasien. Komunikasi terapeutik bertujuan untuk mengembangkan segala yang ada dalam pikiran dan diri pasien ke arah yang lebih positif yang nantinya akan dapat mengurangi beban perasaan pasien dalam menghadapi maupun mengambil tindakan tentang kesehatannya.

Beberapa Teknik utama dalam komunikasi terapeutik yang dapat dilakukan oleh perawat kepada pasien, diantaranya: 1) mendengarkan aktif dengan penuh perhatian; 2) empati; 3) penyelidikan (*exploration*); 4) meringkas; 5) memberikan penghargaan; 6) menawarkan diri; 7) memberi kesempatan klien untuk memulai pembicaraan; 8) menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan; 9) menempatkan kejadian secara teratur; 10) menganjurkan klien untuk menguraikan persepsinya. Membagi persepsi (*sharing perception*); 11) refleksi; 12) kesenyapan; 13) menunjukan penerimaan; 14) menanyakan pertanyaan yang berkaitan; 15) mengulangi ucapan pasien dengan menggunakan kata-kata sendiri; 16) mengklarifikasi; 17) memfokuskan; 18) menyatakan hasil observasi; 19) menawarkan informasi/ menawarkan diri/ memberikan informasi; 20) diam; 21) meringkas; 22) memberi penghargaan/ memberikan pujian (*reinforcement*); 23) memberi kesepakatan kepada pasien untuk memulai pembicaraan; 24) menempatkan kejadian secara berurutan; 25) memberi kesempatan pada pasien untuk menguraikan persepsinya; 26) mengubah cara pandang (*reframing*); 27) refleksi (*reflection*); 28) asertif; 29) identifikasi tema, dan 30) humor.

H. Glosarium

WAJIB ADA BUKAN OPSIONAL

Empati	: kemampuan memahami perasaan orang lain
Bahasa non verbal	: komunikasi melalui gerakan tubuh dan ekspresi wajah
Bahasa verbal	: komunikasi melalui bahasa lisan langsung
Asertif	: komunikasi yang terbuka, menghargai diri sendiri dan orang lain
Refleksi	: komunikasi yang melibatkan untuk mendengar secara aktif dan merespon pesan pembicara

I. Daftar Pustaka

- Abraham, S. A., Nsatimba, F., Agyare, D. F., Agyeiwaa, J., Opoku-Danso, R., Ninnoni, J. P., Doe, P. F., Kuffour, B. O., Anumel, B. K., & Berchie, G. O. (2024). Barriers and outcomes of therapeutic communication between nurses and patients in Africa: a scoping review. *BMC Nursing*, 23(1), 362.
- Alkhaqani, A. L. (2022). Importance of teamwork communication in nursing practice. *Nursing Communications*, 6(0), e2022015.
- Anders, R. L. (2021). Practical tips for effective communication. *Nursing Management*, 52(6), 10–13.
- Dartiguelongue, J. B., & Cafiero, P. J. (2021). Communication in health care teams. *Arch Argent Pediatr*, 119(6), e589–e593.
- El-Abidi, K., Moreno-Poyato, A. R., Cañabate-Ros, M., Garcia-Sanchez, J. A., Lluch-Canut, M. T., Muñoz-Ruoco, E., Pérez-Moreno, J. J., Pita-De-La-Vega, J., Puig-Llobet, M., & Rubia-Ruiz, G. (2024). The therapeutic relationship from the perspective of patients and nurses in the first days of admission: a cross-sectional study in acute mental health units. *International Journal of Mental Health Nursing*, 33(1), 134–142.
- Engel, M., Kars, M. C., Teunissen, S. C. C. M., & van der Heide, A. (2023). Effective communication in palliative care from the perspectives of patients and relatives: a systematic review. *Palliative & Supportive Care*, 1–24.
- Gul, S., Saddique, H., & Jabeen, R. (2024). Knowledge, Attitude and Practice of Nurses Regarding Therapeutic Communication at Tertiary Care Hospital. *Journal of Health and Rehabilitation Research*, 4(2), 144–148.

- Kordkolaee, Z. A., Kaveh, O., Hosseinnataj, A., & Esmaeilli, R. (2024). Barriers to Effective Communication Between Nurses and Patients from the Perspective of Emergency Nurses at Educational-Therapeutic: A Cross-Sectional Study. *Journal of Nursing & Midwifery Sciences*, 11(3).
- Kurniyawan, E. H., Putri, C. A., Waroh, I. K., Irham, N. A. A., Kurniawan, D. E., Nur, K. R. M., & Afandi, A. T. (2024). Therapeutic Communication for Healing Psychological Trauma Experienced by Victims of Sexual Violence: A Literature Review. *Health and Technology Journal (HTechJ)*, 2(1), 72–80.
- Lord, H., Loveday, C., Moxham, L., & Fernandez, R. (2021). Effective communication is key to intensive care nurses' willingness to provide nursing care amidst the COVID-19 pandemic. *Intensive and Critical Care Nursing*, 62, 102946.
- Moreno-Poyato, A. R., Rodríguez-Nogueira, Ó., & Group, M. C. A. T. W. (2021). The association between empathy and the nurse–patient therapeutic relationship in mental health units: a cross-sectional study. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 28(3), 335–343.

BAB 7

KOMUNIKASI TERAPEUTIK PADA ANAK

Tujuan Intruksional:

Mahasiswa Mampu memahami konsep komunikasi terapeutik pada anak.

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu menyebutkan pengertian Komunikasi Terapeutik pada Anak
2. Mampu menjelaskan tujuan Komunikasi Terapeutik pada Anak
3. Mampu menjelaskan perkembangan komunikasi pada anak
4. Mampu menjelaskan Bentuk-bentuk Komunikasi pada anak
5. Mampu melakukan Teknik- Komunikasi Terapeutik pada Anak

Pendahuluan

Komunikasi Terapeutik pada Anak, Komunikasi merupakan fondasi utama dalam setiap interaksi manusia, terlebih dalam konteks pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan anak. Anak sebagai individu yang masih berada dalam proses tumbuh kembang memiliki kebutuhan komunikasi yang khas dan sensitif. Mereka belum sepenuhnya mampu mengekspresikan pikiran, perasaan, atau kebutuhan secara verbal seperti orang dewasa. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan khusus dalam menjalin komunikasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga memiliki dampak positif secara emosional dan psikologis—yang disebut dengan komunikasi terapeutik.

Komunikasi terapeutik adalah bentuk komunikasi profesional yang bertujuan untuk mendukung proses penyembuhan, memperkuat hubungan antara tenaga profesional dan anak, serta menciptakan rasa aman, nyaman, dan diterima. Dalam dunia kesehatan, terutama keperawatan dan psikologi, komunikasi terapeutik menjadi keterampilan utama yang harus dimiliki oleh setiap praktisi, khususnya saat berhadapan dengan pasien anak. Demikian pula dalam konteks pendidikan dan bimbingan anak, komunikasi yang membangun kepercayaan dan rasa empati merupakan kunci untuk memahami dan mendampingi anak dengan efektif.

Uraian Materi

Komunikasi terapeutik merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kesehatan, terutama perawat yang berinteraksi langsung dengan pasien anak-anak. Dalam praktik keperawatan pediatrik, komunikasi yang efektif tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk memberikan rasa aman, dukungan emosional, dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Komunikasi pada anak merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan diri kita dengan anak. Melalui komunikasi akan terjalin rasa percaya, rasa kasih sayang, dan selanjutnya anak akan merasa memiliki suatu penghargaan pada dirinya.

Komunikasi terapeutik pada anak dimaksudkan untuk membantu proses penyembuhan, terutama dalam psikoterapi. Ini sangat penting bagi anak-anak karena membantu mereka mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka yang mungkin sulit diungkapkan dengan cara lain. Pada akhirnya, proses ini membantu anak-anak merasa dipahami dan didukung, yang pada gilirannya dapat menghasilkan peningkatan kesehatan mental mereka (Adolph, 2016).

Komunikasi terapeutik pada pasien anak adalah komunikasi yang direncanakan dan dimaksudkan untuk kesembuhan antara perawat dan pasien anak. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat berkomunikasi dengan anak termasuk perkembangan mereka, cara mereka berkomunikasi dengan orang lain, dan peran orang ketiga seperti orang tua dan orang terdekat pasien dalam membantu proses komunikasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perawat dapat melakukan tindakan asuhan keperawatan dengan baik dan benar (Ners et al., n.d.)

A. Tujuan komunikasi terapeutik pada bayi dan anak

Adapun tujuan yang diharapkan dalam melakukan komunikasi terapeutik pada bayi dan anak adalah : (Widiyanto., et al., 2023)

1. Membantu klien mengatasi masalah mereka sehingga mereka tidak merasa terbebani oleh perasaan dan pikiran mereka.
2. Membantu mengambil tindakan yang efektif untuk klien dan pasien.
3. Memperbaiki pengalaman emosional klien, dan akhirnya, mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan.

B. Perkembangan komunikasi pada Anak

Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus dipenuhi; mereka memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dari orang dewasa. Anak selalu bergerak aktif, dinamis, dan selalu ingin mengetahui setiap hal yang dilihat, didengar dan dirasakan. Anak akan mendapatkan banyak kosa-kata dan keterampilan

berbicara seiring bertambahnya usia, berikut perkembangan komunikasi sesuai usia anak : (Eka Putri & Kamali, 2023)

1. Usia Bayi (0-1 tahun)

Komunikasi pada bayi yang umumnya dapat dilakukan adalah dengan melalui gerakan-gerakan bayi, gerakan tersebut sebagai alat komunikasi yang efektif, di samping itu komunikasi pada bayi dapat dilakukan secara non verbal. Perkembangan komunikasi pada bayi dapat dimulai dengan kemampuan bayi untuk melihat sesuatu yang menarik, ketika bayi digerakkan maka bayi akan berespons untuk mengeluarkan suara-suara bayi. Perkembangan komunikasi pada bayi tersebut dapat dimulai pada usia minggu ke delapan dimana bayi sudah mampu untuk melihat objek atau cahaya, kemudian pada minggu kedua belas sudah mulai melakukan tersenyum. Pada usia ke enam belas bayi sudah mulai menolehkan kepala pada suara yang asing bagi dirinya. Pada pertengahan tahun pertama bayi sudah mulai mengucapkan kata-kata awal seperti ba-ba, da-da, dan lain-lain. Pada bulan ke sepuluh bayi sudah bereaksi terhadap panggilan terhadap namanya, mampu melihat beberapa gambar yang terdapat dalam buku. Pada akhir tahun pertama bayi sudah mampu mengucapkan kata-kata yang spesifik antara dua atau tiga kata.

Selain melakukan komunikasi seperti di atas terdapat cara komunikasi yang efektif pada bayi yakni dengan cara menggunakan komunikasi non verbal dengan tehnik sentuhan seperti mengusap, menggendong, memangku, dan lain-lain

2. Usia Todler dan Pra Sekolah toddler (1-3 tahun) dan prasekolah (3-6 tahun)

Perkembangan komunikasi pada usia ini dapat ditunjukkan dengan perkembangan bahasa anak dengan kemampuan anak sudah mampu memahami kurang lebih sepuluh kata, pada tahun ke dua sudah mampu 200-300 kata dan masih terdengar kata-kata ulangan.

Pada anak usia ini khususnya usia 3 tahun anak sudah mampu menguasai sembilan ratus kata dan banyak kata-kata yang digunakan seperti mengapa, apa, kapan dan sebagainya. Komunikasi pada usia tersebut sifatnya sangat egosentris, rasa ingin tahunya sangat tinggi, inisiatifnya tinggi, kemampuan bahasanya mulai meningkat, mudah merasa kecewa dan rasa bersalah karena tuntutan tinggi, setiap komunikasi harus berpusat pada dirinya, takut terhadap ketidaktahuan dan perlu diingat bahwa pada usia ini anak masih belum fasih dalam berbicara.

Pada usia ini cara berkomunikasi yang dapat dilakukan adalah dengan memberi tahu apa yang terjadi pada dirinya, memberi kesempatan pada mereka untuk menyentuh alat pemeriksaan yang akan digunakan, menggunakan nada suara, bicara lambat, jika tidak dijawab harus diulang lebih jelas dengan pengarahannya yang sederhana, hindarkan sikap mendesak untuk dijawab seperti

kata-kata "jawab dong", mengalihkan aktivitas saat komunikasi, memberikan mainan saat komunikasi dengan maksud anak mudah diajak komunikasi dimana kita dalam berkomunikasi dengan anak sebaiknya mengatur jarak, adanya kesadaran diri dimana kita harus menghindari konfrontasi langsung, duduk yang terlalu dekat dan berhadapan. Secara non verbal kita selalu memberi dorongan penerimaan dan persetujuan jika diperlukan, jangan sentuh anak tanpa disetujui dari anak, bersalaman dengan anak merupakan cara untuk menghilangkan perasaan cemas, menggambar, menulis atau bercerita dalam menggali perasaan dan pikiran anak si saat melakukan komunikasi.

3. Usia Sekolah (5-11 tahun)

Perkembangan komunikasi pada anak usia ini dapat dimulai dengan kemampuan anak mencetak, menggambar, membuat huruf atau tulisan yang besar dan apa yang dilaksanakan oleh anak mencerminkan pikiran anak dan kemampuan anak membaca disini sudah muncul, pada usia ke delapan anak sudah mampu membaca dan sudah mulai berfikir tentang kehidupan.

Komunikasi yang dapat dilakukan pada usia sekolah ini adalah tetap masih memperhatikan tingkat kemampuan bahasa anak yaitu menggunakan kata-kata sederhana yang spesifik, menjelaskan sesuatu yang membuat ketidakjelasan pada anak atau sesuatu yang tidak diketahui, pada usia ini keingintahuan pada aspek fungsional dan prosedural dari objek tertentu sangat tinggi. Maka jelaskan arti, fungsi dan prosedurnya, maksud dan tujuan dari sesuatu yang ditanyakan secara jelas dan jangan menyakiti atau mengancam sebab ini akan membuat anak tidak mampu berkomunikasi secara efektif.

4. Usia Remaja (11-18 tahun)

Perkembangan komunikasi pada usia remaja ini ditunjukkan dengan kemampuan berdiskusi atau berdebat dan sudah mulai berpikir secara konseptual, sudah mulai menunjukkan perasaan malu, pada anak usia sering kali merenung kehidupan tentang masa depan yang direfleksikan dalam komunikasi. Pada usia ini pola pikir sudah mulai menunjukkan ke arah yang lebih positif, terjadi konseptualisasi mengingat masa ini adalah masa peralihan anak menjadi dewasa.

Menurut (Wong, 2009) Perkembangan adalah perubahan kualitas yang mencakup peningkatan kapasitas seseorang untuk berfungsi, yang dicapai melalui proses pertumbuhan, pematangan, dan pembelajaran. Perkembangan 45 adalah hasil interaksi kematangan susunan syaraf pusat dengan organ yang dipengaruhi, seperti perkembangan sistem neuromuskuler, kemampuan bicara, emosi, dan sosialisai. Sebaliknya, pertumbuhan terjadi bersamaan dengan perkembangan. Semua fungsi ini penting untuk menjaga kehidupan manusia.

1. Masa bayi

- a. Belum bisa berkomunikasi dengan kata-kata. Komunikasi yang digunakan adalah komunikasi non verbal.
- b. Mengungkapkan kebutuhan dengan tingkah laku dan suara yang bisa diinterpretasikan oleh orang-orang disekitarnya, seperti menangis, yang bisa jadi menunjukkan lapar, sakit, pembatasan gerak, atau kesepian. Adapun tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan mengusap, berbicara halus, menggendong, atau dipangku.
- c. Ketika bayi berumur 6 bulan, perilaku yang biasa dilakukan adalah menggerak-gerakkan tangan dan kaki. Gerakan itu dilakukan guna, menarik perhatian orang-orang disekitarnya. Adapun tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan menepuk tubuh dengan perasaan.
- d. Ketika bayi berusia diatas 6 bulan, biasanya selalu berpusat pada diri dan ibunya. Saat itu, bayi merasa takut pada orang asing.

2. Anak usia kurang 5 tahun.

- a. Sangat egosentris. Melihat sesuatu hanya dengan sudut pandangnya sendiri (komunikasi yang berpusat pada dirinya sendiri).
- b. Takut ketidaktauan. Guna mengatasinya, beritahuan apa yang akan terjadi pada dirinya, bagaimana merasakannya serta diberi kesempatan guna menyentuh atau memegang alat yang menarik perhatiannya.
- c. Belum lancar dalam berbicara. Pergunakan kata-kata yang simpel, singkat, dan dikenal oleh anak dalam berkomunikasi serta berikan pujian mengenai hal-hal yang sudah dicapainya.
- d. Sering-seringlah berpandangan dengan mata sejajar kepada anak.

3. Usia sekolah (5-11 tahun)

- a. Pada umumnya, saat menemui masalah, mereka hanya percaya pada apa yang dilihat dan diketahui tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
- b. Anak usia ini sangat memerhatikan keberadaan tubuhnya. Mereka sangat peka terhadap segala sesuatu yang diasumsikan bisa mengancam atau menyakiti tubuhnya.

4. Anak usia remaja

- a. Mulai memiliki pola pikir dan tingkah laku, sebagai penanda peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa.
- b. Apabila sedang mengalami stres, biasanya akan mendiskusikan masalah tersebut dengan teman sebaya atau orang dewasa diluar keluarganya.
- c. Menolak seseorang yang diasumsikan dapat menjatuhkan harga dirinya. Untuk hal ini, berikan mereka support dan pengertian agar jangan melakukan

interupsi. Selain itu, hindari ragam bentuk pertanyaan yang berpotensi menimbulkan rasa malu.

C. Bentuk-bentuk Komunikasi pada anak

Ada Empat bentuk Komunikasi pra-bicara sementara pada bayi adalah tangisan, celoteh, isyarat, dan ekspresi emosional (Anjaswarni, 2016)

1. Tangisan

Tangisan kelahiran bayi membuat wajah seorang ibu tersenyum syukur. Bayi menangis sebagai cara mereka berkomunikasi dengan orang dewasa. Bayi menangis untuk menyampaikan pesan, dan orang dewasa mendengarkan pesan yang disampaikan bayi.

Salah satu cara pertama bayi berkomunikasi dengan dunia luar pada awal kehidupan pasca lahir adalah menangis. Dia menangis untuk mengungkapkan kebutuhannya, termasuk lapar, lapar, panas, lelah, dan kebutuhan untuk perhatian. Bayi hanya akan menangis saat sakit atau tertekan jika kebutuhannya segera dipenuhi. Karena ibu muda sangat membutuhkan bantuan saat menangis, perawat harus banyak berlatih mengenal berbagai arti tangisan bayi. Kebanyakan kasus setelah berusia dua minggu disebabkan oleh orang tua yang tidak cepat memahami apa arti tangis bayinya dan tidak konsisten dalam menanggapi. Pada usia enam bulan, frekuensi tangisan bayi yang sehat dan normal menurun. Ini terjadi karena kebutuhan dan keinginan mereka telah terpenuhi.

2. Ocehan dan Celoteh

"Ocehan" atau "celoteh" adalah istilah untuk jenis komunikasi prabicara. Bunyi eksplosif pertama muncul karena perubahan gerakan mekanisme "suara". Selama bulan pertama kehidupan bayi, hal-hal seperti merengek, menjerit, menguap, bersin, menangis, dan mengeluh muncul. Sebagian dari ocehan akan menjadi celoteh, dan sebagian lagi akan hilang. Proses perkembangan otot saraf bayi dikenal sebagai celotehan. Sebagian bayi mulai berceloteh pada awal bulan kedua dan meningkat dengan cepat antara bulan keenam dan kedelapan.

3. Isyarat

Isyarat adalah gerakan anggota badan tertentu yang membantu atau mengganti bicara. Contoh isyarat yang biasa ditunjukkan oleh bayi adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong putting susu dari mulut, menunjukkan bahwa dia kenyang atau tidak lapar;
- b. Tersenyum dan mengacungkan tangan, menunjukkan bahwa dia ingin digendong;

- c. Mengeliat, meronta, menangis, dan menangis selama berpakaian dan mandi, menunjukkan ketidaksukaan terhadap batas gerak.

4. Ungkapan Emosional

Ungkapan emosional terjadi melalui perubahan tubuh dan roman muka.

Sebagai contoh:

- a. Gembira: mengendurkan badan, mengangkat tangan/kaki, tersenyum dan marah.
- b. Marah: menegakkan badan, gerak membanting tangan atau kaki, roman muka tegang dan menangis.

D. Teknik Komunikasi Terapeutik pada Anak

Anak-anak adalah individu yang berbeda, dan respons mereka terhadap komunikasi disampaikan secara berbeda-beda sesuai kebutuhan mereka. Setiap anak memiliki cara yang berbeda untuk mengungkapkan keinginannya. Untuk menjalin hubungan dengan anak secara efektif dan sesuai dengan perkembangan mereka, diperlukan pendekatan atau metode tertentu. Cara berkomunikasi dengan anak adalah dengan memberi tahu mereka tentang apa yang terjadi, memberi mereka kesempatan untuk menyentuh alat, menggunakan nada suara yang jelas dan berbicara perlahan, dan menggunakan sentuhan non-verbal yang disetujui anak. Memberikan mainan untuk memudahkan komunikasi, menjaga jarak saat berbicara, menghindari konfrontasi langsung, tidak duduk terlalu dekat atau berhadapan, dan mengalihkan perhatian saat berkomunikasi juga dapat digunakan (Anjaswarni, 2016), (Damayanti, 2023).

Berikut tehnik komunikasi pada bayi dan anak, Yang dikutip Widiyanto (2023) dari beberapa sumber:

1. Menggunakan Sentuhan Lembut dan Tatapan Mata

Bayi memiliki komunikasi verbal yang sangat terbatas, jadi perawat harus menggunakan sentuhan lembut, tatapan mata, dan perubahan ekspresi wajah untuk membuat bayi nyaman dan tenang.

Sebagai contoh : ketika perawat melaksanakan perasat memandikan bayi, perawat dapat melakukannya dengan penuh kelembutan, mengusap dan menyeka perlahan sambil menatap dan tersenyum pada bayi.

2. Berbicara dengan suara Lembut

Anak-anak sangat sensitif terhadap nada suara. Menggunakan nada suara yang lembut dapat membantu anak merasa aman dan nyaman selama proses pemberian tindakan, terutama dalam situasi yang mungkin menimbulkan ketakutan atau kecemasan.

Contoh : Saat perawat menyarankan anak untuk menghabiskan porsi makanan yang telah disajikan, "ayo sayang.. dihabiskan makannya yaa.. setelah itu bisa minum obat dan istirahat..."

3. Menggunakan Alat Permainan

Menggunakan mainan untuk mengalihkan perhatian anak dari hal-hal yang mungkin menakutkan atau menyakitkan bagi anak, dengan permainan yang disukai oleh anak seperti menggambar, mobil-mobilan, boneka, robot, dan lain-lain. Hal ini juga merupakan cara anak untuk berinteraksi dan mengekspresikan dirinya dengan mainan disukai.

Contoh: ketika akan merawat luka pada kaki anak, perawat dapat memberikan mainan visual seperti buku gambar, boneka atau robot-robotan.

4. Mendengarkan Aktif dan Memvalidasi Perasaan Anak

Mendengar aktif merupakan salah satu keterampilan yang harus dilakukan Perawat, menunjukkan rasa empati dan membantu anak-anak menyampaikan perasaan mereka dengan cara yang mudah dipahami, meskipun anak-anak mungkin belum dapat mengungkapkan emosi mereka secara verbal dengan sempurna.

Contoh: pada saat anak mengungkapkan rasa takutnya terhadap tindakan medis, "... aku takut sekali...nanti sakit..? Perawat dapat menjawabnya dengan lembut dengan ekspresi wajah senyum.. "jangan takut yaa.. hanya sebentar.. dan tidak sakit, agar cepat sembuh dan bermain kembali.."

5. Penggunaan Bahasa yang Sederhana dan Jelas

Tidak semua anak dapat memahami apa yang disampaikan oleh perawat, maka menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas ucapannya sangat penting untuk diperhatikan ketika berkomunikasi dengan anak, menghindari kata-kata sulit agar anak tidak bingung. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan anak memahami pesan yang disampaikan.

Contoh : Saat perawat akan melakukan pemeriksaan fisik pada seorang anak yang sedang demam tinggi, "tolong buka ketiaknya sedikit.. saya akan letakkan alat pengukur panas ini untuk mengetahui keadaan demamnya.."

6. Memberikan pilihan

Anak-anak akan merasa lebih berdaya jika diberi pilihan dalam situasi yang membuat mereka cemas. Perawat dapat mengurangi perasaan dengan memberi mereka pilihan yang aman dan terkendali.

Contoh ""Apakah kamu ingin saya memulai dengan tangan kanan atau kiri saat memeriksa tekanan darah?"

7. Bermain Peran

Untuk anak-anak di prasekolah dan sekolah dasar, bermain peran adalah teknik komunikasi yang sangat efektif. Ini memungkinkan anak untuk meniru kondisi medis mereka dan memahami apa yang akan terjadi. Boneka atau alat permainan medis dapat digunakan untuk bermain peran.

Contoh: pada anak yang tidak mau maka perawat dapat mengajak anak bermain peran menggunakan boneka sebagai pasien yang sedang diberi makan oleh ibunya. Hal ini dapat memotivasi anak untuk meniru dan menghabiskan makannya.

8. Memanfaatkan keheningan

Dalam beberapa situasi, memberi anak waktu untuk berpikir dan mengungkapkan perasaannya tanpa tekanan adalah pilihan yang baik.

Contoh: Perawat dapat tetap diam sejenak setelah menginformasikan anak tentang prosedur yang akan datang, memberikan waktu bagi anak untuk bertanya atau mengungkapkan perasaan mereka dengan tenang.

E. Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan komunikasi terapeutik pada anak?
 - A. Proses komunikasi yang hanya berfokus pada informasi medis kepada anak.
 - B. Interaksi antara tenaga kesehatan dan anak yang bertujuan untuk membangun hubungan yang terapeutik dan mendukung proses penyembuhan.
 - C. Komunikasi yang hanya terjadi antara orang tua dan anak tanpa keterlibatan tenaga kesehatan.
 - D. Teknik komunikasi yang digunakan hanya dalam kondisi darurat medis.
 - E. Cara berkomunikasi yang tidak mempertimbangkan kondisi psikologis anak.
2. Salah satu tujuan utama komunikasi terapeutik pada anak adalah...
 - A. Menggunakan bahasa teknis tanpa perlu penyesuaian dengan usia anak.
 - B. Memberikan instruksi tanpa mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan anak.
 - C. Menyampaikan informasi medis dengan bahasa yang sulit agar anak belajar memahami istilah kedokteran.
 - D. Menghindari komunikasi langsung dengan anak dan hanya berbicara dengan orang tua atau wali.
 - E. Menciptakan hubungan yang mendukung kenyamanan dan keamanan emosional anak selama perawatan.

3. Pada tahap perkembangan komunikasi anak usia 0-12 bulan, bentuk komunikasi yang paling dominan adalah?
 - A. Penggunaan kata-kata sederhana untuk menyampaikan kebutuhan.
 - B. Komunikasi verbal yang jelas dengan kalimat lengkap.
 - C. Isyarat nonverbal seperti menangis, tersenyum, dan mengoceh (babbling).
 - D. Kemampuan untuk memahami instruksi kompleks.
 - E. Percakapan dua arah dengan struktur bahasa yang baik.
4. Bentuk komunikasi prabicara yang umum digunakan oleh bayi sebelum mereka dapat berbicara adalah?
 - A. Menggunakan kalimat lengkap untuk menyampaikan kebutuhan.
 - B. Menangis, tersenyum, mengoceh (babbling), dan gerakan tubuh.
 - C. Menggunakan tulisan atau gambar untuk berkomunikasi.
 - D. Berbicara dengan kata-kata yang jelas dan terstruktur.
 - E. Menggunakan bahasa isyarat resmi seperti yang digunakan oleh tunarungu.
5. Teknik komunikasi yang paling efektif dalam berinteraksi dengan bayi adalah?
 - A. Menggunakan suara lembut, ekspresi wajah ramah, dan sentuhan lembut.
 - B. Memberikan instruksi verbal yang panjang dan kompleks.
 - C. Menggunakan bahasa formal seperti berbicara dengan orang dewasa.
 - D. Mengabaikan respons bayi karena mereka belum memahami komunikasi.
 - E. Mengajukan pertanyaan terbuka untuk merangsang diskusi panjang.
6. Saat berkomunikasi dengan anak usia prasekolah (3-5 tahun), teknik yang tepat adalah?
 - A. Hanya berbicara dengan orang tua tanpa melibatkan anak dalam percakapan.
 - B. Memberikan informasi dengan istilah teknis agar anak belajar lebih cepat.
 - C. Menghindari kontak mata untuk menghindari distraksi.
 - D. Menggunakan bahasa sederhana, intonasi yang ramah, serta bercerita.
 - E. Memberikan banyak instruksi sekaligus agar anak cepat memahami.

Essay:

1. Sebutkan pengertian komunikasi terapeutik pada anak secara benar!
2. Jelaskan Tujuan komunikasi terapeutik pada Anak!
3. Jelaskan Perkembangan komunikasi pada anak yang saudara ketahui!
4. Jelaskan tehnik komunikasi terapeutik yang baik pada Anak!
5. Jelaskan komunikasi verbal dan nonverbal pada bayi dan anak!

Kunci Jawaban

1. B
2. E
3. C
4. B
5. A
6. D

F. Rangkuman Materi

Komunikasi terapeutik antara perawat dan pasien anak dimaksudkan untuk kesembuhan. Saat berkomunikasi dengan anak, hal-hal seperti perkembangan mereka, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain, dan peran orang ketiga seperti orang tua dan orang terdekat pasien dalam membantu proses komunikasi adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perawat dapat melakukan asuhan keperawatan dengan benar dan dengan cara yang tepat.

Pada perkembangan komunikasi anak usia toddler dan prasekolah, anak sudah mampu berkomunikasi secara verbal ataupun nonverbal. Anak sudah mampu menyatakan keinginan dengan menggunakan kata-kata yang sudah dikuasainya. Perkembangan komunikasi usia sekolah dan remaja, anak sudah mampu untuk memahami komunikasi penjelasan sederhana yang diberikan. Pada masa ini, anak akan banyak mencari tahu terhadap hal-hal baru dan akan belajar menyelesaikan masalah yang dihadapinya berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.

Komunikasi pra-bicara sementara pada bayi adalah tangisan, celoteh, isyarat, dan ekspresi emosional. Untuk tehnik komunikasi pada anak dapat dilakukan dengan cara Menggunakan sentuhan lembut dan tatapan mata, Berbicara dengan suara Lembut, Menggunakan Alat Permainan, Mendengarkan Aktif dan Memvalidasi Perasaan Anak, Penggunaan Bahasa yang Sederhana dan Jelas, Memberikan pilihan, Bermain Peran, dan Memanfaatkan keheningan.

G. Glosarium

Anak

Individu yang berada dalam rentang usia 0–18 tahun, yang sedang mengalami proses tumbuh kembang secara fisik, psikologis, emosional, dan sosial.

Asuhan Keperawatan

Proses sistematis yang dilakukan oleh perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien, termasuk anak-anak, untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Bahasa Tubuh

Komunikasi nonverbal yang disampaikan melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, postur, dan kontak mata, yang sangat penting dalam interaksi dengan anak.

Empati

Kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, termasuk anak, tanpa menghakimi, dan menjadi dasar penting dalam komunikasi terapeutik.

Komunikasi

Proses pertukaran informasi, pikiran, dan perasaan antara dua pihak atau lebih melalui kata-kata (verbal), gerakan (nonverbal), atau media lainnya.

Komunikasi Terapeutik

Bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mendukung proses penyembuhan, membangun hubungan yang saling percaya, serta membantu anak mengungkapkan perasaannya.

H. Daftar Pustaka

- Adolph, R. (2016). Buku Ajar Komunikasi terapeutik.
- Anjaswarni, T. (2016). Komunikasi dalam Keperawatan (Modul Bahan Ajar Cetak Keperawatan) (Eko Yuliastuti (ed.); 1st ed.). Kementerian Kesehatan RI.
- Damayanti, A. C., Ernawati, N., Supono, & Sulastyawati. (2023). Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat Dengan Kecemasan Anak Saat Hospitalisasi (Literature Review). *Jik : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 4(1), 9–18.
- Eka Putri, A. B., & Kamali, N. A. (2023). Perkembangan Berbicara Anak Usia Dini. *Smart Kids: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 5(1), 35–45. <https://doi.org/10.30631/smartkids.v5i1.131>

Ners, P. S., Tinggi, S., & Kesehatan, I. (n.d.). Komunikasi terapeutik pada pasien anak yang berhubungan dengan nutrisi dan metabolik anak.

Supriyatno, E., Aeni, W., & Fitriani. (2023). Buku Ajar Komunikasi Terapeutik Keperawatan. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2).

Widiyanto. B., et al., (2023). Buku Ajar Komunikasi Terapeutik.

Wong, D. L. (2009). Buku Ajar Keperawatan Pediatrik (1st ed.). Buku Kedokteran EGC.

BAB 8

KOMUNIKASI TERAPEUTIK PADA LANSIA

Tujuan Instruksional:

Mahasiswa dapat memahami, mengenali, dan memanfaatkan teknik komunikasi terapeutik saat berinteraksi dengan orang lanjut usia.

1. Mahasiswa dapat mengartikulasikan lingkungan komunikasi antara orang dewasa dan orang tua.
2. Mahasiswa dapat memanfaatkan teknik komunikasi saat berinteraksi dengan orang dewasa dalam berbagai aplikasi.
3. Karakteristik lanjut usia dapat dipahami oleh mahasiswa.
4. Perkembangan komunikasi pada lansia dapat dipahami oleh mahasiswa.
5. Mahasiswa dapat mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi di antara lansia.
6. Mahasiswa dapat secara efektif menavigasi dan mengatasi hambatan komunikasi yang dihadapi oleh orang lansia.
7. Mahasiswa mempunyai kemampuan untuk menerapkan metode komunikasi terapeutik yang dirancang untuk orang lansia.
8. Komunikasi terapeutik dapat dilakukan secara efektif oleh mahasiswa saat berinteraksi dengan individu lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik dan mental.
9. Mahasiswa dapat menerapkan teknik komunikasi dengan orang lansia.

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep-konsep penting yang terkait dengan komunikasi terapeutik pada lansia.
2. Mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktik melalui analisis kasus dan penerapan prinsip-prinsip komunikasi terapeutik dalam skenario klinis.

Psikomotor:

1. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik secara tepat.

Afektif:

1. Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati, dan etika profesional dalam

- berinteraksi dengan lansia dan keluarga, serta dalam tim perawatan kesehatan.
2. Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan efektif dan jelas, baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya.

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK	
CPL	Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien, keluarga, kelompok khusus atau tenaga kesehatan lainnya dengan tahap-tahap komunikasi, menghadirkan diri dan tehnik-tehnik komunikasi yang tepat.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK	Bila diberikan pengalaman belajar di kelas, mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan, sikap dan keterampilan praktik dan aktifitas menerapkan komunikasi terapeutik yang efektif pada lansia.
Sub-CPMK	
Sub-CPMK 1	Mahasiswa dapat mengartikulasikan lingkungan komunikasi antara orang dewasa dan orang tua.
Sub-CPMK 2	Mahasiswa dapat memanfaatkan teknik komunikasi saat berinteraksi dengan orang dewasa dalam berbagai aplikasi.
Sub-CPMK 3	Karakteristik lanjut usia dapat dipahami oleh mahasiswa.
Sub-CPMK 4	Perkembangan komunikasi pada lansia dapat dipahami oleh mahasiswa.
Sub-CPMK 5	Mahasiswa dapat mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi di antara lansia.
Sub-CPMK 6	Mahasiswa dapat secara efektif menavigasi dan mengatasi hambatan komunikasi yang dihadapi oleh orang lansia.
Sub-CPMK 7	Mahasiswa mempunyai kemampuan untuk menerapkan metode komunikasi terepeutik yang dirancang untuk orang lansia.
Sub-CPMK 8	Komunikasi terapeutik dapat dilakukan secara efektif oleh mahasiswa saat berinteraksi dengan individu lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik dan mental.

Sub-CPMK 9	Mahasiswa dapat menerapkan teknik komunikasi dengan orang lansia.
------------	---

Pendahuluan

Komunikasi terapeutik sangat penting dalam membantu pasien memecahkan masalah selama perawatan keperawatan. Perilaku seseorang, yang meliputi aktivitas fisik dan mental, terkait erat dengan keterampilan komunikasi dan juga dibentuk oleh faktor-faktor seperti usia, pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial, dan tujuan yang ingin dicapai.

Pentingnya komunikasi dalam memberikan asuhan keperawatan telah meningkat karena kemajuan dalam ilmu dan teknologi kedokteran, serta pergeseran dari fokus semata-mata pada perawatan pasien individual ke pendekatan yang lebih holistik. Di era progresif ini, peran komunikasi baik verbal maupun non-verbal dari pengasuh, yang sering kali merupakan individu terdekat dengan pasien, telah menjadi penting dalam memfasilitasi proses penyembuhan.

Komunikasi menjadi sesuatu yang cukup kompleks karena manusia itu beragam jenisnya. Ada berbagai karakter yang begitu unik dan beragam. Salah satu faktor yang membuat manusia menjadi beragam adalah usia. Usia manusia yang merentang dari masa bayi hingga tua adalah salah satu pembentuk karakter yang sangat universal.

Bab ini akan membahas komunikasi terapeutik di kalangan lansia. Penulisan ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami konsep komunikasi terapeutik dalam kelompok demografi ini. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa yang bergabung dalam program studi pendidikan profesi keperawatan.

Bab ini menguraikan lingkungan komunikasi antara orang dewasa dan lansia, mengeksplorasi metode komunikasi yang digunakan oleh orang dewasa dan penerapan praktisnya, mengkaji sifat-sifat lansia, dan membahas evolusi komunikasi pada kelompok usia ini beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, bab ini akan membahas hambatan komunikasi yang dihadapi oleh lansia dan strategi untuk mengatasinya, strategi komunikasi terapeutik untuk lansia, interaksi terapeutik dengan lansia yang mengalami tantangan fisik atau mental, serta teknik komunikasi yang disesuaikan untuk lansia.

Uraian Materi

Bab ini menguraikan unsur-unsur yang terkait dengan komunikasi antara orang dewasa dan orang lanjut usia, termasuk lingkungan komunikasi untuk kelompok-kelompok ini, teknik-teknik efektif untuk komunikasi orang dewasa dan penggunaannya, ciri-ciri orang lanjut usia, evolusi komunikasi pada individu yang lebih tua, faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi mereka, kendala yang mereka hadapi dan strategi untuk mengatasinya, metode komunikasi terapeutik untuk orang lanjut usia, dan pendekatan-pendekatan yang disesuaikan bagi mereka yang memiliki tantangan fisik atau mental.

A. Suasana Komunikasi pada Orang Dewasa dan Lansia

Selain sikap, penting untuk fokus pada atau membina lingkungan yang mendukung komunikasi efektif di antara orang dewasa atau lansia. Berusahalah untuk menumbuhkan suasana komunikatif yang dapat memenuhi tujuan yang diinginkan.

a. Suasana hormat menghormati

Lingkungan yang saling menghargai mendorong komunikasi yang efektif antara orang dewasa dan orang lanjut usia, karena mereka merasakan kebahagiaan yang lebih besar ketika pandangan pribadi mereka diakui dan mereka memiliki kebebasan untuk berbagi pikiran mereka

b. Suasana saling menghargai

Setiap pendapat, perasaan, pikiran, ide, dan sistem nilai yang dianut patut dihormati. Merendahkan harga diri seseorang dan mengabaikan perspektifnya dapat menghambat komunikasi yang efektif.

c. Suasana saling percaya

Saling percaya bahwa informasi yang disampaikan dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Jangan menyanggah apa yang dikatakan orang dewasa atau lansia karena ini akan membuat mereka tidak percaya dengan Anda dan mengakibatkan tujuan komunikasi tidak tercapai.

d. Suasana saling terbuka

Bagi orang dewasa maupun lansia, keterbukaan dalam komunikasi sangat diperlukan. Terbuka berarti mendengarkan orang lain dan terbuka untuk mengungkapkan diri. Setiap alternatif hanya dapat dieksplorasi ketika kita terbuka.

Semua jenis komunikasi harus saling mendukung satu sama lain, baik verbal maupun nonverbal. Perilaku nonverbal sangat penting pada orang dewasa dan orang tua, seperti halnya komunikasi pada anak-anak. Status emosional orang

dewasa dan lansia dapat terlihat pada nada suara, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah.

Ketika orang dewasa yang sakit dan dirawat di rumah sakit berada di sekitar orang yang berwenang, mereka dapat merasa tidak berdaya, tidak aman, dan tidak mampu. Orang lain memutuskan kapan mereka makan dan tidur, mengubah status kemandirian mereka. Ketika orang dewasa tidak berdaya dan cemas, ini merupakan pengalaman yang mengancam dirinya, dan ini dapat terungkap dalam bentuk kemarahan dan agresi.

Pasien dewasa akan mampu menunjukkan perilaku yang adaptif dan mencapai penerimaan terhadap masalahnya jika para profesional berkomunikasi dengan cara yang sesuai dengan konteks pasien sebagai orang dewasa.

B. Teknik Komunikasi pada Orang Dewasa dan Penerapannya

Jika Anda ingin berbicara dengan orang dewasa, Anda harus menggunakan teknik komunikasi berikut ini.

- a. Memberikan penjelasan langsung kepada penerima tanpa perantara. Ini akan membuat penjelasan lebih mudah diterima oleh penerima. Penggunaan telepon atau media komunikasi lainnya, seperti pesan tertulis, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman karena tidak adanya umpan balik langsung yang dapat digunakan untuk evaluasi.
- b. Dalam komunikasi antara perawat dan pasien dewasa, terdapat hubungan saling memengaruhi, di mana kedua belah pihak harus berada dalam posisi yang seimbang tanpa ada yang mendominasi. Perawat sebaiknya tidak selalu mengambil kendali penuh agar pasien tetap memiliki kemandirian dan kepatuhan yang bersifat alami. Pendekatan ini menitikberatkan pada hubungan yang saling mendukung.
- c. Interaksi langsung dan timbal balik dalam komunikasi dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Hubungan yang baik antara perawat dan pasien ditunjukkan melalui komunikasi yang bersifat dua arah dan saling menghargai.
- d. Komunikasi bersifat berkelanjutan, tidak statis, dan selalu dinamis, mengikuti perkembangan situasi dan kebutuhan pasien.

C. Karakteristik Lansia

Lansia, atau lanjut usia, merupakan fase kehidupan yang pasti akan dialami oleh setiap individu yang mencapai usia tua. Lansia adalah kelompok usia yang telah memasuki tahap akhir dalam siklus kehidupan. Menurut Badan Koordinasi Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN), batasan usia lanjut ditentukan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu aspek biologis, ekonomi, dan sosial (BKKBN dalam Anjaswarni, 2016).

Dari segi biologis, lansia merupakan kelompok individu yang mengalami proses penuaan secara bertahap, yang ditandai dengan penurunan daya tahan fisik. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai penyakit yang dapat berujung pada kematian. Penurunan tersebut terjadi akibat perubahan dalam struktur serta fungsi jaringan, sel, dan sistem organ tubuh. (Anjaswarni, 2016).

Didekati dengan cara yang berbeda dengan orang tua karena perubahan yang terjadi pada mereka secara fisik, mental, atau emosi, serta berbagai aspek sosial dan spiritual. Oleh karena itu, para perawat dan tenaga kesehatan harus memahami karakter orang tua agar mereka dapat berkomunikasi dengan mereka dengan baik dan tepat sasaran. Memahami karakter ini akan membantu perawat menggunakan model komunikasi dan teknik komunikasi yang tepat (Prabowo, 2020).

Usia lanjut sering kali dipandang sebagai periode kemunduran, baik dari segi fisik maupun sosial. Namun, setiap individu mengalami masa tuanya dengan cara yang berbeda. Beberapa lansia melihat fase ini sebagai tahap penting dalam kehidupan yang memberikan kesempatan untuk terus berkembang dan berkontribusi. Di sisi lain, ada pula lansia yang merespons proses penuaan dengan sikap yang beragam, mulai dari kepasrahan pasif hingga penolakan, pemberontakan, dan keputusan (Anjaswarni, 2016).

Berdasarkan klasifikasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lansia dibagi menjadi empat kelompok usia:

1. *Middle age* (usia pertengahan): 45-59 tahun
2. *Elderly* (lansia): 60-70 tahun
3. *Old* (lansia tua): 75-90 tahun
4. *Very old* (lansia sangat tua): di atas 90 tahun

Selain itu, klasifikasi lansia berdasarkan usia kronologis terbagi menjadi:

1. *Young old*: 60-75 tahun
2. *Middle old*: 75-84 tahun
3. *Old-old*: di atas 85 tahun

Karakteristik orang tua sering berhubungan dengan kemunduran fisik dan penyakit yang disebabkan oleh menua. Perawat harus mengetahui permasalahan dan penyakit apa saja yang sering dialami oleh orang tua agar mereka dapat memahami pendekatan dan strategi komunikasi yang tepat untuk orang tua.

1. Cenderung mudah terjatuh
2. Cepat merasa lelah
3. Mengalami nyeri di area dada

4. Mengalami gangguan mental
5. Merasa sesak napas saat beraktivitas
6. Mengalami jantung berdebar (palpitasi)
7. Terjadi pembengkakan di bagian bawah kaki
8. Mengalami nyeri pada pinggang atau punggung
9. Merasakan nyeri di sendi pinggul
10. Berat badan mengalami penurunan
11. Kesulitan menahan buang air kecil (sering mengompol)
12. Kesulitan mengontrol buang air besar
13. Mengalami gangguan tidur
14. Merasa sering kedinginan
15. Mengalami kesemutan pada anggota tubuh
16. Rentan mengalami gatal-gatal
17. Sering merasa pusing
18. Mengalami sakit kepala

Masalah fisik dan penurunan fungsi panca indra sering menjadi penyebab gangguan komunikasi pada orang tua.

D. Perkembangan Komunikasi Pada Lanjut Usia

Meskipun batasan usia untuk menggolongkan orang tua sangat beragam, perubahan yang disebabkan oleh usia telah ditemukan. Ada perubahan neurologis dan sensorik, perubahan visual, dan perubahan pendengaran. Proses penerimaan dan interpretasi maksud komunikasi dapat terganggu oleh perubahan ini. Klien lansia juga mengalami kesulitan berkomunikasi karena perubahan ini. Selain itu, perubahan kognitif yang terjadi pada usia tua menyebabkan kesulitan komunikasi, yang berdampak pada tingkat inteligensi, kemampuan belajar, daya ingat, dan motivasi klien.

Penolakan terhadap kondisi lansia adalah reaksi yang sering terlihat sebagai perubahan emosi. Gejala penolakan yang menyebabkan ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan orang tua adalah:

1. Meragukan diagnosis, gejala, perkembangan penyakit, serta informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan.
2. Menyalahartikan atau mengubah informasi yang diterima sehingga menjadi tidak akurat.
3. Enggan membahas perawatan yang dijalani selama di rumah sakit.
4. Tidak mau terlibat dalam perawatan diri sendiri, terutama dalam tindakan yang langsung berkaitan dengan kesehatannya.

5. Menolak mengikuti anjuran medis, seperti istirahat total atau perubahan posisi tidur, meskipun saran tersebut bertujuan untuk kenyamanan pasien.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komunikasi Dengan Lansia

1. **Faktor dari lansia:** Kecemasan dan penurunan fungsi sensorik (seperti gangguan pendengaran dan penglihatan), kurangnya kewaspadaan, pemikiran yang berulang seputar kesehatan, kehilangan respons terhadap lingkungan, kecenderungan mengenang masa lalu, serta ketakutan akan kehilangan kendali dan kematian.
2. **Faktor dari perawat:** Sikap dan perilaku perawat terhadap lansia serta kurangnya pemahaman perawat mengenai kondisi mereka.
3. **Faktor lingkungan:** Suasana yang bising dapat menyebabkan lansia kebingungan dan kesulitan memahami pesan yang disampaikan.

F. Hambatan Komunikasi Pada Lansia dan Cara Mengatasi

Keterbatasan fisik yang disebabkan oleh proses menua, juga dikenal sebagai proses menua, berhubungan dengan hambatan komunikasi yang efektif pada orang tua, antara lain:

1. Distraksi internal
2. Overload sensasi
3. Gangguan neurologis
4. Keterbatasan pengetahuan
5. Keterbatasan bahasa
6. Situasi yang tidak sesuai
7. Perbedaan budaya

Penguasaan terhadap teknik mengatasi hambatan komunikasi diperlukan untuk berkomunikasi dengan lebih baik dengan orang tua. Ini adalah beberapa cara untuk mengatasi kesulitan berkomunikasi dengan orang tua.

1. Menurunkan tingkat kebisingan.
2. Menjadi pendengar yang setia dan sediakan waktu untuk berbicara.
3. Pastikan alat bantu dengar berfungsi dengan baik.
4. Pastikan kacamata bersih dan pas.
5. Jangan berbicara dengan keras atau berteriak, tetapi bicara langsung dengan telinga yang dapat mendengar dengan lebih baik.
6. Berdiri di depan klien, jangan terlalu jauh dari orang tua.
7. Gunakan kata-kata yang sederhana dan pendek.
8. Beri kesempatan bagi klien untuk berpikir.

9. Dorong mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial seperti perkumpulan orang tua.
10. Berbicara pada tingkat pemahaman klien.
11. Selalu bertanya, terutama saat mengajarkan tugas atau keahlian.

G. Pendekatan Komunikasi Terapeutik Pada Lanjut Usia

Berkomunikasi dengan lansia merupakan tantangan yang lebih kompleks dan beragam dibandingkan dengan individu yang lebih muda. Faktor budaya sering memengaruhi cara lansia memahami penyakit dan kesediaan mereka dalam mengikuti rencana perawatan serta pengobatan. Untuk mengurangi hambatan komunikasi dan dampak negatif yang mungkin terjadi, diperlukan interaksi yang efektif antara perawat dan lansia. (Anjaswarni, 2016).

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan perawat untuk meningkatkan komunikasi mereka dengan klien yang lebih tua.

1. Buat suasana yang menyenangkan dan usahakan berhubungan langsung dengan klien secara fisik dan emosional.
2. Beri instruksi dan informasi untuk memulai komunikasi.

Pedoman yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Beri waktu tambahan. Klien yang lebih tua biasanya menginginkan informasi yang lebih rinci dan lebih banyak dibandingkan dengan klien yang lebih muda. Mengingat ada beberapa orang tua mungkin berkomunikasi kurang baik dan kurang fokus, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama, diberikan waktu tambahan.
2. Hindari menjadi tidak peduli. Klien yang lebih tua ingin tahu bahwa perawat menyediakan waktu yang baik untuk mereka. Kesan pertama harus dibuat dalam 60 detik pertama.
3. Berdiri di depan klien. Klien yang mengalami gangguan pendengaran akan membaca bibir untuk menerima informasi dari perawat.
4. Terus berkomunikasi dengan perawat. Dalam komunikasi nonverbal, kontak mata sangat penting. Untuk menumbuhkan kepercayaan klien, beritahu klien bahwa perawat senang bertemu dengannya. Memelihara kontak mata adalah hal yang baik dan dapat membuat klien lebih terbuka untuk mendapatkan informasi tambahan.
5. Mendengarkan, mengurangi kesalahan komunikasi dengan mendengarkan cerita pasien lansia.
6. Bicara dengan jelas dan nyaring tentang rencana,

7. Gunakan kata-kata yang sederhana, pendek, dan singkat untuk membuat pasien lansia lebih mudah diterima.
8. Fokuskan pada satu pembicaraan karena klien yang lebih tua tidak dapat fokus pada banyak topik.
9. Beri catatan untuk instruksi yang rumit agar klien tidak bingung.
10. Gunakan gambar atau tabel untuk membuatnya lebih mudah dipahami.
11. Ringkas poin utama untuk topik utama diskusi.
12. Beri kesempatan kepada orang tua untuk bertanya.
13. Cari tempat yang tenang untuk menghindari kebingungan dan menciptakan suasana komunikasi yang kondusif.
14. Gunakan sentuhan untuk membuat orang tua merasa nyaman dan sebagai cara perawat memperhatikan mereka.

H. Komunikasi Terapeutik dengan Lansia yang Mengalami Masalah Fisik maupun Mental

1. Lansia dengan Gangguan Pendengaran

- a. Berdiri di dekat klien saat berbicara.
- b. Berbicara ke arah telinga yang lebih baik.
- c. Menjaga kontak mata dan menunjukkan ekspresi wajah dengan jelas.
- d. Menyebut nama klien sebelum memulai percakapan.
- e. Berbicara dengan suara jelas, pelan, dan langsung menghadap klien.
- f. Menghindari gerakan bibir yang berlebihan.
- g. Tidak berbicara sambil berbalik atau berpaling.
- h. Jika klien belum memahami, ulangi dengan kata-kata berbeda.
- i. Mengurangi kebisingan di sekitar.
- j. Menggunakan intonasi yang sesuai.
- k. Memberikan panduan sederhana agar komunikasi lebih mudah dipahami.
- l. Menghindari pertanyaan tertutup dan menggunakan kalimat pendek.
- m. Menggunakan bahasa tubuh yang selaras dengan pembicaraan.

2. Lansia dengan Ketulian (Deaf)

Lansia dengan ketulian memiliki kebutuhan komunikasi serupa dengan mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi perlu beberapa metode tambahan:

- a. Menulis pesan jika klien bisa membaca.
- b. Menggunakan gambar atau alat bantu komunikasi lainnya.
- c. Menyampaikan pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas.
- d. Memanfaatkan berbagai metode komunikasi, seperti bahasa tubuh.

- e. Meluangkan waktu lebih banyak bersama klien untuk memastikan pemahaman.

3. Lansia dengan Gangguan Penglihatan

- a. Mengenalkan diri dan mendekati klien dari depan.
- b. Menjelaskan kondisi lingkungan sekitar.
- c. Memberi tahu klien sebelum meninggalkan ruangan.
- d. Menyediakan bantuan, seperti pencahayaan tambahan atau membacakan sesuatu.
- e. Membiarkan klien memegang tangan perawat sebagai panduan.
- f. Menjelaskan rute yang biasa dilalui klien.
- g. Memberikan pujian atas kemandirian dan fleksibilitas klien.

4. Lansia dengan Afasia

Afasia adalah gangguan bahasa akibat cedera atau penyakit otak, seperti stroke, cedera kepala, atau tumor otak. Gangguan ini menyebabkan kesulitan dalam membaca, menulis, berbicara, memahami, dan menafsirkan komunikasi nonverbal. Pendekatan komunikasi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Berhadapan langsung dengan klien dan menjaga kontak mata.
- b. Bersikap sabar dan menyediakan waktu yang cukup.
- c. Jujur dalam berkomunikasi, termasuk jika tidak memahami ucapan klien.
- d. Menyesuaikan metode komunikasi terbaik bagi klien, misalnya dengan bahasa tubuh atau gambar.
- e. Memberikan kesempatan bagi klien untuk menulis dan mengungkapkan pikirannya.
- f. Membantu klien membaca dengan jelas. Menggunakan gerakan tangan untuk memperjelas pembicaraan.
- g. Memanfaatkan sentuhan untuk memberikan kenyamanan dan meningkatkan fokus.

5. Lansia dengan Penyakit Alzheimer

- a. Selalu berbicara dari arah depan klien.
- b. Menggunakan nada bicara yang normal dan tidak berlebihan.
- c. Menjaga kontak mata dan mengurangi stimulasi berlebihan di sekitar.
- d. Mengikuti ritme komunikasi klien.
- e. Menjaga jarak yang nyaman.
- f. Mengajukan pertanyaan satu per satu.
- g. Memberikan ekspresi yang ramah dan tersenyum saat memahami ucapan klien.

6. Lansia yang Menunjukkan Kemarahan

- a. Menjelaskan alasan yang mungkin menyebabkan klien marah.

- b. Membantu klien mengekspresikan kemarahan dengan cara yang lebih konstruktif.
- c. Menggunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong komunikasi.
- d. Meluangkan waktu secara rutin untuk berinteraksi dengan klien.
- e. Menghargai dan memberikan apresiasi atas setiap usaha klien.

7. Lansia yang mengalami kecemasan:

- a. Dengarkan apa yang dibicarakan klien
- b. Berikan penjelasan yang ringkas dan jelas tentang apa yang terjadi
- c. Identifikasi sumber-sumber yang menyebabkan ketegangan atau kecemasan
- d. Berkolaborasi dengan staf dan anggota keluarga

8. Lansia yang menunjukkan penolakan:

- a. Perlahan-lahan menyampaikan kenyataan
- b. Tidak mendukung penolakan klien
- c. Bantu klien mengungkapkan keresahan atau perasaan sedihnya
- d. Libatkan keluarga

9. Lansia yang mengalami depresi:

- a. Lakukan kontak sesering mungkin
- b. Beri perhatian terus menerus
- c. Libatkan klien dalam menolong dirinya sendiri
- d. Gunakan pertanyaan terbuka
- e. Libatkan staf dan anggota dalam memberikan perhatian

Secara khusus, terdapat empat metode utama dalam menangani lansia, yaitu pendekatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing metode tersebut:

1. Pendekatan Fisik

Pendekatan ini berfokus pada pemantauan kesehatan secara menyeluruh, termasuk kebutuhan medis, perubahan organ tubuh, tingkat kesehatan yang dapat dicapai dan ditingkatkan, serta pencegahan penyakit agar tidak berkembang lebih lanjut. Karena aspek fisik dapat diamati dengan jelas, metode ini cenderung lebih mudah diterapkan dan solusinya lebih cepat ditemukan.

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini lebih abstrak dan bertujuan untuk mengubah perilaku, sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam penerapannya. Perawat dapat berperan sebagai konselor, advokat, pendukung, serta penerjemah dalam situasi

tertentu. Selain itu, mereka juga bisa menjadi tempat berbagi rahasia dan teman dekat bagi lansia.

3. Pendekatan Sosial

Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lansia dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Agar lansia dapat bersosialisasi dengan tenaga kesehatan atau sesama lansia, pendekatan ini dapat dilakukan melalui percakapan, diskusi, permainan, atau aktivitas kelompok lainnya.

4. Pendekatan Spiritual

Dalam pendekatan ini, perawat berupaya membantu lansia mencapai ketenangan batin melalui hubungan dengan Tuhan atau keyakinan yang dianut, terutama saat mereka mengalami sakit atau berada dalam kondisi terminal. Pendekatan ini sangat efektif, terutama bagi lansia yang memiliki kesadaran diri tinggi dan latar belakang keagamaan yang kuat.

I. Teknik Komunikasi dengan Lansia

Berbagai teknik komunikasi dapat diterapkan oleh perawat saat berinteraksi dengan lansia (Mundakir, 2006), di antaranya:

1. Teknik Asertif

Asertivitas dalam komunikasi berarti menerima dan menghargai lansia apa adanya. Perawat menunjukkan sikap peduli, sabar dalam mendengarkan, serta berusaha memahami kondisi mereka. Sikap ini membantu membangun hubungan terapeutik yang baik dengan lansia.

2. Teknik Responsif

Teknik ini menuntut perawat untuk merespons secara cepat terhadap perubahan yang terjadi pada lansia serta memberikan klarifikasi jika diperlukan. Respon aktif ini dapat membantu lansia merasa tenang dan dipahami. Contoh: *"Bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa yang bisa saya bantu?"*

3. Teknik Fokus

Lansia sering kali berbicara panjang lebar dan terkadang menyimpang dari topik utama. Oleh karena itu, perawat harus tetap fokus dalam komunikasi dan mengarahkan pembicaraan kembali ke topik yang lebih relevan dengan tujuan terapi.

4. Teknik Suportif

Lansia cenderung mengalami ketidakstabilan emosi, sehingga perawat perlu memberikan dukungan agar mereka merasa lebih tenang dan percaya diri. Contoh: Ketika lansia mengungkapkan perasaan mereka, perawat dapat menunjukkan sikap hormat dengan mengangguk dan tersenyum, sehingga lansia

merasa dihargai. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dan mendorong mereka untuk tetap mandiri.

Ucapan seperti: *"Saya yakin Anda bisa melakukannya dengan baik. Jika Anda membutuhkan bantuan, saya siap membantu."* dapat memberikan motivasi bagi lansia.

5. Teknik Klarifikasi

Teknik ini digunakan untuk memperjelas informasi yang disampaikan lansia, terutama karena perubahan kognitif yang dapat menghambat komunikasi. Perawat dapat mengajukan pertanyaan ulang atau meminta lansia menjelaskan kembali agar terjadi pemahaman yang sama.

Contoh: *"Bisakah Ibu menjelaskan kembali bagaimana perasaan Ibu saat ini?"*

6. Kesabaran dan Ketulusan

Seiring bertambahnya usia, beberapa lansia mengalami perubahan yang terkadang tampak kekanak-kanakan. Oleh karena itu, perawat harus menghadapi kondisi ini dengan kesabaran dan ketulusan agar komunikasi tetap efektif dan hubungan dengan lansia tetap terjalin dengan baik.

J. Latihan Soal

1. Bagaimana cara menciptakan suasana komunikasi yang efektif dengan orang dewasa dan lansia?
 - A. Berbicara dengan nada tinggi agar mudah terdengar
 - B. Menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas
 - C. Menghindari kontak mata agar tidak membuat mereka canggung
 - D. Mengabaikan respons mereka jika tidak sesuai harapan
 - E. Memberikan informasi dengan cepat tanpa memperhatikan reaksi
2. Teknik komunikasi apa yang paling efektif diterapkan pada orang dewasa untuk memastikan pesan dipahami dengan baik?
 - A. Memberikan penjelasan panjang tanpa jeda
 - B. Menggunakan contoh nyata yang relevan dengan pengalaman mereka
 - C. Berbicara dengan cepat agar waktu lebih efisien
 - D. Menghindari diskusi agar tidak terjadi perdebatan
 - E. Menggunakan istilah teknis tanpa memberikan penjelasan
3. Apa karakteristik utama yang biasanya dimiliki oleh individu lanjut usia?
 - A. Kemampuan fisik yang meningkat seiring bertambahnya usia
 - B. Penurunan fungsi kognitif dan fisik secara bertahap

- C. Ketergantungan penuh pada orang lain dalam semua aktivitas
 - D. Tidak memerlukan interaksi sosial karena lebih suka menyendiri
 - E. Kemampuan belajar yang sepenuhnya hilang
4. Apa yang menjadi salah satu tantangan utama dalam perkembangan komunikasi pada lansia?
 - A. Meningkatnya kemampuan mendengar secara signifikan
 - B. Kesulitan memahami informasi yang kompleks
 - C. Tidak memerlukan komunikasi karena lebih fokus pada aktivitas fisik
 - D. Kemampuan berbicara yang meningkat drastis
 - E. Tidak adanya perubahan dalam kemampuan komunikasi
 5. Faktor apa yang paling memengaruhi efektivitas komunikasi pada lansia?
 - A. Gaya berpakaian orang yang berkomunikasi dengan mereka
 - B. Gangguan pendengaran dan penurunan fungsi kognitif
 - C. Tingginya tingkat pendidikan pada masa muda
 - D. Ketersediaan teknologi komunikasi modern
 - E. Usia orang yang berkomunikasi dengan mereka
 6. Apa yang menjadi salah satu hambatan utama dalam komunikasi dengan lansia?
 - A. Lansia selalu mengabaikan percakapan yang tidak menarik
 - B. Lingkungan yang terlalu bising dan gangguan pendengaran
 - C. Lansia lebih suka berbicara dibandingkan mendengarkan
 - D. Penggunaan bahasa yang terlalu sederhana dan lambat
 - E. Lansia cenderung tidak membutuhkan komunikasi yang intensif
 7. Apa pendekatan komunikasi terapeutik yang efektif untuk lansia?
 - A. Memberikan perintah langsung tanpa diskusi untuk menghindari kebingungan
 - B. Menggunakan bahasa tubuh yang mendukung, seperti kontak mata dan senyuman
 - C. Menghindari pembicaraan emosional agar suasana tetap netral
 - D. Berbicara dengan cepat untuk menghemat waktu mereka
 - E. Mengabaikan cerita masa lalu mereka karena tidak relevan dengan kondisi saat ini
 8. Pendekatan komunikasi terapeutik apa yang paling tepat untuk lansia dengan masalah fisik dan mental?
 - A. Menggunakan bahasa teknis untuk menjelaskan kondisi mereka secara rinci

- B. Memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk merespons dan mengekspresikan diri
 - C. Mengabaikan keluhan mereka jika dianggap tidak masuk akal
 - D. Menghindari komunikasi langsung untuk mencegah stres tambahan
 - E. Berbicara terus-menerus tanpa jeda untuk menjaga perhatian mereka
9. Teknik komunikasi terapeutik apa yang paling efektif untuk membangun hubungan yang baik dengan lansia?
- A. Memberikan perhatian penuh saat mereka berbicara
 - B. Menghindari pembicaraan yang melibatkan emosi
 - C. Memberikan jawaban singkat untuk menghemat waktu
 - D. Mengalihkan pembicaraan jika mereka membicarakan masa lalu
 - E. Menyampaikan informasi tanpa memperhatikan respons mereka
10. Apa teknik komunikasi terapeutik yang dapat membantu lansia dengan gangguan kognitif memahami informasi?
- A. Berbicara dengan cepat agar mereka tidak lupa
 - B. Menggunakan kalimat pendek dan sederhana
 - C. Menghindari kontak mata untuk mengurangi tekanan
 - D. Memberikan banyak informasi sekaligus untuk efisiensi
 - E. Mengulangi informasi tanpa memeriksa apakah mereka memahami

Latihan Kasus

Berikut ini sebuah skenario latihan kasus untuk memahami dan menerapkan komunikasi terapeutik pada lansia.

Kasus

Seorang wanita lansia berusia 75 tahun, Ny. Siti, datang ke puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Ia mengalami hipertensi dan gangguan pendengaran ringan. Saat berbicara, Ny. Siti sering mengulang cerita tentang masa mudanya dan tampak cemas mengenai pengobatan yang sedang dijalannya. Ny. Siti mengeluhkan bahwa ia merasa kesepian di rumah karena anak-anaknya sibuk bekerja, dan ia tidak ingin menjadi beban. Ia juga merasa khawatir karena tidak sepenuhnya memahami instruksi dokter tentang pengobatannya.

Tugas mahasiswa:

Berdasarkan kasus di atas

1. Identifikasi Masalah Komunikasi:
 - Apa saja hambatan komunikasi yang dihadapi oleh Ny. Siti?
 - Faktor apa saja yang memengaruhi komunikasi dengan Ny. Siti?

2. Rancang Pendekatan Komunikasi Terapeutik:
 - Bagaimana cara Anda membangun hubungan yang baik dengan Ny. Siti?
 - Teknik komunikasi apa yang Anda gunakan untuk membantu Ny. Siti memahami pengobatannya?
 - Bagaimana Anda akan merespons cerita masa lalu Ny. Siti?
3. Simulasi Komunikasi Terapeutik:
 - Dalam kelompok kecil, lakukan simulasi percakapan dengan peran:
 - Mahasiswa sebagai tenaga kesehatan.
 - Mahasiswa lain sebagai Ny. Siti.
 - Gunakan teknik komunikasi terapeutik, seperti mendengarkan aktif, empati, bahasa sederhana, dan perhatian terhadap respons Ny. Siti.
2. Refleksi:
 - Setelah simulasi, diskusikan dalam kelompok:
 - Apa yang berhasil dalam komunikasi Anda?
 - Apa yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas komunikasi terapeutik?

Kunci Jawaban:

1. Kunci Jawaban: B. Menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas

Pembahasan:

Komunikasi yang efektif dengan orang dewasa dan lansia membutuhkan pendekatan yang memperhatikan kondisi fisik, psikologis, dan emosional mereka. Penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas (opsi B) membantu memastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami, terutama jika mereka memiliki keterbatasan pendengaran atau kognitif.

- **Opsi A** salah, karena berbicara dengan nada tinggi bisa dianggap tidak sopan atau membuat mereka merasa tidak nyaman.
- **Opsi C** salah, karena kontak mata penting untuk menunjukkan perhatian dan rasa hormat.
- **Opsi D** salah, karena mengabaikan respons mereka dapat merusak hubungan komunikasi.
- **Opsi E** salah, karena memberikan informasi terlalu cepat tanpa memperhatikan reaksi dapat membuat mereka bingung atau merasa tidak dihargai.

Dengan menciptakan suasana yang tenang, menghormati pendapat, dan menyampaikan pesan dengan jelas, komunikasi akan lebih efektif dan bermakna.

2. Kunci Jawaban: B. Menggunakan contoh nyata yang relevan dengan pengalaman mereka

Pembahasan:

Orang dewasa cenderung belajar dan memahami informasi dengan lebih baik ketika pesan disampaikan menggunakan pendekatan yang relevan dengan pengalaman mereka. Teknik komunikasi seperti menggunakan contoh nyata (opsi B) membantu mereka menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimiliki, sehingga pesan menjadi lebih mudah dipahami dan diterapkan.

- **Opsi A** salah, karena penjelasan panjang tanpa jeda dapat membuat mereka kehilangan fokus.
- **Opsi C** salah, karena berbicara terlalu cepat dapat mengurangi pemahaman mereka terhadap informasi yang disampaikan.
- **Opsi D** salah, karena diskusi justru penting untuk memahami sudut pandang mereka dan memastikan komunikasi dua arah.
- **Opsi E** salah, karena istilah teknis tanpa penjelasan hanya akan membingungkan dan menghambat pemahaman.

Penerapan komunikasi yang efektif pada orang dewasa harus memperhatikan relevansi, partisipasi aktif, dan kejelasan dalam penyampaian pesan. Hal ini membantu mereka merasa dihargai dan lebih mudah memahami informasi yang diberikan.

3. Kunci Jawaban: B. Penurunan fungsi kognitif dan fisik secara bertahap

Pembahasan:

Karakteristik utama pada lanjut usia adalah adanya perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang terjadi secara bertahap. Penurunan fungsi kognitif dan fisik (opsi B) sering dialami, seperti menurunnya kekuatan otot, gangguan penglihatan atau pendengaran, serta kemampuan memori yang melemah. Namun, tingkat penurunan ini bervariasi tergantung pada kondisi kesehatan dan gaya hidup individu.

- **Opsi A** salah, karena kemampuan fisik umumnya menurun seiring bertambahnya usia, bukan meningkat.
- **Opsi C** salah, karena tidak semua lansia sepenuhnya bergantung pada orang lain; banyak yang tetap mandiri dalam aktivitas sehari-hari.
- **Opsi D** salah, karena meskipun beberapa lansia mungkin merasa nyaman dengan waktu sendiri, interaksi sosial tetap penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional mereka.

- **Opsi E** salah, karena kemampuan belajar tidak sepenuhnya hilang pada lansia; mereka masih dapat belajar hal baru, meskipun prosesnya mungkin lebih lambat dibandingkan usia muda.

Pemahaman terhadap karakteristik lansia penting untuk memberikan dukungan yang sesuai, baik dalam aspek kesehatan fisik maupun psikososial, sehingga kualitas hidup mereka tetap terjaga.

4. **Kunci Jawaban:** B. Kesulitan memahami informasi yang kompleks

Pembahasan:

Seiring bertambahnya usia, lansia cenderung mengalami perubahan dalam kemampuan komunikasi, seperti penurunan pendengaran, penglihatan, dan kemampuan kognitif. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan memahami informasi yang kompleks (opsi B), terutama jika disampaikan dengan cepat atau menggunakan istilah teknis yang tidak familiar.

- **Opsi A** salah, karena kemampuan mendengar cenderung menurun, bukan meningkat, akibat perubahan pada organ pendengaran.
- **Opsi C** salah, karena komunikasi tetap penting bagi lansia, terutama untuk menjaga kesehatan mental dan emosional.
- **Opsi D** salah, karena kemampuan berbicara tidak meningkat secara drastis, melainkan bisa menurun akibat kondisi kesehatan tertentu, seperti stroke atau gangguan bicara.
- **Opsi E** salah, karena kemampuan komunikasi pada lansia memang mengalami perubahan, baik secara fisik maupun kognitif.

Untuk mendukung perkembangan komunikasi pada lansia, penting untuk menggunakan bahasa yang sederhana, berbicara dengan jelas, serta memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk merespons. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan menjaga kualitas interaksi.

5. **Kunci Jawaban:** B. Gangguan pendengaran dan penurunan fungsi kognitif

Pembahasan:

Faktor utama yang memengaruhi komunikasi pada lansia adalah perubahan fisik dan kognitif yang terjadi seiring bertambahnya usia. Gangguan pendengaran dan penurunan fungsi kognitif (opsi B) adalah dua aspek yang sering kali menjadi penghambat komunikasi. Gangguan pendengaran dapat membuat mereka sulit menangkap pesan, sementara penurunan kognitif dapat memengaruhi pemrosesan informasi dan daya ingat.

- **Opsi A** salah, karena gaya berpakaian tidak secara langsung memengaruhi efektivitas komunikasi.

- **Opsi C** salah, karena tingkat pendidikan masa muda tidak selalu menentukan kemampuan komunikasi di usia lanjut.
- **Opsi D** salah, karena meskipun teknologi komunikasi modern dapat membantu, faktor utama tetap terletak pada kondisi fisik dan kognitif lansia.
- **Opsi E** salah, karena usia orang yang berkomunikasi dengan mereka tidak menjadi faktor utama dalam efektivitas komunikasi.

Untuk meningkatkan komunikasi dengan lansia, penting untuk berbicara dengan jelas, menggunakan bahasa sederhana, memberikan waktu bagi mereka untuk merespons, dan memastikan lingkungan yang kondusif (tanpa gangguan suara). Hal ini dapat membantu mengatasi hambatan yang disebabkan oleh gangguan pendengaran atau penurunan kognitif.

6. Kunci Jawaban: B. Lingkungan yang terlalu bising dan gangguan pendengaran
Pembahasan:

Salah satu hambatan utama dalam komunikasi dengan lansia adalah kombinasi antara faktor eksternal dan internal. Lingkungan yang terlalu bising dan gangguan pendengaran (opsi B) dapat membuat lansia sulit mendengar atau memahami percakapan dengan jelas. Hal ini sering terjadi karena sensitivitas pendengaran mereka menurun akibat proses penuaan.

- **Opsi A** salah, karena tidak semua lansia mengabaikan percakapan; hambatan biasanya terjadi karena faktor fisik atau kognitif.
- **Opsi C** salah, karena lansia tidak selalu lebih suka berbicara dibandingkan mendengarkan. Komunikasi dua arah tetap penting.
- **Opsi D** salah, karena penggunaan bahasa sederhana dan lambat justru membantu mereka memahami pesan dengan lebih baik.
- **Opsi E** salah, karena komunikasi tetap penting bagi lansia untuk menjaga kesehatan mental, sosial, dan emosional.

Untuk mengatasi hambatan ini, penting menciptakan lingkungan yang tenang, berbicara dengan jelas, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dengan lansia.

7. Kunci Jawaban: B. Menggunakan bahasa tubuh yang mendukung, seperti kontak mata dan senyuman
Pembahasan:

Pendekatan komunikasi terapeutik pada lansia bertujuan untuk menciptakan hubungan yang empatik, penuh perhatian, dan mendukung kebutuhan emosional mereka. Menggunakan bahasa tubuh yang mendukung, seperti kontak mata, senyuman, dan nada suara yang lembut (opsi B), dapat membantu

membangun rasa percaya dan kenyamanan. Pendekatan ini juga menunjukkan penghargaan terhadap mereka sebagai individu.

- **Opsi A** salah, karena memberikan perintah langsung tanpa diskusi dapat membuat lansia merasa tidak dihargai atau dikendalikan.
- **Opsi C** salah, karena pembicaraan emosional sering kali penting untuk membantu lansia merasa didengar dan dipahami.
- **Opsi D** salah, karena berbicara terlalu cepat dapat membuat mereka kesulitan memahami pesan yang disampaikan.
- **Opsi E** salah, karena cerita masa lalu sering kali menjadi bagian penting dari identitas lansia dan dapat digunakan untuk membangun koneksi yang lebih dalam.

Komunikasi terapeutik yang efektif melibatkan empati, kesabaran, dan perhatian terhadap kebutuhan fisik serta emosional lansia, sehingga mereka merasa dihargai dan didukung.

8. Kunci Jawaban: B. Memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk merespons dan mengekspresikan diri

Pembahasan:

Lansia dengan masalah fisik maupun mental membutuhkan pendekatan komunikasi terapeutik yang penuh empati, sabar, dan mendukung. Memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk merespons dan mengekspresikan diri (opsi B) adalah langkah penting untuk memastikan mereka merasa didengar dan dihargai. Hal ini juga membantu mengurangi tekanan akibat keterbatasan fisik atau kognitif yang mereka alami.

- **Opsi A** salah, karena penggunaan bahasa teknis tanpa penyesuaian dapat membuat mereka kebingungan dan merasa tidak dipahami.
- **Opsi C** salah, karena mengabaikan keluhan mereka dapat memperburuk kondisi emosional dan menurunkan kepercayaan mereka terhadap orang yang berkomunikasi.
- **Opsi D** salah, karena komunikasi langsung yang dilakukan dengan cara yang tepat justru membantu mengurangi rasa isolasi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
- **Opsi E** salah, karena berbicara terus-menerus tanpa jeda dapat membuat mereka kesulitan memahami pesan dan merasa kewalahan.

Pendekatan yang efektif mencakup komunikasi yang jelas, sabar, dan empatik, serta mempertimbangkan keterbatasan fisik dan mental lansia. Hal ini membantu menciptakan suasana yang mendukung untuk interaksi yang positif dan bermakna.

9. Kunci Jawaban: A. Memberikan perhatian penuh saat mereka berbicara

Pembahasan:

Memberikan perhatian penuh saat lansia berbicara menunjukkan bahwa Anda menghargai dan peduli terhadap mereka. Teknik ini membantu membangun rasa percaya dan meningkatkan kualitas komunikasi.

- **Opsi B** salah, karena pembicaraan emosional sering kali penting untuk memahami perasaan mereka.
- **Opsi C** salah, karena jawaban singkat dapat membuat mereka merasa diabaikan.
- **Opsi D** salah, karena membicarakan masa lalu sering menjadi cara lansia mengekspresikan diri dan mempererat hubungan.
- **Opsi E** salah, karena komunikasi yang efektif memerlukan perhatian pada respons mereka untuk memastikan pesan tersampaikan dengan baik.

10. Kunci Jawaban: B. Menggunakan kalimat pendek dan sederhana

Pembahasan:

Lansia dengan gangguan kognitif sering kali membutuhkan penyampaian informasi yang jelas dan sederhana. Menggunakan kalimat pendek dan sederhana (opsi B) memudahkan mereka memahami pesan tanpa merasa kewalahan.

- **Opsi A** salah, karena berbicara cepat dapat membuat mereka kesulitan memahami informasi.
- **Opsi C** salah, karena kontak mata penting untuk menunjukkan perhatian dan empati.
- **Opsi D** salah, karena memberikan banyak informasi sekaligus justru dapat membingungkan mereka.
- **Opsi E** salah, karena mengulangi informasi tanpa memastikan pemahaman tidak efektif.

Pendekatan yang tenang, jelas, dan sabar sangat membantu dalam komunikasi terapeutik dengan lansia, terutama yang mengalami gangguan kognitif.

K. Rangkuman Materi

Komunikasi terapeutik pada lansia merupakan keterampilan penting yang bertujuan untuk membangun hubungan yang empatik dan mendukung kebutuhan fisik, mental, dan emosional lansia. Pendekatan ini melibatkan penggunaan teknik komunikasi yang sensitif terhadap perubahan yang dialami lansia seiring bertambahnya usia.

Karakteristik Lansia yang Mempengaruhi Komunikasi:

1. Perubahan Fisik:

Lansia sering kali mengalami gangguan pendengaran, penglihatan, serta penurunan fungsi motorik yang dapat menghambat komunikasi verbal dan non-verbal.

2. Perubahan Kognitif:

Penurunan fungsi kognitif, seperti gangguan memori atau demensia, dapat membuat lansia kesulitan memahami informasi yang kompleks atau mengingat percakapan.

3. Perubahan Emosional:

Lansia mungkin mengalami perasaan kesepian, cemas, atau kehilangan, yang dapat memengaruhi cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.

Hambatan Komunikasi pada Lansia:

1. Gangguan Pendengaran dan Penglihatan:

Lansia dengan gangguan pendengaran atau penglihatan mungkin kesulitan mendengar atau melihat ekspresi wajah, sehingga mengurangi efektivitas komunikasi.

2. Gangguan Kognitif:

Penurunan memori atau kemampuan berpikir kritis dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami informasi atau mengingat percakapan sebelumnya.

3. Emosi dan Isolasi Sosial:

Perasaan cemas, kesepian, atau depresi dapat menghambat komunikasi dan membuat lansia kurang terbuka dalam berbicara.

Teknik Komunikasi Terapeutik pada Lansia:

1. Mendengarkan Aktif:

Mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan respons yang sesuai, dan menghindari gangguan adalah hal yang penting untuk membangun hubungan yang baik.

2. Menggunakan Bahasa Sederhana:

Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta berbicara dengan lambat dan jelas agar pesan dapat diterima dengan baik.

3. Empati dan Validasi:

Tunjukkan rasa empati dengan memahami perasaan lansia, serta validasi perasaan mereka untuk meningkatkan rasa dihargai dan didengar.

4. Memberikan Waktu untuk Merespons:

Berikan waktu yang cukup bagi lansia untuk merespons, terutama jika mereka mengalami kesulitan dalam berbicara atau berpikir.

5. Kontak Mata dan Bahasa Tubuh yang Mendukung:

Kontak mata yang baik dan bahasa tubuh yang terbuka dapat membantu menciptakan suasana yang nyaman dan menunjukkan perhatian.

6. Menghargai Cerita Masa Lalu:

Lansia sering kali ingin berbicara tentang pengalaman hidup mereka. Mendengarkan cerita masa lalu mereka dapat mempererat hubungan dan memberikan mereka rasa dihargai.

Pendekatan dalam Menghadapi Lansia dengan Masalah Fisik dan Mental:

1. Untuk lansia dengan gangguan fisik, seperti gangguan pendengaran, penting untuk berbicara dengan suara yang jelas dan menggunakan isyarat atau alat bantu komunikasi jika diperlukan.
2. Untuk lansia dengan gangguan mental atau kognitif, seperti demensia, gunakan kalimat pendek, sederhana, dan ulangi informasi jika diperlukan. Jangan terburu-buru dan beri waktu bagi mereka untuk memproses informasi.

Tujuan Komunikasi Terapeutik pada Lansia:

1. Meningkatkan kualitas hidup lansia dengan memberikan dukungan emosional, informasi yang jelas, dan perhatian terhadap kebutuhan mereka.
2. Mengurangi perasaan kesepian dan cemas dengan menciptakan hubungan yang penuh perhatian dan saling pengertian.
3. Membantu lansia dalam memahami instruksi medis dan mengelola kondisi kesehatan mereka dengan cara yang lebih mudah dipahami.
4. Komunikasi terapeutik dengan lansia membutuhkan pendekatan yang penuh empati, sabar, dan sensitif terhadap kebutuhan fisik dan emosional mereka. Dengan menggunakan teknik komunikasi yang tepat, kita dapat meningkatkan pemahaman, mengurangi kecemasan, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan lansia, sehingga mereka merasa dihargai dan didukung dalam kehidupan sehari-hari.

L. Glosarium

Empati, memahami perasaan orang lain tetapi tidak terlarut didalamnya, melakukan suatu tindakan dengan menggunakan cara berfikir orang tersebut.

Feedback, respon komunikasi terhadap pesan yang diterima baik secara verbal maupun non verbal.

Helping Relationship, komunikasi interpersonal yang bersifat mutualis untuk mengembangkan hubungan yang akan menghasilkan pemahaman tentang klien sebagai manusia yang utuh.

Identifikasi, mengikuti dan menerima jejak orang lain yang dianggap ideal bagi dirinya.

Komunikasi nonverbal, proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata.

Komunikasi terapeutik, komunikasi yang direncanakan secara sadar bertujuan dan kegiatannya difokuskan untuk kesembuhan pasien, dan merupakan komunikasi profesional yang mengarah pada tujuan untuk penyembuhan pasien.

Komunikasi verbal, komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal.

Simpaty, perasaan "hanyut" untuk mengikuti apa yang dirasakan oleh orang lain.

Supportif, sikap yang dapat menerima, berempati, dan mempunyai kejujuran dalam berinteraksi dengan orang lain.

M. Daftar Pustaka

Anjaswarni, Tri. (2016). *Komunikasi Dalam Keperawatan*. Pusdik SDM Kesehatan: Jakarta.

Antai-Otong, D. (1995). *Psychiatric Nursing, Biological and Behavioral Concepts*. W. B. Saunders Company Year Book: Philadelphia.

Arwani. (2003). *Komunikasi dalam Keperawatan*. EGC: Jakarta.

Brammer & Mc Donald. (1996). *The Helping Relationship: Process and Skills*. Ed ke-6. Allyn & Bacon: USA.

Brunner & Suddarth. (2001). *Text Book of Medical-Surgical Nursing*. Lippincott: Philadelphia.

Burnard Philip & Morrison Paul. (2009). *Caring & Communicating* alih bahasa Widyawati. Edisi 2. EGC: Jakarta.

- Christina, L.I., Untung, S., & Tatik, I. (2003). Komunikasi Kebidanan. EGC: Jakarta.
- Damaiyanti, Mukhrisah. (2010). Komunikasi Terapeutik dalam Praktik Keperawatan. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Devito, Joseph. (1997). Komunikasi Antarmanusia. Karisma Publishing Group: Tenggara Selatan.
- Freidman, L.M. (2010). Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori, Praktik (5th ed). EGC: Jakarta.
- Indrawati. (2003). Komunikasi Untuk Perawat. EGC: Jakarta.
- Intansari, Nurjannah. (2005). Komunikasi Keperawatan: Dasar-Dasar Komunikasi bagi Perawat. Moco Media: Yogyakarta.
- Keliat, Budi Anna. (1992). Hubungan Terapeutik Perawat Klien. EGC: Jakarta.
- Lestari, Sri. (2012). Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga.
- Mubarak. (2012). Ilmu Keperawatan Komunikasi, Konsep dan Aplikasi. Salemba Medika: Jakarta.
- Mulyana, Deddy. (2000). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mundakir. (2006). Komunikasi Keperawatan: Aplikasi dalam Keperawatan. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Prabowo, Tri. (2020). Komunikasi Dalam Keperawatan. Pustaka baru Press: Yogyakarta.
- Purwanto, Heri. (1994). Komunikasi Untuk Perawat. EGC: Jakarta.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2005). Psikologi Komunikasi, edisirevisi. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Stuart and Laraia. (2001). *Principle and Practice of Psyciatric Nursing*. Mosby Year Book: St. Louis.
- Stuart, G.W. & Sundeen, S.J. (1998). *Principle and Practice of Psyciatric Nursing*. Mosby Year Book: St. Louis.
- Supartini, Yupi. (2004). Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak. EGC: Jakarta.
- Suryani. (2005). Komunikasi Terapeutik: Teori & Praktek. EGC: Jakarta.

PROFIL PENULIS



Mukhoirotin, S. Kep., Ns., M. Kep. lahir di Jombang, 28 Maret 1978. Lulus Studi Program Diploma Keperawatan di AKPER Darul Ulum Jombang tahun 1998, Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Universitas Airlangga Surabaya tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2012 melanjutkan ke Program Pascasarjana Magister Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus tahun 2014.

Pada tahun 2000 sampai sekarang menjadi tenaga pendidik di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) Jombang, tahun 2007 s.d 2009 menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Keperawatan

Maternitas Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan FIK Unipdu, tahun 2010 s.d 2014 menjadi staf logistik dan Maintenance Laboratorium FIK Unipdu, tahun 2010 s.d 2012 menjadi Sekretaris Prodi Profesi Ners dan tahun 2015 sampai Agustus 2023 menjadi Sekretaris bidang Akademik Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan FIK Unipdu Jombang.

Buku yang pernah diterbitkan oleh penulis berjudul Pendidikan Kesehatan Persalinan (2017), DISMENOREA: Cara Mudah Mengatasi Nyeri Haid (2018), dan Strategi Penatalaksanaan Dismenorea Berbasis Molekuler (2024). Selain itu juga penulis telah menulis buku kolaborasi dan menulis artikel di jurnal nasional maupun internasional.

E-mail: mukhoirotin@fik.unipdu.ac.id



Habsyah Saparidah Agustina, S.Kep., Ners., M.Kep.

Lulusan Magister Keperawatan Jiwa. Turut berperan dan ikut serta dalam berbagai kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang disertai dengan kolaborasi antar institusi pendidikan dan non-pendidikan. Selain itu, berkontribusi dalam penulisan buku dan artikel serta publikasi ilmiah baik pada tingkat nasional dan internasional.



Ria Tri Harini Dwi Rusiawati, S.ST., M.Pd. Lahir di Merauke, 25 Februari 1968. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yakni jenjang S1 pada Program Studi D IV Perawat Pendidik, Universitas Airlangga tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Pendidikan Ganesha, dan lulus tahun 2009. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1991 sebagai perawat yang bertugas disalah satu Puskesmas di daerah

terpencil di Irian Jaya (sekarang Papua), tahun 1993 bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor – Irian Jaya, tahun 1999 bertugas

sebagai dosen pada Akademi Kebidanan Pemprov. Bali, dan tahun 2018 sampai sekarang bertugas sebagai dosen pada Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Mata kuliah yang penulis ampu adalah Komunikasi Keperawatan, Komunikasi Terapeutik Keperawatan, Farmakologi, Keperawatan Anak Sehat-Sakit, Psikososial dan Budaya Keperawatan, Nursing Enterpreneurship, dan beberapa mata kuliah lain. Penulis aktif melaksanakan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, sebagai penulis buku, publikasi artikel. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: riabasuki1214@gmail.com

PROFIL PENULIS



Yuliana Dafroyati, S.Kep, Ns, M.Sc. Lahir di Damer 18 Februari 19972. Lulus Akademi Keperawatan PEMDA Kupang tahun 1996, melanjutkan pendidikan Keperawatan di Universitas Airlangga Surabaya dengan perolehan gelar (S.Kep) tahun 2004 dan (Ns) pada tahun 2005. Pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada dengan peminatan Maternal Perinatal, lulus tahun 2010 dengan gelar(MSc). Riwayat pekerjaan: pada tahun 1997-2021 bekerja di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi NTT bidang program Diklat. Tahun 2021 pindah ke Poltekkes Kemenkes Kupang-sekarang dan saat ini aktif sebagai Dosen Pada Prodi Diploma Tiga Keperawatan Kupang dan juga mengajar di program Pendidikan Profesi Ners Poltekkes Kemenkes Kupang. Sebagai Dosen aktif dalam kegiatan Tri Dharma PT yaitu mengajar mata kuliah Maternitas, Dokumentasi Keperawatan, Komunikasi terapeutik dan juga Riset Keperawatan. Selain mengajar juga aktif meneliti serta publikasi dalam bentuk buku ajar, monograf, jurnal (nasional dan Internasional). Kegiatan pengabdian masyarakat aktif dalam kegiatan pendidikan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi profesi yang didukung dengan kepemilikan sertifikat sebagai pengendali pelatihan (TPP) dan sebaga tenaga pelatih kesehatan (TPK). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yulianambendon@gmail.com

Motto: **Success begins with the courage to try**



Khusana Rahma. S.Kep., M.Tr Kep. Lulusan magister terapan keperawatan Poltekkes Kemenkes Semarang. saat ini menjadi dosen tetap Universitas Bhakti Husada Indonesia di prodi S1 keperawatan dan profesi ners. Kami sudah menghasilkan Buku yang pernah diterbitkan oleh penulis dan berkolaborasi dengan dosen dosen perguruan tinggi lainnya yaitu " kesehatan reproduksi remaja dan permasalahannya" (2024), BLUEPRINT SOAL DAN RUBIK PENILAIAN OSCE PROFESI NERS(2024) .

PROFIL PENULIS



Afina Muharani Syaftriani, S.Kep., Ns., M.Kep. Penulis lahir di Singaraja, 22 Juni 1993. Ketertarikan penulis terhadap profesi perawat dimulai pada tahun 2011 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih dan menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Keperawatan di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2015 dan pendidikan profesi ners di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2016. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan S2 Magister Ilmu Keperawatan dengan peminatan Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019. Saat ini aktif sebagai Dosen Fakultas Farmasi dan Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners, Institut Kesehatan Helvetia. Penulis tergabung dalam organisasi profesi perawat, yaitu PPNI. Saat ini penulis terdaftar sebagai anggota panitia Pelatihan BTCLS Provider JMST 119 cabang Kota Medan. Rekam jejak penulisan dapat diakses melalui *Google Scholar*. Silahkan menjalin komunikasi melalui akun social media Instagram @afinalubis. Email Penulis: afinalubis@gmail.com/afinamuharanisyafttriani@helvetia.ac.id.



Nurhayati, SKM., MPH, Lahir di Bireuen, 16 Agustus 1965, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh mulai dari Akademi Keperawatan Padjadjaran Bandung Lulus pada Tahun 1986, Jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Aceh Lulus tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009 dan lulus tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1984 sebagai Perawat Kamar Bedah di RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh. Pada tahun 1986 sebagai staf Administrasi pada SPK Depkes Banda Aceh, Tahun 1993 melanjutkan pendidikan di Akper Depkes Bandung, tahun 1996 sebagai guru di SPK Depkes Banda Aceh yang selanjutnya menjadi Akbid Depkes dan menjadi Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Aceh pada tahun 2001. Pada tahun 2007 pindah ke Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Aceh. Saat ini penulis bekerja di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Aceh sebagai Dosen Homebase Prodi Sarjana Terapan Keperawatan (STr Kep), mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan, Komunikasi Terapeutik, Patofisiologi, dan Keperawatan Anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi seperti publikasi artikel, ikut seminar. Pelatihan dll. Penulis juga aktif pada organisasi PPKMI Propinsi Aceh sebagai sekretaris I, dan sebagai anggota KABA ACADEMIC SOCIETY. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nurhayati_454@yahoo.com **Motto Belajar hingga akhir hayat**

PROFIL PENULIS



Ns. Leni Wijaya.,S.Kep.,M.Kes lahir di Plaju, 14 Agustus 1977, anak ke empat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak A. Husni (alm) dan Ibu Sumardiani. Lulus 1999 dari Akademi Keperawatan Mitra Adiguna Palembang dan berlanjut pada program Strata Satu (S-1) lulus 2005, yang kemudian melanjutkan pendidikan Profesi Ners lulus 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Dua (S-2) di Universitas Sriwijaya dengan Program Studi Ilmu Biomedik jurusan Farmakologi lulus 2014.

Penulis merupakan dosen tetap di Program Studi Pendidikan Profesi Ners STIKES Mitra Adiguna. Saat ini penulis menjadi Ketua LPM STIKES Mitra Adiguna. Penulis memulai karier sejak 2000 hingga buku ini terbit, penulis masih mengajar mata kuliah Komunikasi Terapeutik Dalam Keperawatan, Farmakologi Keperawatan, Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan dan beberapa mata kuliah yang lain.

Buku yang telah diterbitkan oleh penulis diantaranya buku ajar Komunikasi Terapeutik Dalam Proses Keperawatan, Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, Keperawatan Dasar Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Handerson dan Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia Dengan Pendekatan SDKI, SLKI, dan SIKI PPNI, dan Standar Prosedur Operasional Keperawatan Dasar. Sedangkan buku hasil penelitian Pelayanan Prima Pada Lansia, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Perawat, dan Terapi Humor Dengan Media Film Komedi. Penulis dapat dihubungi melalui email: leniwijaya1408@gmail.com

Sinopsis

Buku ajar "Komunikasi Terapeutik Keperawatan" disusun sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa keperawatan, dosen, dan praktisi keperawatan dalam memahami serta menguasai keterampilan komunikasi yang bersifat terapeutik. Dalam praktik keperawatan, kemampuan berkomunikasi secara efektif, empatik, dan profesional merupakan salah satu pilar utama dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dan berpusat pada pasien.

Buku ini menguraikan secara sistematis konsep dasar komunikasi, perbedaan komunikasi terapeutik dengan komunikasi biasa, prinsip-prinsip yang melandasinya, serta tahapan dalam proses komunikasi terapeutik. Selain itu, buku ini juga membahas berbagai teknik komunikasi yang dapat diterapkan dalam situasi klinis, termasuk bagaimana menghadapi pasien dengan kondisi khusus seperti anak-anak, lansia, pasien dengan gangguan mental, maupun pasien dalam kondisi kritis.

Dengan pendekatan yang aplikatif dan berbasis pada praktik nyata di lapangan, buku ini turut memuat contoh kasus, dialog interaktif, refleksi pembelajaran, serta tips praktis yang dapat langsung digunakan oleh perawat di berbagai unit pelayanan kesehatan. Tidak hanya itu, buku ini juga mengulas hambatan-hambatan yang sering muncul dalam komunikasi terapeutik serta strategi mengatasinya secara efektif.

Disusun oleh tenaga akademik dan praktisi yang berpengalaman, buku ini diharapkan mampu menjadi sumber belajar utama dalam mata kuliah komunikasi keperawatan, sekaligus referensi penting untuk meningkatkan mutu layanan keperawatan yang lebih humanis dan bermakna. Melalui penguasaan komunikasi terapeutik, perawat dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan pasien, meningkatkan kepatuhan terapi, serta menciptakan pengalaman perawatan yang lebih positif dan menyembuhkan.

Buku ajar "Komunikasi Terapeutik Keperawatan" disusun sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa keperawatan, dosen, dan praktisi keperawatan dalam memahami serta menguasai keterampilan komunikasi yang bersifat terapeutik. Dalam praktik keperawatan, kemampuan berkomunikasi secara efektif, empatik, dan profesional merupakan salah satu pilar utama dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dan berpusat pada pasien.

Buku ini menguraikan secara sistematis konsep dasar komunikasi, perbedaan komunikasi terapeutik dengan komunikasi biasa, prinsip-prinsip yang melandasinya, serta tahapan dalam proses komunikasi terapeutik. Selain itu, buku ini juga membahas berbagai teknik komunikasi yang dapat diterapkan dalam situasi klinis, termasuk bagaimana menghadapi pasien dengan kondisi khusus seperti anak-anak, lansia, pasien dengan gangguan mental, maupun pasien dalam kondisi kritis.

Dengan pendekatan yang aplikatif dan berbasis pada praktik nyata di lapangan, buku ini turut memuat contoh kasus, dialog interaktif, refleksi pembelajaran, serta tips praktis yang dapat langsung digunakan oleh perawat di berbagai unit pelayanan kesehatan. Tidak hanya itu, buku ini juga mengulas hambatan-hambatan yang sering muncul dalam komunikasi terapeutik serta strategi mengatasinya secara efektif.

Disusun oleh tenaga akademik dan praktisi yang berpengalaman, buku ini diharapkan mampu menjadi sumber belajar utama dalam mata kuliah komunikasi keperawatan, sekaligus referensi penting untuk meningkatkan mutu layanan keperawatan yang lebih humanis dan bermakna. Melalui penguasaan komunikasi terapeutik, perawat dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan pasien, meningkatkan kepatuhan terapi, serta menciptakan pengalaman perawatan yang lebih positif dan menyembuhkan.

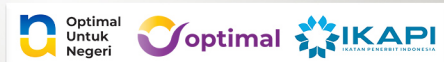
Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-10-9569-5



9

786231

095695